



UTPL

La Universidad Católica de Loja

Modalidad Abierta y a Distancia

Prácticum 2

Guía didáctica





Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Humanidades

Departamento de Psicología

Prácticum 2

Guía didáctica

Carrera	PAO Nivel
▪ Psicología	V

Autores:

Patricia Sofía Faggioni Luna
Vanessa Romina Pineda Rojas



Asesoría virtual
www.utpl.edu.ec





Universidad Técnica Particular de Loja

Prácticum 2

Guía didáctica

Patricia Sofía Faggioni Luna

Vanessa Romina Pineda Rojas

Diagramación y diseño digital:

Ediloja Cía. Ltda.

Telefax: 593-7-2611418.

San Cayetano Alto s/n.

www.ediloja.com.ec

edilocialtda@ediloja.com.ec

Loja-Ecuador

ISBN digital - 978-9942-39-910-6



Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

Usted acepta y acuerda estar obligado por los términos y condiciones de esta Licencia, por lo que, si existe el incumplimiento de algunas de estas condiciones, no se autoriza el uso de ningún contenido.

Los contenidos de este trabajo están sujetos a una licencia internacional Creative Commons **Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)**. Usted es libre de **Compartir** — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. **Adaptar** — remezclar, transformar y construir a partir del material citando la fuente, bajo los siguientes términos: **Reconocimiento-** debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. **No Comercial-** no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. **Compartir igual-** Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original. No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

05 octubre, 2023



Índice

1. Datos de información.....	7
1.1. Presentación de la asignatura.....	7
1.2. Competencias genéricas de la UTPL.....	7
1.3. Competencias específicas de la carrera.....	7
1.4. Problemática que aborda la asignatura.....	8
2. Metodología de aprendizaje.....	9
3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje.....	10
Resultado de aprendizaje 1 y 2	10
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje	10
Semana 1	10
Unidad 1. Herramientas de evaluación psicológica	11
1.1. Evaluación psicológica	11
1.2. Breve reseña histórica.....	13
1.3. Responsabilidad y principios éticos durante la evaluación psicológica.....	14
1.4. Herramientas de recogida de información	16
Actividades de aprendizaje recomendadas	18
Autoevaluación 1.....	20
Semana 2	22
Unidad 2. Diagnóstico psicológico individual y contextual	22
2.1. Diagnóstico psicológico	22
2.2. Proceso para llegar a un diagnóstico psicológico	24
2.3. Sistemas o manuales de diagnóstico psicológico	25
2.4. Técnicas para identificar problemas y llegar a un diagnóstico.....	25
Actividades de aprendizaje recomendadas	27
Autoevaluación 2.....	28
Semana 3	30
Unidad 3. Diseño de herramientas de recogida de información para el proceso de evaluación y diagnóstico psicológico	30
3.1. Entrevista psicológica.....	30

Índice



3.2. Entrevista con informantes.....	35
3.3. Fichas de observación	36
Actividades de aprendizaje recomendadas	38
Autoevaluación 3.....	40
Semana 4	43
3.4. Cuestionarios, inventarios y escalas.....	43
Actividad de aprendizaje recomendada	47
Semana 5	48
Unidad 4. Formulación de Hipótesis y deducción de enunciados verificables	48
4.1. Formulación de hipótesis	48
Actividades de aprendizaje recomendadas	52
Semana 6	53
4.2. Deducción de enunciados verificables	54
Actividades de aprendizaje recomendadas	56
Semana 7	57
Unidad 5. Herramientas de recogida de información.....	57
5.1. Lista de cotejo y escalas de apreciación.....	58
Actividades de aprendizaje recomendadas	64
Autoevaluación 4	66
Semana 8	68
Actividad de aprendizaje recomendada	68
Semana 9	69
Unidad 6. Entrenamiento en escenarios simulados, técnicas psicométricas. Entrenamiento en escenarios simulados, técnicas objetivas y proyectivas.....	69
6.1. Test psicológicos	69
Actividades de aprendizaje recomendadas	80



Semana 10	81
6.2. Técnicas psicométricas objetivas.....	81
6.3. Técnicas proyectivas.....	85
6.4. Evaluación psicológica en entornos simulados.....	93
Actividades de aprendizaje recomendadas	95
Autoevaluación 5.....	97
Semana 11	100
Unidad 7. Diseño de propuestas y programas de intervención psicológica ..	100
7.1. Propuestas de intervención psicológica.....	100
Actividades de aprendizaje recomendadas	104
Semana 12	106
7.2. Diseño de una propuesta de intervención psicológica	106
Actividades de aprendizaje recomendadas	109
Semana 13	111
7.3. Fases para la elaboración de programas o proyectos de intervención psicológica	111
Actividades de aprendizaje recomendadas	113
Semana 14	114
7.4. Recursos y técnicas de intervención primaria.....	114
Actividades de aprendizaje recomendadas	118
Semana 15	119
7.5. Evaluación de programas de promoción y prevención de la salud..	119
Actividades de aprendizaje recomendadas	122
Autoevaluación 6.....	123
Semana 16	125
4. Solucionario	128
5. Referencias bibliográficas	136
6. Anexos	139





1. Datos de información

1.1. Presentación de la asignatura



1.2. Competencias genéricas de la UTPL

- Comunicación oral y escrita.
- Pensamiento crítico y reflexivo.
- Trabajo en equipo.
- Comunicación en inglés.
- Comportamiento ético.
- Organización y planificación del tiempo.

1.3. Competencias específicas de la carrera

- Evalúa diferencias, problemas y necesidades a nivel individual, grupal, intergrupal y social (organizacionales e interorganizacionales), enfocándose en los problemas que se evidencien en los grupos de atención prioritaria y vulnerable.



- Diagnostica diferencias, problemas y necesidades a nivel individual, grupal, intergrupal y social (organizacionales e interorganizacionales), enfocándose en los problemas que se evidencien en los grupos de atención prioritaria y vulnerable.
- Interviene mediante propuestas de prevención y promoción la salud mental para mejorar la calidad de vida de la colectividad, proponiendo estrategias de intervención psicológica a nivel local, regional y nacional.

1.4. Problemática que aborda la asignatura

La presente asignatura Prácticum 2 tiene la finalidad de contribuir al conocimiento, diseño y aplicación de herramientas de recogida de información útiles en el proceso de evaluación y diagnóstico psicológico, así como a la elaboración de informes que se obtienen a partir de los resultados de estos instrumentos; lo cual permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos de manera teórica hasta esta etapa de su formación. Por otro parte, el abordaje de esta asignatura pretende favorecer a la falta de conocimiento sobre los modelos y programas de intervención psicológica en escenarios de práctica, aproximando aún más al ejercicio profesional en diferentes contextos de actuación del psicólogo.

Por ello, esta asignatura tiene el propósito de reconocer la importancia de las herramientas de recogida de información, dentro de los procesos de evaluación psicológica, así como el diseño y elaboración de las mismas, lo cual ayudará a dar respuesta a las problemáticas psicosociales y comunitarias en escenarios reales; y así, formar profesionales con suficientes competencias para evaluar y diagnosticar situaciones y necesidades a nivel individual, grupal, intergrupal y social, enfocándose en los problemas que se evidencien en los grupos de atención prioritaria y vulnerable.





2. Metodología de aprendizaje

En la presente asignatura se utilizará la metodología TPACK (*Technological Pedagogical Content Knowledge*) la misma que permite integrar de manera holística y equilibrada el uso de las herramientas digitales, que promueven el rol activo del estudiante facilitando el desarrollo de las habilidades y la asimilación del conocimiento; considerando el contenido y las estrategias pedagógicas. Además, se implementará la metodología de estudio de casos clínicos que implica el análisis detallado de situaciones reales para comprender mejor los conceptos y principios relevantes de la psicología, lo que permite desarrollar habilidades de diagnóstico y razonamiento clínico. De esta manera, el estudiante potenciará un aprendizaje teórico-práctico, a través de clases colaborativas – autónomas y extra clases, tutorías presenciales y virtuales, experimentación en laboratorios psicológicos especializados; todo ello con la finalidad de brindar la oportunidad al estudiante para que construya un conocimiento integral, proponga soluciones reales y viables de las necesidades a nivel individual, grupal y social donde se desenvuelve el psicólogo.





3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje

Resultado de aprendizaje 1 y 2

- Comprende la importancia de las herramientas de recogida de información, dentro de los procesos de evaluación psicológica.
- Diseña y elabora herramientas de recogida de información que le ayudarán a dar respuesta a las problemáticas psicosociales y comunitarias en escenarios simulados.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje



Semana 1

Estimados estudiantes, les invitamos a dar inicio a esta asignatura, la cual les permitirá reconocer, diseñar y poner en práctica las herramientas de recogida de información dentro del contexto de la evaluación y diagnóstico psicológico; así como el diseño de modelos y programas de intervención primaria, mediante estudios de casos en escenarios reales que le permitirán abordar problemáticas psicosociales y comunitarias en grupos de atención prioritaria y vulnerable.

Es necesario indicar que la planificación de esta asignatura de Prácticum 2 está desarrollada para todo el ciclo académico ordinario, es decir, que no se encuentra organizado por bimestres, por ello, en el transcurso de las 16 semanas encontrará actividades de aprendizaje calificadas y recomendadas que deberá cumplirlas en las fechas establecidas, así como recursos externos que le permitirán ahondar en cada tema.

¡Les invitamos a iniciar!



Unidad 1. Herramientas de evaluación psicológica

Esta primera semana iniciaremos abordando los fundamentos de la evaluación psicológica, siendo relevante facilitar los aprendizajes en el ámbito de la evaluación, lo cual permitirá adquirir competencias evaluativas. La unidad 1. Herramientas de evaluación psicológica trata los conceptos básicos, modelos y procesos de evaluación psicológica, junto a una breve reseña histórica, los contenidos se encuentran disponibles en el capítulo 1 del **texto básico** (Fernández-Ballesteros, 2013).

1.1. Evaluación psicológica

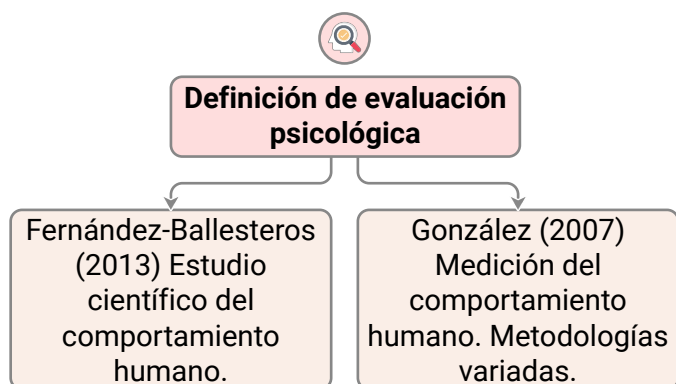
La evaluación psicológica es una disciplina de la psicología, encargada del estudio científico del comportamiento humano con el propósito de describir, clasificar, predecir, explicar y, en ciertos casos, controlar dicho comportamiento; es decir, se encuentra involucrada en recopilar información y generar conclusiones sobre los rasgos, habilidades, capacidades, funcionamiento emocional y problemas psicológicos del individuo, siendo empleada para obtener un diagnóstico específico (Fernández-Ballesteros (2013).

Es fundamental tener en claro la comprensión sobre el concepto de evaluación psicológica, ya que la palabra “evaluación” hace referencia al examen o exploración de personas, e implica juicios de bondad referidos a objetos como los puestos de trabajo, tratamientos, programas. En la siguiente figura usted podrá comprender con más detalle la definición:



Figura 1.

Definición de evaluación psicológica



Nota. Adaptado de Evaluación psicológica [Ilustración], por Fernández-Ballesteros R., 2013, Ediciones Pirámide.

Por otro lado, González (2007) amplía la descripción destacando que la evaluación psicológica abarca la medición de diversos aspectos del comportamiento humano, mediante metodologías como: técnicas psicométricas, proyectivas, observación, entrevistas y autoinformes. A su vez, plantea que la evaluación psicológica persigue objetivos como: describir, clasificar, predecir y controlar el comportamiento del individuo; es decir, describir involucra conocer características de su personalidad, clasificar consiste en ubicar al individuo en una categoría específica, predecir se refiere a anticipar su comportamiento futuro, y controlar supone evaluar y comparar posibles cambios en su comportamiento a lo largo del tiempo.

Para mayor información de los objetivos de la evaluación psicológica le invitamos a examinar la descripción de cada uno de ellos que se presenta a continuación.

Objetivos de la evaluación psicológica

La evaluación psicológica persigue objetivos como: (Fernández-Ballesteros, 2013).

- **Describir:** involucra conocer características de la personalidad del individuo (González, 2007).
- **Clasificar:** consiste en ubicar al individuo en una categoría específica, (González, 2007).

- **Predecir:** se refiere a anticipar su comportamiento futuro.
- **Controlar:** supone evaluar y comparar posibles cambios en su comportamiento a lo largo del tiempo (González, 2007).

En consonancia con los objetivos establecidos, es evidente que la evaluación psicológica es un proceso en donde el experto en salud mental explora a un individuo tomando en consideración aspectos psicológicos, físicos y sociales que pueden ejercer mayor influencia en su funcionamiento y bienestar (González, 2007).

Posterior a adquirir el conocimiento general sobre la evaluación psicológica, resulta fundamental efectuar un breve repaso sobre los autores más importantes y los acontecimientos históricos que han sido trascendentales en el desarrollo de la evaluación psicológica.

1.2. Breve reseña histórica

La evaluación psicológica es una subdisciplina de la psicología, la cual transcurre históricamente a finales del siglo XIX, entre los autores más relevantes relativos a la constitución de la evaluación psicológica se encuentran Francis Galton, McKeen Cattell y Alfred Binet (Fernández-Ballesteros, 2013).

Para un análisis más pormenorizado del tema, a continuación le presentamos una infografía sobre la [historia de la evaluación psicológica](#), en la cual podrá conocer las aportaciones más importantes en esta disciplina.

En función del aporte de cada uno de los pioneros de la evaluación psicológica entre 1910 a 1974, Fernández-Ballesteros (2013) concluye que es una disciplina que realiza el análisis de la individualidad a través de la evaluación de las características sensoriales, perceptivas y motoras de cada persona.

Antes de adentrarnos en el análisis de las herramientas para recolectar información y su aplicación en el ejercicio profesional del psicólogo, es fundamental abordar con entusiasmo significativo un tema relevante en el proceso de evaluación psicológica, como es la responsabilidad y principios éticos durante la evaluación psicológica.



1.3. Responsabilidad y principios éticos durante la evaluación psicológica

Es relevante destacar que la ética profesional se encuentra relacionada con la moral y se refiere a los principios y normas que guían la conducta de los profesionales de una especialidad. De tal forma, González (2007) manifiesta que, aunque los profesionales resuelven cuestiones éticas basándose en su moral individual, existen situaciones en las que una acción puede afectar los derechos de las personas y trasciende el ámbito de la moral personal; de tal manera, se han implementado códigos de ética que regulan el trabajo de profesionales y estudiantes en cualquier profesión e institución.

Por otra parte, Paz y Peña (2021) refieren de la “mala práctica profesional” misma que hace alusión a tres aspectos principales:

- *Imprudencia*: empleo de procedimientos por parte del evaluador o profesional que derivan en resultados dudosos.
- *Negligencia*: utilización de procedimientos de evaluación con descuido.
- *Impericia*: uso de procedimientos de forma inexacta e incompetente por desconocimiento o falta de entrenamiento del profesional o evaluador.

De la misma manera, dentro del proceso de evaluación, como en cualquier actividad que ejecute el profesional, debe considerarse la deontológica en psicología, misma que se basa en tres principios éticos:

- *Beneficencia*: deber de no dañar a la persona y procurar hacer el bien.
- *Autonomía*: respeto por las normas y decisiones ajenas que no perjudiquen a otros.
- *Justicia*: mostrar igual consideración (ofrecer las mismas oportunidades y evitar la discriminación por causa alguna) por todos los seres humanos.

Finalmente, esos principios se operativizan a través de tres normas éticas que se detallan a continuación:



- *Fidelidad*: cumplimiento de los compromisos adquiridos la persona evaluada o paciente en particular.
- *Veracidad*: proporcionar al evaluado o paciente la información respectiva y evitar incurrir en mentiras.
- *Confidencialidad*: esta norma no es un deber absoluto, su cumplimiento se refleja siempre que no atente contra el bien del sujeto evaluado y los de terceras personas (Paz y Peña, 2021, pp. 85,87).

En el ámbito de la psicología, la ética profesional incluye no solo principios intrínsecos de la profesión, sino también el trato y la comunicación con los pacientes y sus familias; de tal forma que establecer un buen rapport y un ambiente de confianza con los pacientes juega un papel crucial favoreciendo el bienestar psicológico y la satisfacción laboral del profesional (Casullo, 2009).

Con relación a la importancia del ejercicio profesional sobre la ética en la evaluación psicológica, se recomienda ampliar su conocimiento sobre este proceso.



Por lo cual, le invitamos a revisar el artículo científico titulado “[La evaluación psicológica: modelos, técnicas y contextos](#)”, aquí encontrará una explicación minuciosa sobre la evaluación psicológica, especialmente las técnicas relevantes para recopilar información del caso en estudio.

Una vez leído el artículo, usted comprenderá que es necesario conocer las técnicas para recopilar información de una forma profesional. Por ello, con la finalidad de realizar un análisis de la lectura, le motivamos a responder las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el proceso de la evaluación psicológica?
2. Después de comprender este proceso, ¿cuáles son las técnicas que permiten la recolección de información en el proceso de evaluación y diagnóstico?

Al responder estas interrogantes, se podrá obtener una visión completa sobre las técnicas empleadas en la evaluación psicológica y cómo se



lleva a cabo este proceso para obtener información relevante y precisa, de esta manera a continuación se detalla las herramientas de recogida de información que han de ser seleccionadas en momentos concretos.

1.4. Herramientas de recogida de información

El proceso de evaluación psicológica se desarrolla en cuatro fases básicas, la primera recogida de información, la segunda formulación de hipótesis y deducción de enunciados contrastables, la tercera la contrastación y la cuarta la comunicación de resultados, o como se lo denomina el informe psicológico oral y/o escrito. Estas cuatro fases engloban todos los pasos que el evaluador realiza cuando la demanda es el diagnóstico, orientación o selección (Fernández-Ballesteros, 2013).

En el módulo didáctico, revise con detenimiento las cuatro [fases de evaluación psicológica](#); sin embargo, es necesario considerar que antes del inicio de cada fase se contará con la demanda planteada bien por el propio sujeto, bien por una tercera persona que se convierte en cliente de la evaluación; lo importante es contener una petición más o menos precisa del sujeto/cliente que el evaluador debe clarificar.

Luego de haber revisado las fases básicas de la evaluación psicológica, debe tomar en cuenta que los profesionales emplean diversas técnicas o herramientas de información, que permiten proporcionar información y datos sobre una problemática o situación. En este sentido, el evaluador debe conocer los principios o normas al emplear determinada técnica. Si bien, los procedimientos de recogida de información no se limitan al empleo de *tests* o técnicas estándar de medida, en muchas ocasiones el evaluador debe realizar observaciones, recoger informes (del sujeto o sus allegados) o respuestas psicofisiológicas mediante técnicas no estandarizadas que han de ajustarse al caso particular de que se aborde (Fernández-Ballesteros, 2013; Paz y Peña, 2021).

Con la finalidad de conocer con más detalle sobre las fases de la evaluación psicológica, procedemos a mencionar la primera fase.



1.4.1. Fase 1. Primera recogida de información

Como lo describe Fernández-Ballesteros (2013), al abordar una evaluación psicológica, el evaluador actúa como un observador participante y recolector de información sobre el caso con las siguientes características:

- La recogida de datos se centra en dos aspectos: especificar la demanda y establecer las condiciones históricas y actuales relevantes (biológicas, sociales y ambientales).
- Clarificar la demanda y determinar objetivos concretos en la evaluación psicológica, lo cual puede ser difícil cuando el sujeto/cliente no tiene claro lo que desea.
- El evaluador debe ayudar a transformar planteamientos vagos en términos concretos para definir objetivos específicos.
- La demanda debe incluir preguntas sobre el motivo de la consulta, el objetivo de la evaluación y qué se desea lograr con ella.
- Aspectos éticos, como la licitud y la capacitación del psicólogo para abordarla, deben ser considerados después de especificar la demanda.
- Informar al cliente/sujeto sobre el proceso de evaluación, las técnicas que se utilizarán y la confidencialidad de la información obtenida.
- Se establece un acuerdo formal entre el evaluador y el cliente/sujeto que especifica las obligaciones mutuas y describe el trabajo evaluativo.

En resumen, la recogida de información está centrada en conductas problema, variables independientes, presentes en las hipótesis intervenidas, datos relativos a la administración del tratamiento y cambios positivos o negativos producidos por el tratamiento.

De tal forma, la selección de las herramientas de recopilación de información en el proceso de evaluación y diagnóstico psicológico se fundamenta en varios criterios, con el objetivo de obtener datos descriptivos y relevantes. Según Muñoz (2010), estos criterios pueden ser clasificados en tres categorías principales, como se detalla a continuación:



1. Criterios económicos

Equilibrio entre costes y beneficios (Muñoz, 2010).

2. Criterios de calidad

- Fiabilidad.
- Validez.
- Homogeneidad.
- Normativización (Muñoz, 2010).

3. Criterios de utilidad

- Función en relación con el problema.
- Tipo de información facilitada.
- Interés en el caso.
- Informante.
- Aspectos abordados.
- Entrenamiento del evaluador (Muñoz, 2010).

Como se ha podido apreciar, el proceso de la evaluación psicológica en la primera fase, considera que los criterios son una aplicación del método científico, siendo clave la recogida de información para posteriormente generar y contrastar hipótesis durante la evaluación.

Finalmente, para conocer con mayor detalle la información con respecto a la unidad 1. Herramientas de evaluación psicológica, es necesario que revise el contenido del capítulo 1 del **texto básico**: capítulo 1. Conceptos y modelos básicos y capítulo 2. El proceso como procedimiento científico y sus variantes. Una vez que ha revisado estos contenidos y en los recursos interactivos de esta semana, podrá resolver la siguiente actividad recomendada; la misma que no será calificada, pero servirá como un recurso para profundizar los contenidos.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Con el fin de mejorar la comprensión de los temas antes expuestos, desarrolle las siguientes actividades, con la finalidad de ahondar en los conocimientos y pueda adquirir competencias requeridas en esta asignatura:



1. Analice criterios para la aplicación de herramientas de recogida de información.

Procedimiento:

- Revise con detenimiento la unidad 1. Herramientas de evaluación psicológica, en el **texto básico**.
- Identifique y enumere los criterios relevantes al aplicar herramientas de recogida de información en el proceso de evaluación psicológica.
- Elabore un cuadro para describir cada criterio y su importancia en la evaluación. Posterior, proporcionar ejemplos prácticos sobre la aplicación de cada criterio en diferentes contextos psicológicos.

Nota: por favor complete las actividades en un cuaderno de apuntes o documento Word.

2. Realice la siguiente autoevaluación para comprobar sus conocimientos.





Autoevaluación 1

1. Complete: se entiende como evaluación psicológica a: _____
 - a. Es un proceso de recopilación de datos sobre el comportamiento humano.
 - b. Un proceso de diagnóstico médico.
 - c. Un proceso de tratamiento psicológico.
2. Seleccione, ¿cuál es uno de los objetivos de la evaluación psicológica?
 - a. Determinar costos de los servicios de un psicólogo.
 - b. Predecir el futuro comportamiento del individuo/cliente.
 - c. Evaluar la eficacia de los medicamentos psicotrópicos.
3. () Seleccione verdadero o falso: la fiabilidad en la evaluación psicológica es la capacidad de una prueba para medir de manera consistente lo que se supone que mide.
4. Seleccione cuál de las siguientes es una herramienta de recogida de información en la evaluación psicológica.
 - a. Escáner cerebral.
 - b. Entrevista clínica.
 - c. Electrocardiograma.
5. Complete: el objetivo de la evaluación psicológica es: _____
 - a. Identificar las características de personalidad de un sujeto.
 - b. Predecir el futuro comportamiento de un individuo.
 - c. Explorar características actuales para comparar cambios posteriores.
6. () Seleccione verdadero o falso: la validez en la evaluación psicológica es la capacidad de una prueba para medir lo que se supone que debe medir.



7. Seleccione de los siguientes criterios, ¿cuál se refiere a mantener un equilibrio entre los costos y beneficios de las pruebas psicológicas?
- Criterios de utilidad.
 - Criterios de calidad.
 - Criterios económicos.
8. Complete, ¿cuál es uno de los criterios de utilidad al seleccionar una técnica de evaluación psicológica? _____
- Fiabilidad de la prueba.
 - Validez de la prueba.
 - Uso según el caso en particular.
9. Identifique uno de los objetivos de la evaluación psicológica que permite predecir:
- Controlar características actuales para comparar cambios posteriores.
 - Describir las características de personalidad de un sujeto.
 - Estimar el futuro comportamiento de un individuo.
10. Seleccione: ¿cuál de las siguientes categorías de criterios se refiere a asegurarse de la calidad de cada técnica utilizada? _____
- Criterios de utilidad.
 - Criterios de calidad.
 - Criterios económicos.

[Ir al solucionario](#)





Retroalimentación:

La relación terapéutica debe entenderse en el conjunto del proceso de la evaluación psicológica, con la finalidad de que cada caso clínico sea elaborado con sutileza, congruencia y siempre respetando el estilo del terapeuta.

Le recordamos que, al iniciar esta asignatura, usted podrá ir efectuando los conocimientos adquiridos con la práctica, por lo que le invitamos a revisar el [anexo 1](#). Actividades potenciales dentro del centro de prácticas, este anexo enumera y describe las diferentes actividades que los participantes pueden llevar a cabo durante su tiempo en el centro de prácticas. Incluye tareas específicas, y responsabilidades que se espera que realicen en dicho espacio.



Semana 2

Unidad 2. Diagnóstico psicológico individual y contextual

Estimado estudiante, como hemos visto en la semana anterior, es primordial realizar adecuadamente el proceso de la evaluación psicológica y luego de conocer las bases de la evaluación, la historia y las cuatro fases básicas para el desarrollo de la evaluación, por tanto, es momento de conocer cómo se desarrolla el diagnóstico psicológico.

En la presente semana iniciaremos enfocándonos en los contenidos de la unidad 2. Diagnóstico psicológico individual y contextual, disponible en el capítulo 3 en el texto de Muñoz (2010).

¡Iniciemos!

2.1. Diagnóstico psicológico

Según Muñoz (2010), el diagnóstico psicológico es parte del proceso integral de la evaluación psicológica; a medida que se identifica y describe las principales problemáticas, su inicio y el desarrollo, se recopila información relevante con el fin de llevar a cabo un diagnóstico que será una base fundamental para el tratamiento. De tal forma, el diagnóstico se



considera un eje fundamental en la evaluación psicológica y contribuye a la comprensión y abordaje de los problemas identificados.

Además, el diagnóstico es un proceso en el cual se construye el conocimiento sobre un objeto o situación en la que se va a intervenir o actuar. Cualquier especialista o profesional que tenga la tarea de influir, orientar, ayudar o tratar algo, necesita tener al menos un conocimiento de los síntomas o manifestaciones externas que presenta el objeto o situación en cuestión, es decir, una intervención efectiva debe dirigirse a eliminar las causas y no limitarse a tratar únicamente los síntomas externos.

Para llegar a un diagnóstico, luego de haber culminado la fase 1. Recolección de datos, y alcanzado a recabar los contextos relevantes del individuo, van a permitir pasar a la segunda fase de la evaluación psicológica.

2.1.1. Fase 2. Formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables

En función de las observaciones e informaciones recibidas del caso, se empieza a plantear supuestos verificables, los cuales supone dos momentos básicos: primero la formulación de hipótesis y segundo la deducción de enunciados verificables, en este caso se refiere a decidir con qué instrumentos va a operacionalizarse cada una de las variables presente en cada una de las hipótesis formuladas (Fernández-Ballesteros, 2013).

Para formular las hipótesis serán fundamentales dos aspectos, la fiabilidad y validez de los datos recogidos sobre el sujeto y sus circunstancias y la amplitud de los conocimientos que el evaluador tenga sobre las funciones psicológicas.

2.1.2. Fase 3. Contratación: administración de test y otras técnicas de evaluación

La sucesión de esta fase se realiza en tres pasos, la preparación y planificación de los instrumentos a utilizar; la administración de los tests y técnicas seleccionados a través de los procedimientos establecidos, las cuales deberán ser aplicadas a través de una metodología prevista, específica al caso; posteriormente, una vez realizada la aplicación y comprobada la calidad de los datos obtenidos, serán ponderados y convertidos en algunos casos en puntuaciones normalizadas.



Finalmente, el análisis de los resultados en orden a la comprobación de las hipótesis, los cuales son un conjunto de datos procedentes de los distintos instrumentos aplicados, tanto a nivel cualitativo y cuantitativo, lo cual permite comprobar si los supuestos han sido contrastados o no (Fernández-Ballesteros, 2013).

2.2. Proceso para llegar a un diagnóstico psicológico

Desde la perspectiva de Fernández-Ballesteros (2013), para obtener un diagnóstico en cualquier ámbito o contexto es relevante fundamentarse en la utilización exhaustiva de toda la información, tanto personal como contextual. Dicha información debe abarcar diversos aspectos considerados en la elaboración del diagnóstico.

Le invitamos a explorar el siguiente módulo didáctico que ofrece una comprensión detallada del [proceso para llegar a un diagnóstico psicológico](#). Esto incluye la recopilación de información sobre los síntomas del paciente, su evaluación en relación con los criterios de diagnóstico, la formulación del diagnóstico y la comprensión de la evolución del problema del paciente. También destaca la importancia de analizar la historia del paciente, su entorno y los factores que pueden influir en su estado psicológico actual, siguiendo la propuesta de Fernández-Ballesteros (2013) de tres niveles en el diagnóstico psicológico.

De esta forma, se define el diagnóstico como parte integral del proceso completo de evaluación psicológica, es decir, la evaluación y el diagnóstico se encuentran relacionadas y el diagnóstico se puede considerar una de las tareas y oportunidades dentro de este proceso (Muñoz, 2010).

Estimado estudiante, tome en cuenta que un diagnóstico y una intervención efectiva no se encuentran limitados a enumerar los síntomas superficiales, sino que buscan descubrir las causas subyacentes y elaborar explicaciones del porqué de estos síntomas.



2.3. Sistemas o manuales de diagnóstico psicológico

El futuro de la evaluación psicológica y del diagnóstico psicológico podría presentar avances significativos, de tal forma Muñoz (2010) recalca que la importancia de la información recopilada en el proceso de evaluación psicológica, obtenida mediante diversos momentos, técnicas e informadores, y su interpretación mediante análisis funcionales y formulación del caso, se deben contrastar mediante los criterios diagnósticos de cualquier clasificación, ya sea mediante el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) o la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10.

Es por ello, que para ampliar la información de lo mencionado, le sugiero revisar el artículo: [DSM-5-TR: antecedentes históricos y descripción general de los principales cambios](#), en este artículo científico encontrará información sobre los antecedentes históricos de los cambios que ha experimentado el Manual Diagnóstico DSM-V (Rivera y Álvarez-Alatorre, 2022).

Posterior a familiarizarse con los diferentes manuales de diagnóstico, es necesario explorar metodologías y técnicas utilizadas para identificar los problemas y llegar a un diagnóstico.

2.4. Técnicas para identificar problemas y llegar a un diagnóstico

Antes de mencionar las múltiples clasificaciones propuestas para las técnicas, es necesario identificar ciertas consideraciones sobre el propio concepto de “técnica”; a lo largo de la historia, se han empleado varias expresiones para referirse a las técnicas, entre ellas: instrumento, test, prueba, medida, estrategias de exploración y procedimientos de recogida de información. Sin embargo, las más ampliamente utilizadas son “instrumento” y “técnica” (Muñoz, 2010).

Según Fernández-Ballesteros (2013), la evaluación siempre implica el uso de un procedimiento de observación, por lo cual se evidencia una clasificación basada en tres niveles: el sujeto que observa (observador externo o autoobservación), el lugar de observación (natural o artificial) y el tiempo en que se realiza la observación (actual o pasado). A su vez, se describe



las diversas formas de observar, también conocidas como técnicas de evaluación.

En la siguiente infografía le invitamos a conocer sobre las [técnicas para el diagnóstico psicológico](#), las mismas que se pueden utilizar para la recolección de información, dado que, dependiendo del caso, algunas técnicas serán utilizados al inicio de la evaluación y otras servirán más adelante a la hora de valorar la intervención aplicada.

En esta misma línea, Fernández-Ballesteros (2013) señala que las diversas herramientas de recogida de información se consideran como la espina dorsal de la evaluación, las cuales influyen en las decisiones finales referidas al diagnóstico, orientación, selección o tratamiento del caso. Por su parte, Paz y Peña (2021) refieren la utilidad de diversas técnicas de recogida de información:

- *Entrevista*: permite recoger los autoinformes del sujeto e informaciones de personas allegadas a él.
- *Técnicas de autoinforme*: se emplean para realizar una autoobservación del sujeto de sus tres niveles de conducta (motor, cognitivo, psicofisiológico).
- *Técnicas subjetivas*: permiten la calificación o clasificación según atributos o descripciones verbales que el sujeto realiza sobre sí mismo u otras personas u objetos, o bien que otros realizan sobre él.
- *Técnicas proyectivas*: son utilizadas para recoger muestras de la conducta verbal, gráfica o constructiva del sujeto con el fin de analizar su mundo cognitivo y afectivo.
- *Técnicas objetivas*: permiten la observación y el registro objetivo del comportamiento manifiesto o encubierto (pp. 95-96).





Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación:

1. Explique, ¿cuál es el proceso para obtener un diagnóstico psicológico?, e ilustre cada paso mediante un ejemplo.

Procedimiento:

- Realice una lectura comprensiva de la unidad 2. Diagnóstico psicológico individual y contextual, prestando atención al apartado en donde se describe el proceso para alcanzar un diagnóstico psicológico.
- Identifique y enumere los pasos necesarios para lograr un diagnóstico psicológico adecuado.
- Por último, elabore un ejemplo concreto que ilustre cada uno de los pasos del proceso de diagnóstico psicológico, con el fin de mejorar la comprensión y la aplicación práctica.

Nota: por favor complete las actividades en un cuaderno de apuntes o documento Word.

2. Realice la siguiente autoevaluación para comprobar sus conocimientos.



El diagnóstico psicológico es un proceso en el cual se van identificando y describiendo los principales problemas que aqueja un sujeto, por tanto, el diagnóstico es bidireccional y se concentra en la elaboración minuciosa de un apropiado análisis de los comportamientos y conductas del individuo.





Autoevaluación 2

1. Complete: el proceso por el cual se determina si los problemas que afectan a una persona cumplen todos los criterios de un trastorno psicológico definidos en una clasificación se denomina: _____
 - a. Diagnóstico.
 - b. Tratamiento.
 - c. Evaluación.
2. Seleccione: los manuales de diagnóstico psicológico que se utilizan en la actualidad son:
 - a. CIE 9 y DSM-V.
 - b. CIE 10 y DSM-V.
 - c. CIE 11 y DSM-V.
3. () Seleccione verdadero o falso: el tipo de diagnóstico que pretende determinar causas se denomina diagnóstico específico.
4. Complete: posterior a la recogida de información relacionada con sintomatología del paciente es necesario: _____
 - a. Aplicar los instrumentos psicológicos.
 - b. Establecer el diagnóstico definitivo.
 - a. Comprende los síntomas de forma clara.
5. Seleccione: el DSM a lo largo del tiempo ha sufrido diferentes cambios significativos a nivel de criterios y supresión de otros diagnósticos. Seleccione la opción que corresponde a la última edición:
 - a. DSM-IV.
 - b. DSM-V.
 - c. DSM-IV-TR.



6. Complete: el proceso de observación contiene los siguientes elementos: _____
- a. Lugar de la observación y sujeto que observa.
 - b. Sujeto que observa.
 - c. Observador, lugar y tiempo de observación.
7. Seleccione: las técnicas que permiten la recogida de información sobre eventos psicológicos observables se denominan:
- a. Técnicas proyectivas.
 - b. Técnicas objetivas.
 - c. Entrevista.
8. Seleccione: el lugar de observación puede ser:
- a. En un ambiente natural y artificial.
 - b. Únicamente en el ambiente natural.
 - c. Únicamente en un ambiente artificial.
9. Complete: los elementos para llegar a un diagnóstico son: _____
- a. Listado de comportamiento, material de entrevistas, historia personal, familiar, laboral, resultados de pruebas, criterios diagnósticos.
 - b. Listado de comportamiento, material de entrevistas.
 - c. Resultados de pruebas, criterios diagnósticos.
10. () Seleccione verdadero o falso: los tres niveles de diagnóstico que se llevan a cabo son: diagnóstico general, específico y diagnóstico en el proceso de tratamiento.

[Ir al solucionario](#)

¡Felicitaciones! Ha concluido con la evaluación





Unidad 3. Diseño de herramientas de recogida de información para el proceso de evaluación y diagnóstico psicológico

Estimado estudiante, como hemos observado en semanas anteriores, es imprescindible conocer el proceso para elaborar un diagnóstico psicológico, el cual se basa en un método científico, el mismo que permite realizar con criterios profesionales un adecuado diagnóstico. Por tal razón, es momento de conocer el diseño de herramientas de recogida de información.

En esta semana los contenidos de la unidad 3. Diseño de herramientas de recogida de información para el proceso de evaluación y diagnóstico psicológico, los encuentra disponibles en el capítulo 5, en el texto de Paz Guerra & Peña Herrera (2021).

¡Empecemos!

3.1. Entrevista psicológica

La entrevista clínica va más allá de ayudar a las personas a hablar de sí mismas, en el campo de la salud mental, pedimos a los pacientes que revelen sus emociones y vida personal. A través de la experiencia, aprendemos cómo obtener la información necesaria para ayudar al paciente, es una habilidad esencial, ya que se considera la más importante entre los profesionales de la salud mental, dado que un buen entrevistador debe adaptarse a diversas personalidades y problemas, alentando a los pacientes a expresarse y guiándolos en la conversación (Morrison, 2014).

Con base en lo antes mencionado para iniciar la exploración de este tema, es esencial abordar la siguiente interrogante:

3.1.1. ¿Cuál es el significado de una entrevista psicológica?

Es fundamental tener en cuenta la contribución de Perpiñá, quien describe brevemente que la entrevista se define como una técnica para recopilar



información y, por ende, una herramienta de evaluación; pero su alcance va más allá de eso.

Su capacidad de adaptación y flexibilidad permite moldear cada entrevista según su propósito particular y ajustarla a las necesidades del entrevistado y al estilo personal del entrevistador, lo que le confiere una ventaja considerable en comparación con otras técnicas de evaluación psicológica (Perpiñá, 2012, p. 23).

Así mismo, es importante destacar que la entrevista despliega un papel fundamental al dar inicio, organizar y coordinar todo el proceso de evaluación y diagnóstico psicológico. Es la principal estrategia para recopilar información sobre el caso y ejerce una función crucial como coordinadora de todo el procedimiento. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta la necesidad de comparar los datos obtenidos en la entrevista con los que provienen de otras técnicas, como cuestionarios, autoobservaciones y similares (Morrison, 2014).

De la misma forma, es necesario recordar que **la entrevista es una conversación con un propósito**. Por tanto, los elementos que se encierran tras esta afirmación son:

- Conversación: **"Comunicación"**.
- La conversación se da, al menos, entre dos personas: **"Interacción"**.
- Propósito: **"Objetivo", finalidad**.

En la tabla 1, se puede apreciar aquellos elementos que diferencian una conversación de una entrevista, con la finalidad de comprender que el diálogo gira en torno al entrevistado y utilice los conocimientos, aportando su experiencia y trabaje con técnicas adecuadas.



Tabla 1.

Diferencias entre conversación informal y entrevista

Aspecto	Conversación Informal	Entrevista
Carácter de la interacción	Espontáneo	Planificado con cita previa
Tópicos	Mutuo interés	Propósito e intencionalidad
Peso en la conversación	Partes iguales	Roles y funciones diferenciados
Conclusión	No es necesario	Puede tener una conclusión o resultado
Propósito	Pasar el tiempo/ divertirse	Obtener información específica
Roles	Conversadores llevan a partes iguales	Entrevistador y entrevistado con funciones definidas
Temas	Elegidos libremente	Planteados por el entrevistador
Respuestas	Espontáneas	Respuestas estructuradas y reflexiones
Aceptación	Sin juzgar ni discutir	Aceptar respuestas y expresiones sin juicio
Confidencialidad	No siempre necesaria	Obligatorio mantener la confidencialidad

Nota. Adaptado de Fundamentos de evaluación psicológica, por Paz Guerra & Peña Herrera, 2021, pp. 114-221, editorial Universidad Politécnica Salesiana.

Como se puede observar en la tabla 1 la entrevista es una de las técnicas más complejas y de más fácil manejo, porque se basa una de las habilidades que desarrollamos a diario; sin embargo, un profesional en Psicología requiere conocer las técnicas apropiadas de interacción y comunicación (Paz Guerra & Peña Herrera, 2021).

3.1.2. Tipo de entrevistas psicológicas

Las entrevistas pueden estar estructuradas de diversas formas:

- **Entrevista no estructurada.** La entrevista se lleva a cabo siguiendo solo unas pautas generales; es el proceso interactivo en sí mismo el que establecerá el orden y el tipo de preguntas, lo que posibilita abordar a cada entrevistado de manera única y personalizada (Perpiñá, 2012).
- **Entrevista semiestructurada.** Es relevante destacar que uno de los principales desafíos de los cuestionarios estructurados es su



rigidez y falta de flexibilidad, lo cual es fundamental en un proceso de evaluación y diagnóstico psicológico. Para abordar este tipo de problemas, se sugieren las entrevistas semiestructuradas, que proporcionan una guía, pero también permiten cierta adaptabilidad y flexibilidad para ajustarse a la persona entrevistada y a las circunstancias particulares (Morrison, 2014).

Es necesario mencionar que este tipo de entrevistas son especialmente útiles cuando se busca obtener un diagnóstico rápido, fiable y válido, sin la posibilidad de realizar una evaluación psicológica más exhaustiva. En estas entrevistas, las preguntas son más flexibles que en las entrevistas estructuradas, ya que se basan en preguntas planificadas que pueden adaptarse a los entrevistados. La ventaja radica en la capacidad de adecuarse a los individuos, brindando amplias posibilidades para motivar al entrevistado, aclarar conceptos, identificar ambigüedades y reducir formalidades (Paz Guerra & Peña Herrera, 2021).

Es fundamental recordar, estimado estudiante, que las preguntas en este tipo de entrevistas presentan cierto nivel de estructuración: el guion está conformado por áreas específicas, dentro de las cuales el entrevistador tiene libertad para formular preguntas pertinentes, siguiendo una orientación algo detallada (Perpiñá, 2012).

Le animo a revisar el siguiente **ejemplo**:

Me gustaría hablar sobre la relación con su pareja. ¿Puede describir cómo se ha sentido en esa relación en las últimas semanas?

En este ejemplo, se utilizan preguntas abiertas para permitir al entrevistado expresar sus sentimientos y situaciones relacionadas con su pareja.

La estructura de la pregunta se enfoca en el comportamiento y los sentimientos en la relación, pero las respuestas son abiertas y permiten que el entrevistado se exprese libremente.

- **Entrevista estructurada.** La entrevista a la que hacemos referencia posee un formato predeterminado en el que todos o algunos de los elementos mencionados están establecidos de antemano. Es decir, las preguntas se definen previamente, el orden de presentación y las opciones de respuesta del entrevistador están limitadas, siguiendo una dirección específica a través de sus secciones. Además, la



combinación de ciertos criterios facilita la interpretación de las respuestas proporcionadas por el entrevistado (Perpiñá, 2012).

Al respecto, Muñoz (2010), indica que entre las ventajas importantes que han justificado su difusión en los últimos años, a pesar de no ofrecer información funcional y de resultar en algunas ocasiones largas y costosas para el entrevistado, quien debe repasar todos los aspectos de su vida respondiendo en muchas ocasiones con monosílabos.

Es relevante destacar que uno de los principales desafíos de los cuestionarios estructurados es su rigidez y falta de flexibilidad, lo cual es fundamental en un proceso de evaluación y diagnóstico psicológico. Para abordar este tipo de problemas, se sugieren las entrevistas semiestructuradas, que proporcionan una guía, pero también permiten cierta adaptabilidad y flexibilidad para ajustarse a la persona entrevistada y a las circunstancias particulares (Morrison, 2014).

Es fundamental recordar, estimado estudiante, que las preguntas en este tipo de entrevistas presentan cierto nivel de estructuración: el guion está conformado por áreas específicas, dentro de las cuales el entrevistador tiene libertad para formular preguntas pertinentes, siguiendo una orientación algo detallada (Perpiñá, 2012).

A continuación, le invito a revisar un **ejemplo** de este tipo de entrevista:

Vamos a hablar sobre sus hábitos de sueño. Por favor, indique cuántas horas promedio duerme cada noche:

- ☐ Menos de 5 horas.
- ☐ Entre 5 y 7 horas.
- ☐ Entre 7 y 9 horas.
- ☐ Más de 9 horas.

En este ejemplo, la pregunta está estructurada de manera que el entrevistado puede seleccionar una de las opciones de respuesta proporcionadas. Al tener opciones específicas, se obtiene una respuesta completa y se recopila información relevante sobre los hábitos de sueño del entrevistado.

Otra técnica que permite recoger información en el proceso de evaluación y diagnóstico es la entrevista con informantes.



3.2. Entrevista con informantes

Según Muñoz (2010), aquellos que pueden proporcionar información sobre el caso son informantes como familiares, tutores, profesionales y otros individuos. Por tanto, contar con la colaboración y la información del entorno del paciente es fundamental en la mayoría de los problemas abordados en psicología. Desde el principio, es necesario informar al paciente que se indagará con las personas que actuarán como informantes. Esto puede comunicarse de la siguiente manera: “vamos a intentar conversar con sus familiares y posiblemente les pediremos que colaboren en el proceso de intervención. ¿Está usted de acuerdo?, ¿con quién cree que podríamos hablar?”

A continuación, en la tabla 2, se presenta un resumen de las situaciones en las que se requiere buscar información adicional en el ejercicio profesional, conforme lo manifiesta Morrison (2014).



Tabla 2.

Situaciones para la búsqueda de información adicional

Situación	Razón
Niños y adolescentes que carecen de perspectiva adecuada sobre su propia conducta	Requiere obtener información de otros países para tener una visión completa.
Pacientes con discapacidad intelectual que necesitan ayuda para relatar su propia información	Su capacidad para proporcionar información puede estar limitada.
Pacientes que ocultan información debido a vergüenza o conductas pasadas problemáticas	Se necesitan fuentes adicionales para obtener datos precisos y completos.
Pacientes con psicosis que presentan interpretaciones delirantes de los hechos	Requiere corroborar y contrastar la información con otras fuentes.
Historia de salud en la infancia desconocida para el paciente, relevante en ciertos casos	Puede ser necesario obtener información de familiares o registros médicos.
Pacientes con trastornos cognitivos que no pueden relatar una buena historia	Se necesita buscar información de fuentes externas para obtener el historial.
Pacientes con trastornos de la personalidad que pueden no decir la verdad	Se requiere corroborar y obtener datos adicionales de otras fuentes.
Pacientes con trastornos de personalidad que no ven sus problemas, pero afectan a otros	Se necesita información de personas cercanas para obtener una visión más completa.
Situaciones en las que proteger un secreto familiar es prioritario	Puede ser más importante mantener la confidencialidad que obtener cierta información.

Nota. Adaptado de DSM-5 Guía para el diagnóstico Clínico, por Morrison 2014, pp. 17-108, Manual Moderno.

Continuando con los contenidos de esta unidad, ahora le invito a estudiar otra herramienta que permite la recolección de información en el proceso de evaluación psicológica, como son las fichas de observación.

3.3. Fichas de observación

Una ficha de observación es una herramienta diseñada para recopilar datos relacionados con un objetivo particular, en la que se establecen variables específicas. También, es un registro destinado a obtener la máxima información de un sujeto a través de su observación, esta observación



puede llevarse a cabo durante un período prolongado o de corta duración (Gil, 2016).

Las particularidades del individuo bajo observación influirán en las características de la ficha utilizada (Gil, 2016). Por ejemplo, al observar el clima en un lugar, se deben considerar al menos los siguientes aspectos:

- Superficie o extensión territorial del área observada.
- Período de tiempo durante el cual se llevará a cabo la observación.
- Variables que serán observadas, tales como temperatura, humedad, saturación del aire, transparencia atmosférica, entre otras.

Asimismo, es notable tener en cuenta las siguientes sugerencias al preparar una ficha de observación:

- Incluir datos informativos en la parte inicial de la ficha, como el nombre completo del sujeto observado, la fecha o períodos de observación y los nombres del observador; al final, debe llevar la firma del observador.
- Organizar la ficha de observación de manera secuencial, colocando los puntos a observar en el orden en que se desarrollan.
- Cada variable de observación debe contener los ítems específicos a observar, de modo que cada variable refleje los aspectos que la caracterizan.

Además, si la variable por observar es memoria en niño preescolar, los ítems a observar serían, por ejemplo:

- Capacidad para recordar nombres de objetos familiares.
- Habilidad para repetir una serie de números o palabras en orden.
- Recuerdo de situaciones o eventos recientes.
- Capacidad para seguir instrucciones y recordarlas.
- Recuerdo de cuentos o historias escuchadas previamente.

Los ítems de la ficha de observación deben ser medidos en su frecuencia o intensidad según sea la necesidad, por ejemplo: para medir frecuencia, se puede utilizar nunca, a veces, frecuentemente y siempre; mientras que, para medir intensidad, se puede utilizar baja, media y profunda. A



continuación, le invitamos a revisar el [anexo 2. Ficha de observación](#), la cual detalla el formulario utilizado para registrar observaciones detalladas sobre un sujeto, evento o situación específica. Puede incluir categorías de comportamiento, frecuencia de ocurrencia y otras notas relevantes.



Estimado estudiante, para reforzar los conocimientos abordados en esta semana le sugiero la lectura de la unidad 3. Diseño de herramientas de recogida de información para el proceso de evaluación y diagnóstico psicológico, que se encuentra disponible en el capítulo 2, en el texto de Perpiñá (2012).



Actividades de aprendizaje recomendadas

Para mayor comprensión de estos temas, desarrolle estas actividades, que le ayudarán a la adquisición de las competencias requeridas en este Prácticum.

1. Elabore un ejemplo de entrevista estructurada, un ejemplo de entrevista semiestructurada y una ficha de observación.

Procedimiento:

- Revise y lea con detenimiento la unidad 3. Diseño de herramientas de recogida de información para el proceso de evaluación y diagnóstico psicológico.
- Identifique las características de una entrevista estructurada y semiestructurada y ficha de observación.
- Elabore los ejemplos en los que se pueda apreciar el tipo de preguntas que implementará en una entrevista estructurada, semiestructurada y ficha de observación.
- Revise el [anexo 3. Entrevista estructurada y semiestructurada](#), la cual es una guía detallada de preguntas y temas a abordar durante una entrevista estructurada. Estas entrevistas siguen un formato



predefinido y consistente para recopilar información específica de manera estandarizada.

Nota: por favor complete las actividades en un cuaderno de apuntes o documento Word.



Una vez finalizada la actividad, comprenderá que la elaboración de una entrevista estructurada comprende preguntas diferentes en comparación con una entrevista semiestructurada y así mismo una ficha de observación requiere otro tipo de ítems diferentes al de las entrevistas.

2. Realice la siguiente autoevaluación para comprobar sus conocimientos.





Autoevaluación 3

1. Seleccione: la autobiografía se considera un tipo de herramienta de recogida de información que forma parte de la clasificación de:
 - a. Escalas de apreciación.
 - b. Entrevista.
 - c. Autoinformes.
2. () Seleccione verdadero o falso: la entrevista estructurada se caracteriza por poseer un formato predeterminado, en donde las preguntas se definen previamente y las opciones de respuesta del entrevistado son limitadas.
3. Complete: la fase II del proceso de evaluación psicológica se denomina: _____
 - a. Herramientas de recogida de información.
 - b. Aplicación de test y técnicas.
 - c. Formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables.
4. Seleccione: el tipo de supuesto que se enfoca en establecer relaciones explicativas de un evento se denomina:
 - a. Supuesto de asociación funcional.
 - b. Supuesto de semejanza.
 - c. Supuesto de asociación predictiva.
5. Complete: el instrumento que recopila información sobre la presencia o ausencia de un comportamiento se denomina: _____
 - a. Escala de apreciación.
 - b. Lista de cotejo.
 - c. Autorregistro.



6. Seleccione: las escalas de apreciación pueden ser de varios tipos, una de ellas contiene una escala numérica con clave descriptiva. Mencione a qué tipo corresponde lo antes expresado:
- Escala descriptiva.
 - Escala de frecuencia.
 - Escala numérica.
7. () Seleccione verdadero o falso: la fase del proceso de evaluación que identifica las variables contenidas en la hipótesis para posteriormente operacionalizarlas con test y/o técnicas se denomina: formulación de hipótesis:
8. Complete: los autoinformes suponen una autoobservación que incluyen contenidos evaluables como _____, _____ y _____
- Manifestaciones motoras, cognitivas y fisiológicas.
 - Manifestaciones motoras, cognitivas y emociones.
 - Manifestaciones motoras, cognitivas, fisiológicas, experiencia subjetiva y emociones.
9. () Seleccione verdadero o falso: la rúbrica es un tipo de herramienta de recogida de información que se caracteriza por contener un formulario de preguntas o afirmaciones a las cuales el sujeto debe responder mediante una alternativa dicotómica o una escala ordinal:



10. Complete: la herramienta de recogida de información que facilita determinar el nivel y la calidad de una tarea mediante una escala cuantitativa y/o cualitativa se denomina: _____.

- a. Entrevista.
- b. Rúbrica.
- c. Lista de cotejo.

[Ir al solucionario](#)

¡Enhorabuena, ha concluido con la evaluación!

¡Excelente!



Una vez finalizada la autoevaluación es momento de analizar los aciertos, lo cual le permitirá realizar un breve repaso de la unidad 3. Diseño de herramientas de recogida de información para el proceso de evaluación y diagnóstico psicológico, los encuentra disponibles en el capítulo 5, en el texto de Paz Guerra & Peña Herrera (2021).





Semana 4



En esta semana continuamos con la unidad 3. Diseño de herramientas de recogida de información para el proceso de evaluación y diagnóstico psicológico, los temas se encuentran disponibles en el capítulo 5, en el texto de Paz Guerra & Peña Herrera (2021).

Felicitaciones por llegar hasta esta semana, prosigamos con la evaluación de otras herramientas para recopilar información. Después de analizar la entrevista estructurada y semiestructurada y la ficha de observación, es el momento de examinar los cuestionarios, inventarios y escalas.

¡Iniciemos!

3.4. Cuestionarios, inventarios y escalas

De acuerdo con lo mencionado por Muñoz (2010), los cuestionarios, inventarios y escalas representan una opción inicial que ofrece varias ventajas, como requerir poca formación para su uso, ser rápidos y fáciles de analizar. Estos también contribuyen a la identificación de problemas, ya que funcionan como instrumentos para formular y confirmar hipótesis diagnósticas, así como para medir el progreso a lo largo del tratamiento.

Al respecto, Fernández-Ballesteros (2013) menciona que estas herramientas de recopilación de información, presentan un formulario de preguntas o afirmaciones a las cuales el sujeto debe responder mediante una alternativa dicotómica ("sí", "no"; "verdadero", "falso") o bien indican su grado de conformidad mediante una escala ordinal, seleccionando o clasificando elementos de acuerdo con sus preferencias o utilizando una escala de intervalos con adjetivos, adverbios o valores numéricos.

Por cual es importante establecer una diferenciación entre cada uno de ellos, a continuación, se presentan las características del cuestionario, escala e inventario.



Características del cuestionario

- Conjunto de preguntas organizadas de uno o varios tipos (abiertas, cerradas, opción múltiple, etc.).
- Utilizadas para recolectar datos sobre una o más variables a medir (Muñoz, 2010).

Características de la escala

- Método para medir variables que constituyen actitudes, comúnmente de Likert y Guttman.
- Consta de un conjunto de ítems en forma de afirmaciones con opciones de respuesta en categorías (de acuerdo, desacuerdo, favor, en contra, indiferente (Muñoz, 2010)).

Características del inventario

- Instrumento para describir y medir las características individuales.
- El individuo responde eligiendo una posición.
- Es multidireccional (Muñoz, 2010).

Como se puede observar, se logra obtener una visión más amplia y organizada de las características de los elementos descritos en relación entre sí, dado que, en el contexto específico de la investigación cuantitativa, conocer las principales características de cada instrumento es de gran importancia para utilizarlos de manera dirigida en situaciones en las que puedan ser más beneficiosos, ya sea debido a su estructura o al método de recopilación de datos. En el ámbito de la psicología, los tres instrumentos presentados anteriormente pueden ser de gran valor, no solo para obtener información, sino también para detectar y destacar problemas, medir características, y abordar diversas necesidades dentro del proceso de evaluación y diagnóstico. Finalmente, se destaca que los inventarios y escalas encuentran aplicación en pruebas psicométricas relacionadas tanto con la personalidad como con el conocimiento y las actitudes (Muñoz, 2010).

Cabe destacar que el uso de cuestionarios, inventarios y escalas pueden aportar una perspectiva más cuantitativa al juicio clínico derivado de las



estrategias de entrevista. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta algunas consideraciones para su adecuada utilización, como las que se detallan a continuación (Muñoz, 2010):

- Deben ser breves y sencillos para facilitar su comprensión y cumplimentación por parte de los pacientes o clientes (Muñoz, 2010).
- Es recomendable que cuenten con formas paralelas o que hayan demostrado su utilidad al emplearse en repetidas ocasiones, asegurando la consistencia y fiabilidad de los resultados (Muñoz, 2010).
- Los cuestionarios deben ser sensibles a pequeños cambios, y aquellos que incluyen escalas de Likert o puntuaciones pueden ser más útiles para detectar y medir modificaciones en el estado del paciente a lo largo del tiempo (Muñoz, 2010).
- Debe existir la posibilidad de aplicar los cuestionarios en situaciones específicas o en intervalos temporales determinados, permitiendo evaluar el progreso del paciente y la efectividad del tratamiento (Muñoz, 2010).

Conforme se puede analizar, se garantiza una utilización más efectiva y confiable de los cuestionarios, inventarios y escalas como herramientas complementarias en el proceso de evaluación y diagnóstico.

Continuando con el tema y considerando que los cuestionarios son una opción complementaria a la entrevista para identificar problemas, es relevante tener en cuenta la perspectiva del autor sobre su uso en dos momentos distintos del proceso de evaluación y diagnóstico previo a la primera entrevista y después de ella, por lo cual en la siguiente tabla 3 se detalla una mejor explicación.



Tabla 3.*Consideraciones pre y post entrevista*

Etapa	Objetivo	Momento de uso
Antes de la primera entrevista	Facilitar parte del trabajo inicial de evaluación y diagnóstico psicológico. Orientar a los pacientes o clientes.	Previo a la primera entrevista.
	Obtener información valiosa sobre las circunstancias vitales que ayudarán a identificar los principales problemas.	
	Guiar la búsqueda posterior durante la entrevista.	
Después de la primera entrevista	Complementar la información obtenida en la primera entrevista.	Antes de la segunda entrevista, cuando se dispone de información más compleja.
	Confirmar o refutar las hipótesis sobre el problema que presenta el paciente.	

Nota. Adaptado de Manual Práctico de Evaluación psicológica Clínica, por Muñoz, 2010, p. 99, Síntesis.

Posterior a la revisión de este tipo de herramienta de recogida de información, es hora de desarrollar las siguientes actividades, que le ayudarán a profundizar sus conocimientos. Recuerde que luego de realizar la entrevista psicológica al sujeto a evaluar, se debe elaborar la historia clínica, para más detalle revise el [anexo 4](#). Formato de historia clínica, el mismo que contiene datos del evaluado, datos identificativos, motivo de consulta: sintomatología, composición familiar, psicoanamnesis personal, estado actual físico y de salud, observación de la conducta, diagnóstico presuntivo, instrumentos psicológicos aplicados, diagnóstico definitivo, pronóstico y recomendaciones.





Actividad de aprendizaje recomendada

Reforcemos el aprendizaje resolviendo la siguiente actividad.

Elabore un mapa mental que permita analizar las ventajas y desventajas del uso de cuestionarios en el proceso de evaluación y diagnóstico psicológico.

Procedimiento:

- Primeramente, estimado estudiante, examine minuciosamente la información presentada previamente en la unidad 3. Diseño de herramientas de recogida de información para el proceso de evaluación y diagnóstico psicológico, los encuentra disponibles en el capítulo 5, en el texto de Paz Guerra & Peña Herrera (2021).
- Posterior a ello, investigue y analice el uso de cuestionarios en el proceso de evaluación y diagnóstico psicológico, identifique las ventajas y desventajas de utilizar los cuestionarios en el ejercicio profesional.
- Finalmente, elabore el mapa mental.

Nota: por favor complete las actividades en un cuaderno de apuntes o documento Word.

¡Enhorabuena, ha finalizado las actividades!



Al culminar las actividades se puede apreciar que los instrumentos, como los cuestionarios, inventarios y escalas, también son estrategias para contrastar información en la estructuración de la evaluación psicológica.





Unidad 4. Formulación de Hipótesis y deducción de enunciados verificables

A modo de resumen, luego de haber revisado las unidades 1, 2 y 3 los fundamentos, las fases del proceso de evaluación psicológica y el diseño de herramientas de recogida de información, es momento de conocer la unidad 4. Formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables, esta unidad la encuentra disponible en el capítulo 2 del **texto básico** de Fernández-Ballesteros (2013).

¡Empecemos!

4.1. Formulación de hipótesis

Es menester recordar que el proceso de evaluación comienza cuando el paciente/cliente realiza una demanda al profesional, con la finalidad de resolver el problema o cuestión planteada. A partir, de ese momento, es necesario tomar una serie de decisiones en cada fase de la evaluación psicológica. Con ello, tras el estudio de la primera fase: herramientas de recogida de información, en la cual el evaluador recopila la información en función de los objetivos establecidos, lo motivo a continuar con el estudio de la segunda fase que corresponde a la formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables.

Para comprender con más detalle los dos momentos imprescindibles para formular la hipótesis, a continuación, se describe la fase 2 del proceso de evaluación psicológica.

Fase 2. Formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables.

Actividad de supuestas plantaciones sobre el caso, en función a las observaciones e información conocido como la formulación de casos (Fernández- Ballesteros, 2013).



■ Paso 1: Formulación de hipótesis

Con base en las observaciones realizadas y su ajuste a los conocimientos generales y específicos, consiste en establecer hipótesis, formulando la teoría sobre el caso (Fernández- Ballesteros, 2013).

Deliberar con qué instrumentos se trabajará para cada variable establecida en las hipótesis formuladas (Fernández- Ballesteros, 2013).

■ Paso 2: Deducción de enunciados verificables

Decidir con qué instrumentos va a operacionalizarse cada una de las variables presentes en cada una de las hipótesis formuladas (Fernández- Ballesteros, 2013).

Establecer hipótesis, formulando la denominada “teoría del caso” (Fernández- Ballesteros, 2013).

Considerando los dos momentos de la fase 2 detallados anteriormente, Fernández -Ballesteros (2013) refiere que la formulación de hipótesis se realiza según las observaciones ejecutadas y se ajuste con los conocimientos generales, específicos obtenidos, llegando a establecer la teoría del caso; mientras que, en la deducción de enunciados verificables, el evaluador deberá decidir los instrumentos a emplear para operacionalizar las variables contempladas en las hipótesis formuladas. Por ejemplo: si la hipótesis fuese, “el sujeto se comporta como depresivo” (hipótesis de semejanza), la deducción de enunciados verificables llevaría hasta la necesidad de concretar variables, métodos y técnicas, por tanto, “el sujeto debería obtener una alta puntuación en el BDI-II” (instrumento que detecta y evalúa la sintomatología depresiva).

Según Buela y Sierra (1997) la formulación de hipótesis obedece a la demanda del caso y emplea el método inductivo, que parte de la información preliminar obtenida hasta la interpretación del caso; no obstante, la interpretación inicial debe ser flexible con el fin de permitir modificaciones posteriores, esto debido a que según avance el proceso de evaluación y diagnóstico se puede obtener nueva información que implicará un replanteamiento de las hipótesis.

Por otra parte, dentro de este paso resulta fundamental considerar la fiabilidad-validez de los datos recopilados del sujeto, su entorno y los

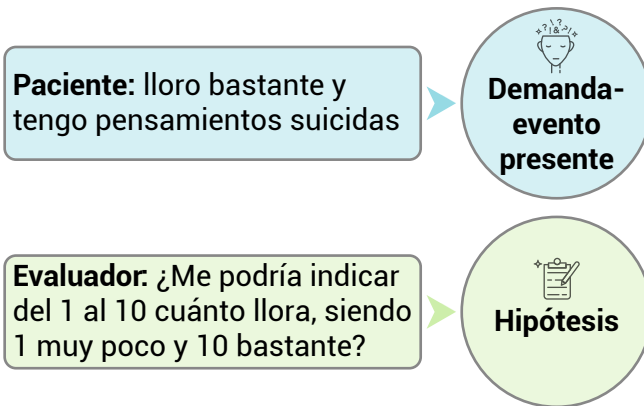


conocimientos del evaluador; de esta manera, cuando se concatena la información obtenida del sujeto evaluado y el contexto, el evaluador procederá a enunciar los supuestos para posteriormente contrastarlos (Buela y Sierra, 1997 y Fernández -Ballesteros, 2013).

En este sentido, Fernández -Ballesteros (2013) distingue cuatro tipos de supuestos que pueden formularse:

1. **Supuestos de cuantificación:** las hipótesis se formula en términos de grado o intensidad; es decir, mediante este supuesto se busca comprobar en qué medida aparece un fenómeno. Ejemplo:

Figura 2.
Formulación de hipótesis



Nota. Adaptado de Evaluación Psicológica Segunda Edición, por Fernández-Ballesteros, 2013, pp. 69-70. Pirámide.

2. **Supuestos de semejanza:** se enuncian atendiendo a un cuadro sintomático, tratando de explorar alguna alteración psicopatológica que obedece a criterios establecidos en un sistema de calificación oficial (DSM-V, CIE 11) con la finalidad de situarlo en una categoría nosológica. Ejemplo:

- *Paciente:* tengo depresión, me siento triste, con poca energía desde 3 semanas atrás.
- *Evaluador:* debe observar si actúa o si cumple los criterios establecidos en DSM-V.

3. **Supuestos de asociación predictiva:** se formulan considerando pronósticos o predicciones de una conducta o situación de estudio en función a las consecuencias esperables a mediano o largo plazo; es decir, se busca hipotetizar en qué medida la conducta o situación de estudio se asocia a otras variables. Ejemplo:

- *Paciente:* tengo a mi hijo de 10 años con un bajo rendimiento escolar.
- *Evaluador:* observar cuáles podrían ser las predicciones con base en la demanda del paciente y que otras áreas se debe evaluar, el problema puede estar asociado a la dinámica familiar, comportamiento hiperactivo del menor, entre otros.

4. **Supuestos de asociación funcional:** las hipótesis se establecen considerando relaciones explicativas o causales de un evento o variables. Ejemplo: hipotetizar que la falta de rendimiento escolar de un menor se debe a una lesión cerebral.

A continuación, se puede observar los aspectos a considerar para elaborar hipótesis, con la finalidad de comprender que cuando se pretenda realizar un diagnóstico psicológico, tan solo será necesario establecer supuestos de cuantificación y semejanza; así mismo, cuando los objetivos sean de orientación o selección, tendrán que ser formulados supuestos de cuantificación y asociación predictiva (Fernández -Ballesteros (2013).

Aspectos a considerar para elaborar hipótesis

1. Para realizar un diagnóstico será necesario formular supuestos de cuantificación y semejanza (Fernández- Ballesteros, 2013).
2. Cuando la finalidad sea de orientación o selección, se establecerán hipótesis de cuantificación y asociación predictiva (Fernández- Ballesteros, 2013).
3. Para el cambio comportamental de un determinado sujeto se realizaron suposiciones de relación funcional (Fernández- Ballesteros, 2013).

Como se puede evidenciar es necesario conocer las bases del establecimiento de las hipótesis, con el propósito de deducir enunciados



verificables en los que las variables implicadas se operacionalicen mediante técnicas de evaluación psicológica.

En la siguiente infografía se pretende ejemplificar la fase 2: formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables, mediante un caso clínico, que le permitirá conocer el proceso para formular hipótesis, para ello le invitamos a revisar la siguiente información:

Ejemplo de caso clínico fase II.

Con lo antes mencionado, los animamos a analizar y responder las siguientes preguntas:

- ¿Qué aspectos se deben considerar para formular las hipótesis?
- Durante el ejercicio profesional, ¿cuál sería la importancia de formular adecuadamente las hipótesis durante el proceso de evaluación psicológica?



Actividades de aprendizaje recomendadas

Luego de los temas de estudio, es momento de desarrollar las siguientes actividades que le ayudaran a ejercitarse en la formulación de hipótesis, fase de gran utilidad dentro del ejercicio profesional del psicólogo.

1. Formule e identifique tres hipótesis considerando el siguiente caso: Lucía, adolescente de 16 años de edad, indica que siente ansiosa y muy triste la mayor parte del día; además, menciona que no se encuentra bien en el colegio, le cuesta conciliar el sueño y prefiere estar en casa la mayor parte del tiempo. Durante las tres últimas semanas experimenta: nerviosismo, calor, llanto fácil, pérdida de peso significativo, fatiga y dificultad para concentrarse.

Procedimiento:

- Estimado estudiante, en un primer plano lea detenidamente la información presentada en esta unidad. Posteriormente, considere los elementos del caso para la formulación de las hipótesis.



- Identifique el tipo de supuesto idóneo para este caso o situación en particular.
- Enliste los 3 supuestos relacionados con el caso.
- Identifique la hipótesis final y la sintomatología principal de la adolescente.

Nota: por favor complete la actividad en un cuaderno de apuntes o documento Word.

¡Enhorabuena!

Con esta actividad ha comprendido la fase II del proceso de evaluación psicológica, las bases del establecimiento de hipótesis (en sus diferentes formas) y como, desde ellas, se deducirán los enunciados verificables. Considere que, en función de los objetivos y demanda del caso detallado, se formula hipótesis de semejanza debido a que se pretende averiguar si el sujeto presenta una serie de conductas semejantes a las de otros, previamente clasificado en una entidad nosológica.

2. Le invitamos a dar lectura al [anexo 5. Informe de contextualización del centro de prácticas](#): que proporciona un contexto completo sobre el centro de prácticas donde lleva a cabo la experiencia. Puede incluir detalles sobre la organización, su misión, estructura, servicios, funciones y otros aspectos relevantes.



Semana 6

Estimado estudiante, continuando con la unidad 4. Formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables, como breve resumen, tras el estudio de la formulación de hipótesis lo motivo a continuar con el siguiente paso que corresponde a la deducción de enunciados verificables. En un primer momento, se requiere identificar las variables implicadas y los instrumentos con los que serán medidas, para posteriormente establecer conclusiones contrastables; es así que, lo invito a adentrarse en el conocimiento del segundo paso del proceso de evaluación psicológica.



Le recordamos que la unidad 4. Formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables, se encuentra disponible en el capítulo 2 del **texto básico** de Fernández-Ballesteros (2013).

¡Adelante!

4.2. Deducción de enunciados verificables

Fernández-Ballesteros (2013) menciona que la de la deducción de enunciados verificables facilita establecer conclusiones contrastables, para lo cual se requiere que las variables que constan en las hipótesis se encuentren debidamente operacionalizadas mediante la aplicación de diversos instrumentos de evaluación. Para ello, el evaluador debe considerar dos aspectos fundamentales:

- Enlistar las variables implicadas en las hipótesis.
- Establecer las técnicas, *test* y procedimiento de evaluación.

Para la comprensión de la deducción de enunciados verificables, a continuación, se presenta una tabla que le permitirá comprender que en esta sub fase se requiere especificar las variables involucradas mediante los instrumentos con los que se va a estudiar al sujeto. Por lo tanto, la deducción de enunciados permitirá establecer conclusiones contundentes.



Tabla 4.

Ejemplo caso clínico de deducción de enunciados verificables

Ejemplo	Imagen
Ejemplo 1: Hipótesis Juan rinde escasamente en la escuela. El bajo rendimiento puede estar asociado a una baja inteligencia.	 <i>Nota.</i> Tomado de Lindo niño pequeño con la mano en la mejilla sintiéndose cansado, aburrido y perezoso estudiando, haciendo su tarea en el escritorio en casa [Ilustración], por Herman ., s.f., vecteezy
Ejemplo 2: Variables implicadas Referidas a la conducta problema: especificación cuantitativa del rendimiento escolar. Referidas a las variables personales: inteligencia.	 <i>Nota.</i> Tomado de Niño triste sentado en un escritorio en el vector del aula. escuela. educación. ilustración aislada [Ilustración], por Pavel Sevryukov, s.f., vecteezy
Ejemplo 3: Instrumentos elegidos para verificar los enunciados deducidos Reporte de calificaciones escolares como medida del rendimiento. Escala de Medida de la Inteligencia para Niños de Wechsler; Test de Medida de la Inteligencia Terman.	 <i>Nota.</i> Tomado de Vector indio chico aislado dibujos animados personaje ilustración [Ilustración], por MD. RAHEL HOSSEN, s.f., vecteezy

Nota. Adaptado de Evaluación Psicológica Segunda Edición, por Fernández-Ballesteros, 2013, pp. 67-69,

Similar a la formulación de hipótesis, los conocimientos teóricos del evaluador inciden en la deducción de enunciados verificables, mediante ellos se seleccionarán las variables que constan en los supuestos y se procederá a establecer la metodología y procedimiento de evaluación. Finalmente, le invito a revisar el [anexo 6. Informe de formulación y deducción de variables](#), este informe describe cómo se formularon y dedujeron las variables utilizadas en el estudio. Explica la relación entre las variables, cómo se midieron y por qué se consideraron importantes.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Una vez que realizó la revisión de los contenidos de esta unidad, lo invito a desarrollar la siguiente actividad recomendada sobre los temas hasta ahora planteados:

Formule hipótesis y realice la deducción de enunciados verificables según el siguiente caso: Ana, adolescente de 12 años, es hija única de matrimonio, su madre es abogada y su padre trabaja como guardia en un prestigioso banco. Viven en un condominio al Norte de la ciudad de Quito en compañía de su abuela materna. Ana es sometida a un proceso de evaluación por motivo de no querer acudir a invitaciones de fiestas. Comenta que presenta miedo intenso de encontrar payasos, lo cual deriva en síntomas como nerviosismo, inquietud, aumento de ritmo cardíaco, opresión en el pecho y sensación de ahogo.

Procedimiento:

- Estimado estudiante, realice una revisión minuciosa de la unidad 4. Formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables, subtema 4.2 Deducción de enunciados verificables, información que puede ver en el capítulo 2 del **texto básico** de Fernández-Ballesteros (2013).
- Lea detenidamente el caso clínico que se detalla anteriormente.
- Con base en el caso, formule tres hipótesis.
- Identifique y enliste las variables implicadas.



- Realice la deducción de enunciados verificables, para ello considere la aplicación de dos instrumentos de evaluación por cada variable.

Nota: por favor complete la actividad en un cuaderno de apuntes o documento Word.

Retroalimentación:

¡Bien hecho!

La actividad realizada le permite prepararse y entrenarse en la elaboración de la formulación de hipótesis y la deducción de enunciados verificables. En función del caso o situación, las hipótesis se pueden establecer considerando la conducta, problema o situación, variables personales y ambiente del sujeto evaluado, luego el evaluador procede a identificar las variables para operacionalizarlas con los instrumentos idóneos; por consiguiente, no cabe duda que cuantos mejores instrumentos se utilicen, tantas más adecuadas garantías presentarán los datos, al menos si se realiza un análisis minucioso de los instrumentos que faciliten la triangulación de los resultados.



Semana 7

Unidad 5. Herramientas de recogida de información

Estimado estudiante, es momento de continuar con el estudio de las herramientas de recogida de información para el proceso de evaluación y diagnóstico psicológico. En este sentido, la información debe ser recopilada de forma sistemática, para lo cual el evaluador emplea diversas técnicas de evaluación de amplio espectro que coadyuven a obtener datos del sujeto, su contexto social y ambiental.

Los contenidos de la unidad 5. Herramientas de recogida de información, se encuentran disponibles en el capítulo 2 del **texto básico** de Fernández-Ballesteros (2013).

¡Comencemos!



5.1. Lista de cotejo y escalas de apreciación

5.1.1. Lista de cotejo

Según Medina y Verdejo (2001) la lista de cotejo, también denominada *lista de control*, es un instrumento estructurado que coadyuva a recolectar información sobre la presencia o ausencia de un comportamiento, acción o una característica en particular. Se caracteriza por ser dicotómica; es decir, que, ante un determinado grupo de rasgos observables, el evaluador establece dos alternativas: la presencia o ausencia, alcanza o no alcanza, entre otros.

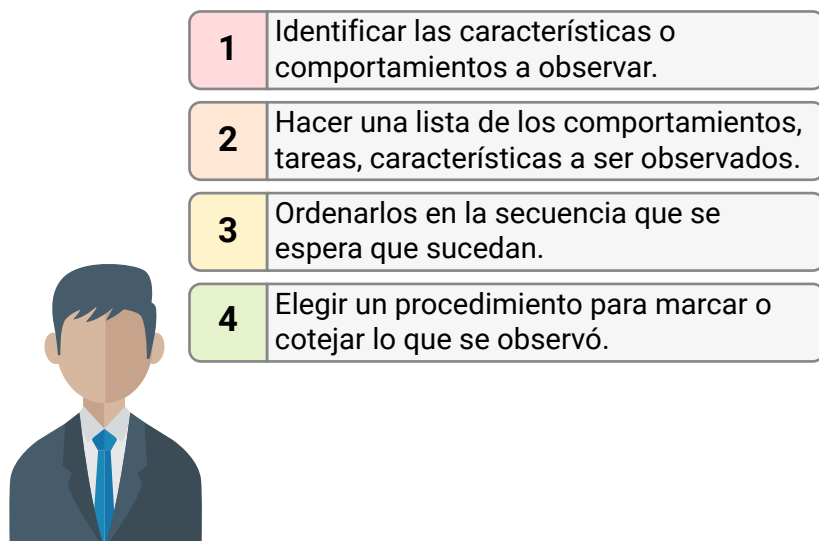
Con la finalidad de obtener más claridad sobre el diseño y desarrollo de la lista de cotejo, le invitamos a revisar el [anexo 7](#). Lista de cotejo, que es un documento que enumera los criterios específicos que deben cumplirse o evaluarse. Se utiliza para realizar evaluaciones puntuales y marcar los elementos que se han completado. Así mismo, en el [anexo 8. Formato de informe para lista de cotejo y escalas de apreciación](#), se lo utiliza para presentar los resultados obtenidos a partir de una lista de cotejo o escalas de apreciación. Puede incluir puntuaciones, comentarios y observaciones relacionadas con la evaluación.

Las listas de cotejo son una guía de información y a la vez permiten la recolección de información; por lo tanto, para su elaboración se deben considerar algunas recomendaciones que se muestran en la siguiente figura:



Figura 3.

Aspectos para elaborar listas de cotejo



Nota. Adaptado de La Evaluación del aprendizaje estudiantil 3ª Ed., Medina y Verdejo, 2001, Isla negra. Evaluación del aprendizaje estudiantil. (3ª Ed.). Isla negra.

Como se pudo observar en la figura, las listas de cotejo detallan los criterios que se debe seguir para lograr identificar y resolver una determinada actividad, con el propósito de observar claramente si los criterios que se desea lograr han sido cumplidos.

5.1.2. Escalas de apreciación

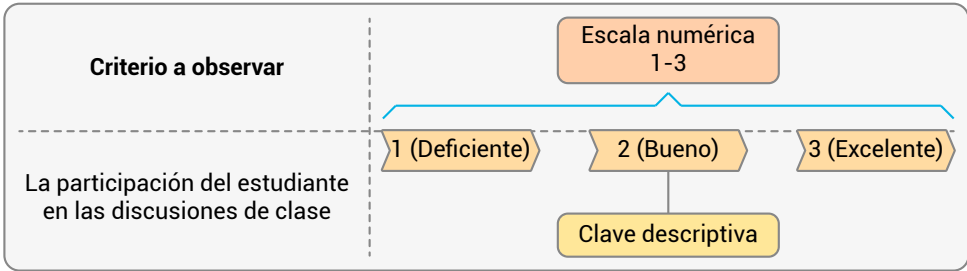
González (2007) menciona que las escalas de apreciación permiten al observador recolectar información acerca de la frecuencia o intensidad con que ocurren los comportamientos. Generalmente, constan de una lista de características, comportamientos u otros aspectos que van a ser observados y algún tipo de escala que indica la gradación en la que se encuentra determinada característica.

Según Delgado (2007) se distinguen tres tipos de escalas que son empleadas con mayor frecuencia: escalas numéricas, descriptivas y frecuencia.

- **Numérica:** es expresada en números, para ello el observador asigna una escala numérica con una clave descriptiva que señalan los niveles de frecuencia de característica u otro aspecto observable.

A continuación, en la siguiente figura se detalla un ejemplo para identificar cómo es una escala numérica:

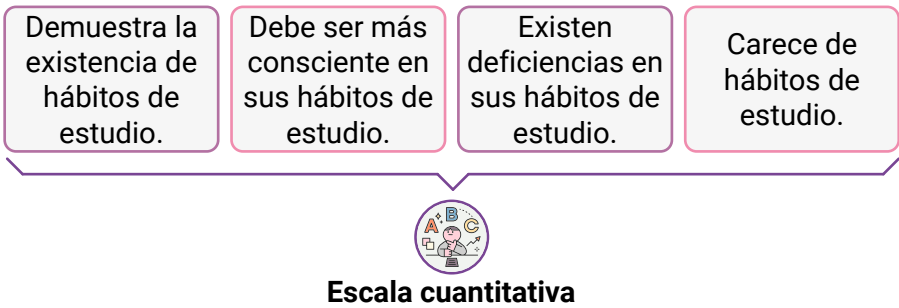
Figura 4.
Ejemplo para identificar una escala numérica



Nota. Faggioni, P., Pineda, V., 2023

- **Descriptiva:** también denominada escala de cualitativa, presenta los distintos niveles de frecuencia con frases descriptivas expresadas brevemente en un orden secuencial. Por ejemplo: ante la valoración de hábitos de estudio, los criterios de valoración podrían ser los que se presentan a continuación:

Figura 5.
Criterios de valoración

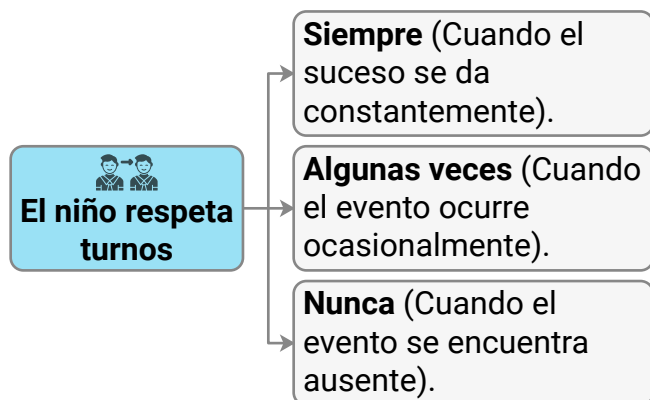


Nota. Faggioni, P., Pineda, V., 2023

- **Frecuencia:** presencia en la que ocurre un comportamiento determinado. En la figura 6 se presenta un ejemplo:

Figura 6.

Ejemplo de Frecuencia



Nota. Elaboración propia.

Para la elaboración de las escalas de apreciación es menester considerar algunas recomendaciones:

- Preparar una lista con los aspectos a ser observados.
- Seleccionar el tipo de escala con las categorías que señalen el grado o nivel en que se presenta las características, comportamiento u otro aspecto observable.
- Incluir las instrucciones de forma específica para el observador que va a utilizar la escala de apreciación.
- Se sugiere proveer un espacio para observaciones o comentarios, de tal forma que el evaluador pueda detallar los inconvenientes después de cada aspecto observado.

5.1.3. Rúbrica

González (2007), manifiesta que las rúbricas permiten determinar el nivel y la calidad de una tarea mediante una escala cuantitativa y/o cualitativa. En la rúbrica se detallan los criterios que van a ser empleados para evaluar el trabajo o tarea del estudiante.

Para la elaboración de las rúbricas es fundamental considerar qué actividad, tarea u otro aspecto que se va a evaluar, establecer los objetivos que se desea alcanzar, determinar los criterios en función de los objetivos y fijar



las puntuaciones. En este sentido, a continuación, se puede observar los elementos que se reflejarán en la rúbrica:

- **Cara 1:** niveles de ejecución.

Ejemplo: excelente, bueno, necesita mejorar (González, 2007).

- **Cara 2:** criterios o indicadores de evaluación.

Ejemplo: contenidos, originalidad, requisitos (González, 2007).

- **Cara 3:** valores o puntuación.

Ejemplo: asignar a cada nivel de ejecución un valor (González, 2007).

Como se puede apreciar, para la elaboración de las rúbricas es fundamental considerar qué actividad, tarea u otro aspecto que se va a evaluar, establecer los objetivos que se desea alcanzar, determinar los criterios en función de los objetivos y fijar las puntuaciones.

5.1.4. Autoinformes

Fernández-Ballesteros (2013), refiere que un autoinforme supone una autoobservación que realiza el sujeto de su propia conducta. A lo largo del tiempo, los autoinformes productos de la introspección, como procedimientos de recogida de información en psicología, han sido fuertemente criticados.

A continuación, se presenta la clasificación de los contenidos de los autoinformes según el criterio de Fernández-Ballesteros (2013), relevantes para esta herramienta.

- **Título 1:** manifestaciones motoras.

Cuantos cigarrillos consume en una unidad de tiempo (Fernández-Ballesteros, 2013).

- **Título 2:** pensamientos o cogniciones.

Por *ejemplo*: si tiene ideas de suicidio (Fernández-Ballesteros, 2013).



- **Título 3:** manifestaciones fisiológicas.

Por *ejemplo*: si tiene taquicardia (Fernández-Ballesteros, 2013).

- **Título 4:** experiencias subjetiva en relación con determinados actos o comportamientos.

Por *ejemplo*: si cree que está fumando demasiado (Fernández-Ballesteros, 2013).

- **Título 5:** emociones.

Por *ejemplo*: si se siente alegre o triste (Fernández-Ballesteros, 2013).

Es importante indicar que los autoinformes sobre contenidos cognitivos, experiencia emocional, autocalificaciones y valoraciones han de ser comprendidos como la expresión verbal de eventos internos, y, en este caso, el autoinforme pasa a ser un procedimiento directo y prioritario de recogida de información (Fernández-Ballesteros, 2013, p. 243).

Por otra parte, se pueden distinguir diferentes tipos de autoinforme, dentro del campo de la psicología, los más utilizados son: cuestionario, inventarios-escalas, autorregistros, pensamiento en voz alta, entrevista y autobiografía, para más información le invitamos a revisar la infografía [Tipos de autoinformes](#).

Para finalizar, Carrasco y Rubio (2020), manifiestan que con relación a la calidad de los informes existen dos limitaciones: la reactividad y la distorsión de la respuesta misma que se relaciona con la falsedad o engaño, errores escalares, deseabilidad social que se engloba la tendencia no voluntaria de los sujetos a dar una imagen de sí mismos socialmente deseable y el asentimiento, considerado como la predisposición que lleva a un evaluado a responder “sí” independientemente de la pregunta que se establezca.





Actividades de aprendizaje recomendadas

Luego de los temas de estudio, es momento de desarrollar las siguientes actividades que le ayudarán a ejercitarse en la elaboración de listas de cotejo y autoinformes, herramientas de gran utilidad dentro del ejercicio profesional del psicólogo.

1. Le animamos a analizar y responder las siguientes preguntas:
 - ¿Qué aspectos se deben considerar al elaborar listas de cotejo?
 - Durante el ejercicio profesional, ¿cuál sería la importancia de los autoinformes en un caso relacionado con el consumo de sustancias?
2. Elabore una lista de cotejo para observar y evaluar el comportamiento de un niño de 10 años de edad con posible diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Cabe considerar que la aplicación del instrumento será dentro del entorno educativo.

Procedimiento:

- Realice una lectura comprensiva de la unidad 5. Herramientas de recogida de información, se encuentran disponibles en el capítulo 2 del **texto básico** de Fernández-Ballesteros (2013).
- Posteriormente, considere los elementos para la elaboración de listas de cotejo.
- Investigue en la *web*, sobre el TDAH con la finalidad de establecer las dimensiones a observar, considerando la etapa de desarrollo y edad cronológica del menor.
- Enliste los aspectos a observar de cada dimensión.
- Finalice con la elaboración de la lista de cotejo.

Nota: por favor complete las actividades en un cuaderno de apuntes o documento Word.

¡Enhorabuena!





Ha finalizado con la actividad 1 recuerde que las listas de cotejo se elaboran con base a los objetivos del caso o situación y brinda una visión cuantitativa, amplia y rápida al evaluador sobre la presencia o ausencia de una situación o criterio en cuestión; en tanto se requiere que los criterios a observarse sean redactados de forma clara, precisa y pertinente.

3. Así mismo, dentro de las herramientas de recogida de información se encuentran los *test* psicológicos, lo invitamos a revisar el [anexo 9. Cuestionario PHQ-9](#), es una herramienta de evaluación que se utiliza para medir la gravedad de los síntomas de depresión. Consiste en una serie de preguntas que exploran diferentes aspectos del estado emocional del individuo.
4. También, revise el [anexo 10. Cuestionario 16PF-5](#), es una prueba de personalidad que evalúa 16 rasgos de personalidad. Ayuda a comprender las características personales de un individuo y su estilo de comportamiento.
5. Realice la siguiente autoevaluación para comprobar sus conocimientos.



Al concluir esta unidad, es importante mencionarle que una de las herramientas de recogida de información, más criticadas, ha sido el autoinforme, ya que permiten una introspección o la autoobservación, por ende, su resultado es cualitativo. Ante ello, se sugiere que para una apropiada evaluación psicológica se elija herramientas de recogida de información que contengan confiabilidad y validez.





Autoevaluación 4

1. Seleccione: la autobiografía se considera un tipo de herramienta de recogida de información que forma parte de la clasificación de:
 - a. Escalas de apreciación.
 - b. Entrevista.
 - c. Autoinformes.
2. Complete: la entrevista estructurada se caracteriza por: _____
 - a. Poseer un formato predeterminado, en donde las preguntas se definen previamente y las opciones de respuesta del entrevistado son limitadas.
 - b. Contener pautas generales donde las preguntas se formulan durante el proceso interactivo.
 - c. Coadyuvar a un diagnóstico rápido y fiable.
3. () Seleccione verdadero o falso: la fase II del proceso de evaluación psicológica se denomina herramientas de recogida de información.
4. Seleccione: el tipo de supuesto que se enfoca en establecer relaciones explicativas de un evento se denomina:
 - a. Supuesto de asociación funcional.
 - b. Supuesto de semejanza.
 - c. Supuesto de asociación predictiva.
5. Complete: el instrumento que recopila información sobre la presencia o ausencia de un comportamiento se denomina: _____

 - a. Escala de apreciación.
 - b. Lista de cotejo.
 - c. Autorregistro.



6. Seleccione: las escalas de apreciación pueden ser de varios tipos, una de ellas contiene una escala numérica con clave descriptiva. Mencione a qué tipo corresponde lo antes expresado
- Escala Descriptiva.
 - Escala de frecuencia.
 - Escala numérica.
7. () Seleccione verdadero o falso: la fase del proceso de evaluación que identifica las variables contenidas en la hipótesis para posteriormente operacionalizarlas con test y/o técnicas se denomina deducción de enunciados verificables.
8. Complete: los autoinformes suponen una autoobservación que incluyen contenidos evaluables como: _____
- Manifestaciones motoras, cognitivas y fisiológicas.
 - Manifestaciones motoras, cognitivas y emociones.
 - Manifestaciones motoras, cognitivas, fisiológicas, experiencia subjetiva y emociones.
9. Seleccione: tipo de herramienta que se caracteriza por contener un formulario de preguntas o afirmaciones a las cuales el sujeto debe responder mediante una alternativa dicotómica o una escala ordinal.
- Cuestionarios.
 - Entrevista.
 - Rúbrica.
10. La herramienta de recogida de información que facilita determinar el nivel y la calidad de una tarea mediante una escala cuantitativa y/o cualitativa se denomina:
- Entrevista.
 - Rúbrica.
 - Lista de cotejo.

[Ir al solucionario](#)





Semana 8

Durante esta semana continuaremos con el estudio del proceso de evaluación psicológica y las herramientas de recopilación de información, mismas que son de gran utilidad para el psicólogo en su ejercicio profesional; por ello, es importante volver a revisar los contenidos de la fase I y II del procedimiento de evaluación psicológica e identificar las características, requerimientos o elementos que deben ser considerados en cada una de las herramientas de recogida de información.

Sobre la base teórica que se ha impartido desde la semana 1 hasta la semana 7, le invitamos a revisar el siguiente módulo didáctico que le permitirá realizar un breve repaso de los contenidos, con la finalidad de potenciar las habilidades adquiridas a lo largo de estas ocho semanas, lo cual le servirá para comprender que un proceso de evaluación psicológica implica solucionar en algunos casos problemas, por tal razón han de tomarse decisiones, basadas en la ciencia, para dar respuesta a la demanda del sujeto.

Resumen de semanas 1 - 8.

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación:



Actividad de aprendizaje recomendada

Con el fin de reforzar los contenidos tratados en semanas anteriores, se sugiere revisar los recursos interactivos realizados para cada uno de los temas.

Procedimiento:

Subraye las ideas principales y tome notas de los aspectos importantes de cada tema.

Nota: por favor complete la actividad en un cuaderno de apuntes o documento Word.



¡Felicitaciones!

Hemos finalizado el estudio de las unidades 1, 2, 3, 4 y 5.

Es momento de prepararse para estudiar nuevos temas, los cuales también serán llevados a la práctica en escenarios reales.



Semana 9

Unidad 6. **Entrenamiento en escenarios simulados, técnicas psicométricas. Entrenamiento en escenarios simulados, técnicas objetivas y proyectivas**

¡Bienvenidos a la unidad 6!

Una vez que usted ha revisado la información sobre cómo llevar a cabo el proceso de evaluación y diagnóstico de forma ética, es momento de continuar con el estudio de una nueva unidad, en la que usted identificará diferentes técnicas psicométricas tanto objetivas y proyectivas, todo ello le ayudará a recoger información de la persona evaluada en cada uno de sus centros de práctica, así como también el proceso de aplicación de instrumentos psicométricos, siendo este un paso primordial para contrastar hipótesis y llegar a un diagnóstico definitivo. Asimismo, se adentrará en el mundo de la realidad virtual y sus aplicaciones en la psicología. A continuación, le animo a dar lectura del contenido.

6.1. Test psicológicos

La aplicación de pruebas psicológicas por parte del profesional de psicología es una herramienta fundamental en la evaluación y diagnóstico de diversos aspectos psicológicos de los individuos. Sin embargo, es importante considerar que, antes de aplicar cualquier prueba, el profesional de psicología debe realizar una entrevista exhaustiva con el individuo para recabar información relevante sobre su historia clínica, contexto social, síntomas y problemas actuales. Esta evaluación inicial ayudará a seleccionar las pruebas más apropiadas para el caso y a interpretar adecuadamente los resultados. Es esencial tener en cuenta que el psicólogo debe emplear pruebas psicológicas que hayan sido validadas y



cuenten con evidencia científica que respalde su utilidad y precisión. Esto asegura que los resultados sean válidos y confiables, brindando una base sólida para la toma de decisiones clínicas.

Cronbach (1990), determina que un *test* es un procedimiento sistemático en la cual se llevan a cabo procesos de observación de conducta para describirlos con la ayuda de escalas numéricas o categorías establecidas por el evaluador. Por otro lado, Fernández – Ballesteros (2013) menciona que existen otras formas de recogida de información llamadas “técnicas” o “instrumentos, ya que estos cuentan con un material, forma de administración y corrección, o en su defecto adopten una forma flexible en la aplicación o administración.

En ese sentido, resulta importante detallar lo que afirma Chiavenato (2008), el cual manifiesta que un *test* psicométrico es una medición objetiva y estandarizada que mide el comportamiento, capacidades, aptitudes o características del comportamiento de un determinado individuo.

La historia de la evaluación psicológica y el uso de *test* psicológicos es un viaje fascinante que abarca siglos de desarrollo, evolución y refinamiento de técnicas y métodos para comprender la mente humana. Desde la antigüedad hasta la era moderna, la evaluación psicológica ha desempeñado un papel crucial en el estudio y la comprensión de la conducta y el funcionamiento mental. A lo largo de los años, ha pasado por diversas etapas, cada una influenciada por los avances científicos, las teorías psicológicas y las necesidades sociales. Es por ello que a continuación revisaremos de acuerdo con Aiken Lewis R. (2022) la perspectiva histórica de la medición psicológica.

Desde los comienzos de la humanidad se ha podido identificar que las personas difieren tanto en sus características de personalidad, aptitudes cognoscitivas, y comportamiento, y, por lo tanto, estas diferencias pueden evaluarse en cierta forma. A continuación, conoceremos algunos datos históricos sobre el proceso de evaluación.

Medición mental en el siglo XIX

En este periodo no existían instrumentos precisos y automáticos para medir y registrar, por lo que se basaban en gran medida de las habilidades de percepción motrices de los observadores humanos. Ante ello impulsado



por las postulaciones de Charles Darwin sobre las diferencias individuales, surgió el interés de varios autores por desarrollar medidas estandarizadas.

- **Francis Galton:** se interesó en las bases hereditarias de la inteligencia y en la medición de las habilidades humanas, elaboró una serie de pruebas sensoriomotrices para evaluar aptitudes y temperamento.
- **James McKeen Cattell:** intentó relacionar las calificaciones de las mediciones de tiempo de reacción y discriminación sensorial con las calificaciones escolares.

Principios del siglo XX

- **Alfred Binet:** con apoyo de Theodore Simon, construyeron una prueba de evaluación psicológica validada con el fin de medir el coeficiente de inteligencia en los niños, para ser administrada individualmente, a partir de ello se introdujo el concepto de edad mental como una forma de cuantificar el desempeño general de una persona en la prueba.
- **Charles Spearman:** describe su teoría sobre aptitudes mentales.
- **Edward Thorndike:** se destaca en pruebas de aprovechamiento, para lo cual elabora pruebas estandarizadas de aritmética, calígrafa, lenguaje y ortografía.
- **Lewis Terman:** en pruebas de inteligencia, para lo cual publica la Escala de inteligencia de Stanford-Binet.
- **Robert Woodworth y Hermann Rorschach:** se destacan en pruebas de personalidad e introducen las pruebas proyectivas.

La historia de la evaluación psicológica y mental es un reflejo de cómo la humanidad ha buscado comprender la complejidad de la mente y el comportamiento a lo largo de los siglos. Con ello, la evaluación psicológica ha evolucionado con la tecnología y la investigación, lo que ha proporcionado, a través de la neurociencia, nuevas formas de comprender el funcionamiento cerebral y cómo se relaciona con la psicología mediante las técnicas de neuroimagen.



6.1.1. Objetivos de aplicación de las pruebas

La utilización de pruebas psicológicas y otros instrumentos de evaluación son utilizados en varios campos, así como con diversos fines, los mismos que pueden ser académicos, clínicos, laborales, forenses, vocacionales, etc. El objetivo principal de las pruebas psicológicas es evaluar el comportamiento, las aptitudes cognoscitivas, rasgos de personalidad y otras características individuales y de grupo, con el fin de ayudar a la toma de decisiones, formar juicios o predicciones. Entre otros objetivos que se detallan a continuación:

- Seleccionar personal para contratación de empleos.
- Clasificar y colocar a las personas en contextos educativos y laborales.
- Asesorar educativa, vocacional y personal.
- Diagnosticar y prescribir tratamientos psicológicos.
- Evaluar cambios cognoscitivos o de comportamiento en los procesos de intervención.
- Evaluar la eficacia de nuevos programas o nuevas técnicas. (Aiken, 2022, p. 9).

Aplicar pruebas psicológicas es una responsabilidad importante, ya que los resultados pueden influir en la comprensión y toma de decisiones relacionadas con la salud mental, el diagnóstico y el tratamiento. A continuación, le invitamos a revisar la siguiente infografía en el cual se detallarán varios aspectos clave que debes considerar antes de aplicar pruebas psicológicas, tomando en cuenta que los profesionales de la psicología deben estar equipados con una serie de competencias y atributos esenciales que van más allá del dominio técnico.

Aspectos antes de aplicar test psicológicos.

Con la información revisada, usted puede evidenciar que, la tarea de aplicar pruebas psicológicas es una responsabilidad que va más allá de la técnica, abarcando habilidades interpersonales, conocimiento ético y una apreciación profunda de la diversidad humana. Estas condiciones generales aseguran que la evaluación psicológica se lleve a cabo con



precisión, empatía y respeto por la dignidad y el bienestar del individuo evaluado.

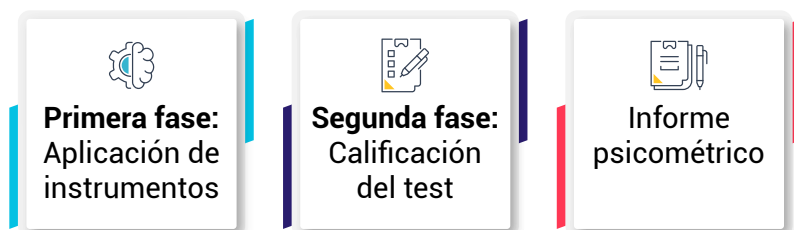
6.1.2. Normas de aplicación

Para desarrollar una adecuada aplicación de los instrumentos es importante tomar en cuenta que el proceso se lo ejecuta en dos fases, la primera corresponde a la aplicación y la segunda a la calificación de los resultados. Una vez cumplidas las dos fases se procede a realizar el informe de los resultados.

A continuación, se explicará el desarrollo de cada una de las fases y condiciones a considerar en cada una de ellas, en la figura que se detalla a continuación se encuentra el esquema general del proceso para llevar a cabo la aplicación de instrumentos psicológicos.

Figura 7.

Fases para la aplicación de instrumentos



Nota. Adaptado de Instrumentos de evaluación psicológica [Ilustración], por González F., 2007, Editorial Ciencias Médicas.

Una vez que usted ha podido identificar el mecanismo a seguir, a continuación, se explicará cada una de las fases y datos importantes a considerar en el proceso de administración de un test psicológico, ya sea este proyectivo u objetivo.

■ **Primera fase: aplicación de los test**

Los objetivos para la aplicación de los test los determinará el evaluador de conformidad con la persona evaluada, en ese sentido la aplicación podrá ser de manera grupal o individual, tomando las instrucciones del instrumento a aplicar y también las siguientes sugerencias:



- Contar con los conocimientos para la aplicación y calificación.
- Familiarizarse con el instrumento.
- Seguir las instrucciones y directrices éticas para la aplicación.
- Mantener una actitud científica e imparcial.
- Evitar expresiones mímicas que brinden información al examinado.
- Mantener una actitud amable con el examinado (González, 2007).

Valorar una persona que requiere de servicios psicológicos, puede generar cierto nivel de estrés; al no disponer de una experiencia o experticia en la aplicación de algún test en particular, es por ello que además de las características que usted ha podido leer anteriormente, se pueden añadir algunas otras, que permitirán facilitar el proceso de aplicación. A continuación, de acuerdo con González, F. (2007) se muestran algunas consideraciones para la aplicación de instrumentos.

Existen algunas características que todo profesional en psicología debe tomar en cuenta al momento de realizar la aplicación de instrumentos, para lo cual se describen a continuación.

- Tomar en cuenta las condiciones ambientales durante la aplicación de los test psicológicos, tales como iluminación, evitar ruidos, interrupciones, etc.
- Escuchar con atención y ofrecer instrucciones claras y precisas al evaluado. Por ejemplo, “por favor tome la hoja y escriba su nombre”, “Por favor coloque la hoja boca abajo”.
- Observar el estado físico y psicológico del examinado durante todo el proceso de aplicación.
- Cuidar que las respuestas que se den no ofrezcan orientación al tipo de respuesta que se espera. Se puede usar frases expresando: “Como a usted le parezca mejor”.
- Evitar una excesiva rigidez que exprese un aspecto inhumano.
- Estar atentos a posibles accidentes del examinado, tomar contacto con familiar y dar aviso, o auxiliar en la búsqueda de ayuda con base en el peligro.



Como usted ha podido identificar, el psicólogo debe ser capaz de establecer una relación de confianza con el evaluado, explicar claramente el propósito de las pruebas y tranquilizar cualquier ansiedad que pueda surgir.

Por ende, como indica González (2007) no se puede dejar de lado aquellas habilidades del evaluador enfocadas a la observación de conducta, ya que estas características deben también ser registradas. Es posible que durante la aplicación se muestren indicadores de ansiedad (sudoración, salivación, tics, lágrimas, tartamudez, respiración agitada, etc.) o indicadores de depresión (llanto, disminución de movimiento, lenguaje reducido, fascia deprimida).

La siguiente tabla le servirá como guía al momento de observar al examinado cómo desarrolla su trabajo, entendiendo que la observación es una de las técnicas más utilizadas en la psicología y está presente en todas las fases de evaluación. A continuación, se detallan una serie de actitudes, y conductas a nivel de lenguaje no verbal que pudieran ser de gran interés.

Tabla 5.

Aspectos a considerar en el lenguaje no verbal durante la evaluación

Expresión facial	Preocupada o despreocupada, deprimida, risueña, extraña, etc.
Postura	La persona está recostada, relajada, entrecruzada de piernas, etc.
Conducta	Ruborización, sudoración, tics nerviosos, fuma o camina en exceso, temeroso, gestos expansivos.
Expresión oral	Tomar en cuenta la velocidad de lenguaje, pierde el hilo de lo que habla, silencios, lenguaje cansado.
Apariencia física	Observar su higiene personal, está arreglado, limpio, desaliñado, vestimenta acorde a la temporada, cicatrices, etc.
Actitud ante la tarea	Muestra predisposición a realizar la tarea, cooperador o actitud de rechazo, evasivo, temeroso, duda de su trabajo.
Actitud ante el examinador	Se muestra cooperador, hostil, tranquilo, colaborador, afable, receloso, hace muchas preguntas

Nota. Tomado de Instrumentos de evaluación psicológica (pp. 34-35), por González F., 2007, Ciencias Médicas

Como usted pudo observar, la observación desempeña un papel esencial en la aplicación de pruebas psicológicas, complementando la información recopilada a través de los cuestionarios, escalas y otras herramientas de evaluación. A través de la observación se puede percibir muchas actitudes y comportamientos, ya que la observación implica la



recolección sistemática y objetiva de información del evaluado, lo que permite conseguir una comprensión más completa y contextualizada del funcionamiento y la dinámica del individuo.

▪ **Segunda fase: calificación de los test**

La calificación e interpretación de las pruebas debe realizarse con cuidado y conocimiento, considerando múltiples factores antes de realizar conclusiones diagnósticas, ya que cada *test* dispone de su propio sistema de calificación, y por ende se debe ser estrictos al momento de analizarlo. Es así que, usted podrá dar lectura a algunas características al momento de calificar diferentes tipos de pruebas descritos por Aiken (2022):

Calificación de pruebas de ensayo: la calificación puede basarse en la calidad de la respuesta y ser lo más objetivos posible. El procedimiento de calificación de los reactivos de ensayo debe estar estructurados y ser objetivos.

Calificación de pruebas objetivas: para estos casos se pueden elaborar plantillas o tiras claves para calificar a mano los cuadernillos, para ello se puede emplear una hoja de cartón marcando las respuestas correctas o perforando en los espacios correspondientes. Por ejemplo, el *test* de Raven.

Calificación a máquina: hay opciones en las cuales las hojas de respuesta se las envía a un servidor especial para que las califique, por ejemplo, MicroCAT (Assesment Systems Corporation) el cual ofrece servicios de construcción, aplicación y análisis de pruebas.

Calificación de reactivos de clasificación: estas pueden calificarse asignando 1 punto a las respuestas correctas y 0 puntos a las erróneas y las omisiones. Debido a la gran cantidad de órdenes distintos en que puede colocarse un grupo de reactivos, para ello se puede utilizar fórmulas dependiendo de los objetivos del evaluador (pp. 71 – 75).

▪ **Informe psicométrico**

El informe psicométrico corresponde a plasmar los resultados del proceso de la fase 1 y fase 2 anteriormente expuestos. En ese sentido, el documento deberá contener datos generales de identificación, los resultados de observación, a ello se le adjuntan los *test* aplicados con su calificación, hoja de respuestas y sus perfiles, así como las recomendaciones que el psicólogo sugiere González, (2007).



A continuación, le invitamos a revisar el formato que se presenta en el [anexo 11. Formato del informe de resultados de test proyectivos](#). El mismo que contiene información básica para desarrollar un informe de resultados de la aplicación de test psicológicos, este documento contiene datos informativos, la ficha técnica de los instrumentos proyectivos aplicados, recuerde que la ficha técnica proporciona información esencial sobre las características, el desarrollo, la administración de la prueba, nombre de los autores o desarrolladores del test, año de publicación, normas de aplicación, confiabilidad, validez, puntuación e interpretación, aplicaciones y usos, citas y referencias a estudios o investigaciones que respaldan el desarrollo y la validez del test. Finalmente, en el informe psicométrico se agrega los resultados de los test aplicados, conclusiones y recomendaciones.



Recuerde que dicho insumo deberá ser utilizado durante el desarrollo de actividades en su centro de práctica.

6.1.3. Ética

El profesional de psicología debe adherirse a los principios éticos y de confidencialidad al administrar las pruebas y manejar la información del evaluado. La privacidad y la protección de los datos son fundamentales para establecer una relación terapéutica de confianza.

La Asociación Americana de Psicología (APA), y otras instituciones hacen mucho énfasis a los temas de la aplicación, normalización, confiabilidad y validez de las pruebas, y estos destacan la importancia de considerar el bienestar del examinando o cliente y de protegerlo del mal uso de los instrumentos de evaluación.

La ética se refiere a los principios de la conducta moralmente aceptados por una persona o grupo. El estudio sistemático de la esencia de los conceptos de valor, se refiere a lo “bueno”, lo “malo” y lo que debe hacer una persona o grupo (Ardila, 2011).

Cuando hablamos de ética no solo basta comprender su significado, sino también utilizarlos en la práctica, sobre todo en la toma de decisiones. A continuación, de acuerdo con Franca-Tarragó (2003) se explican los tres principios básicos de la psicoética que dignifican al ser humano.



Cuando hablamos de ética no solo basta comprender a que hacen referencia, sino también utilizarlos en la práctica, sobre todo en la toma de decisiones. A continuación, usted conocerá algunos principios básicos de la psicoética.

Principio de beneficencia: hace mención a “hacer el bien o no perjudicar” es decir, el deber de no dañar a las personas, hacer el bien ayudando a solucionar las necesidades humanas. Los psicólogos deben esforzarse por promover el bienestar y tratar a los individuos de manera beneficiosa. También deben evitar causar daño intencional o inadvertido a sus clientes. Esto implica sopesar los posibles beneficios y riesgos de las intervenciones y tomar decisiones.

Principio de autonomía: Kant ya mencionaba que significa a la capacidad de gobernarse por una norma que él acepta sin coerción. En ese sentido, los psicólogos deben respetar la autonomía de sus clientes y tratarlos con dignidad y respeto. Esto implica informar a los individuos sobre sus opciones y permitirles tomar decisiones informadas sobre su tratamiento. También significa no discriminar ni tratar a las personas de manera injusta.

Principio de justicia: respetar la autonomía de sus clientes y tratarlos con dignidad y respeto. Esto implica informar a los individuos sobre sus opciones y permitirles tomar decisiones informadas sobre su tratamiento. También significa no discriminar ni tratar a las personas de manera injusta.

Conoce a detalle a qué hace referencia cada uno de estos principios éticos básicos, que guían el comportamiento profesional de los psicólogos en sus interacciones con los clientes, colegas y la comunidad en general; le permitirán como futuro psicólogo ejercer la profesión con calidad, así que no se puede dejar de lado otro instrumento denominado consentimiento informado.

En todo proceso de evaluación se necesita de un consentimiento informado de quienes se someten a una prueba o de sus representantes legales. El consentimiento informado implica que una persona acepta entregar información privada, es por ello que el evaluador debe explicar el carácter y los objetivos de la evaluación, quien tendrá acceso a la información y cómo se usará esta. Para ello se invita a revisar el [anexo 12. Consentimiento informado](#), en el cual usted encontrará datos informativos que deberá completar la persona evaluada, es importante recalcar que dicho



instrumento debe contener la firma que legalice y autorice la valoración psicológica.

6.1.4. Fiabilidad y validez

La fiabilidad y la validez son dos conceptos fundamentales en el campo de la evaluación y medición psicológica, y se refieren a la precisión y a la utilidad de un instrumento para medir de manera confiable y válida las características o constructos que se pretenden evaluar. Estos términos son especialmente relevantes en el contexto de los *test* psicológicos, pero también se aplican a otros tipos de instrumentos de medición. Fernández-Ballesteros (2013) detalla lo siguiente:

“Fiabilidad”, según el Diccionario de la Real Academia, hace referencia a la probabilidad del buen funcionamiento de una cosa. Técnicamente, el término “fiabilidad” fue introducido en la psicología por Spearman en una serie de trabajos publicados entre 1904 y 1913 en la revista *American Journal of Psychology*. Un *test* será más fiable cuanto mayor sea la proporción de variabilidad de las puntuaciones recogidas que se deba a la variabilidad de las puntuaciones verdaderas, y menor, la que se deba a la del error (p.133).

Por otro lado, la validez se refiere a la capacidad de un instrumento para medir realmente lo que pretende medir. Es decir, un instrumento es válido si mide de manera precisa y exacta el constructo o característica que se busca evaluar. Una prueba válida es aquella que realmente mide lo que se supone que debe medir y que proporciona resultados que reflejan con precisión las características que se quieren evaluar.

Validez se ha definido como el grado en que una prueba mide lo que está diseñada para medir. Una desventaja de esta definición es la implicación de que una prueba solo tiene una validez, la cual supuestamente es establecida para un solo estudio para determinar si la prueba mide lo que se supone debe medir. En realidad, una prueba puede tener muchas clases de validez, dependiendo de los propósitos específicos para los cuales fue diseñada, la población objetivo, las condiciones en que se aplica y el método para determinar la validez (Aiken, 2022, pp. 94,95).





Una vez que ha culminado con la revisión de las diferentes fases para aplicar instrumentos y las consideraciones éticas y técnicas a tomar en cuenta, es indispensable desarrollar las siguientes actividades para reforzar y consolidar los aprendizajes. ¡Adelante!



Actividades de aprendizaje recomendadas

Para mayor comprensión de estos temas, desarrolle las siguientes actividades que le ayudarán a profundizar sus conocimientos y a adquirir las competencias requeridas en esta asignatura:

1. Elabore un organizador gráfico de las fases de aplicación de *test* psicológicos.

Procedimiento:

- Lea con detenimiento la unidad 6, centrando la atención en los *test* psicológicos.
 - Identifique el proceso que debe seguir para aplicar un *test*.
 - Elabore un organizador gráfico de las fases de aplicación de *test* psicológicos.
2. Para ampliar información sobre el uso del consentimiento informado, por favor desarrollen las siguientes actividades:

Procedimiento:

- Observe con atención el siguiente video [Principios éticos para el establecimiento del consentimiento informado en salud mental](#) de la Organización Ética Psicológica (2023). En el cual se realiza una entrevista a un profesional en la rama y detalla algunos aspectos importantes sobre el uso de dicho instrumento.



- Elabore un resumen dando contestación a las siguientes interrogantes con base en el video observado.
 - ¿Para qué sirve el uso del consentimiento informado?
 - ¿Describa los beneficios del uso del consentimiento informado?
 - Detalle 3 mitos sobre el consentimiento informado.

Nota: conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

Durante las semanas anteriores usted ha desarrollado las competencias necesarias para realizar una correcta evaluación psicológica. Por lo tanto, usted dispone de la información de su estudio de caso para la elaboración del informe del caso 1. Es momento de revisar el [anexo 13. Formato de informe psicológico](#). En el cual usted detallará toda la información recabada en todas las fases de la entrevista psicológica.



Semana 10

En la presente semana ampliaremos información sobre la evaluación psicológica para comprender y medir una amplia gama de características y aspectos de la mente humana. Usted logrará potenciar su conocimiento en técnicas de evaluación psicológica para una práctica ética y eficiente en el campo.

6.2. Técnicas psicométricas objetivas

Las técnicas psicométricas objetivas son métodos de evaluación psicológica que se basan en la medición cuantitativa y objetiva de características psicológicas. Cuando se habla de técnicas objetivas, Cronbach (1968), detalla que es objetivo cuando se asigna el mismo valor a una ejecución. Por otro lado, el término psicometría significa medida de los fenómenos psíquicos (González, 2007, p. 8).

A continuación, de acuerdo con González, F. (2007) se detallarán algunas características generales de las técnicas psicométricas. Estas técnicas buscan medir aspectos específicos del comportamiento, la cognición o las emociones de una manera estandarizada y consistente, lo que permite



obtener puntuaciones numéricas que pueden compararse y analizarse de manera sistemática.

- Miden la ejecución de las personas en el desarrollo del instrumento y comparan resultados con los obtenidos por otros sujetos.
- Son instrumentos de evaluación de rasgos que forman parte de la estructura básica de la personalidad.
- La explicación de la conducta se denomina rasgos que son entendidos como constructos hipotéticos y teóricos inferidos de la observación.
- No tiene en cuenta el contexto en el que está inmersa la persona que desarrolla el test.

Como pudo observar en la figura anterior, estas técnicas se utilizan ampliamente en la investigación y la práctica clínica para medir y comprender diferentes aspectos del funcionamiento psicológico. Dentro de este grupo se pueden encontrar los cuestionarios de personalidad, test de inteligencia, cuestionarios de depresión y ansiedad.

Para ampliar la información y continuar con el estudio de la temática, en la siguiente tabla usted conocerá de manera breve una serie de instrumentos psicológicos que permiten evaluar diversos aspectos que forman parte de la psique, así como la personalidad, inteligencia, estado de ánimo, entre otros, y la característica que corresponde a cada uno de ellos en cuanto a su aplicación.



Tabla 6.

Tipos de instrumentos psicológicos objetivo

Construto que evalúa	Test	Característica
Inteligencia	Test de matrices progresivas de Raven (1936)	Consta de 60 matrices agrupados en cinco series A, B, C, D, E. En la cual debe completar la serie faltante. La versión de niños (5 y 11 años) se encuentra en colores y consta de 3 series A, B, C.
	Escala de Stanford Binet (SB-IV)	Consiste en una jerarquía de 3 niveles, el primer nivel: inteligencia general (g), el segundo: habilidades cristalizadas, fluido-analíticas y memoria a corto plazo; y el tercer nivel: razonamiento verbal, abstracto-visual y cuantitativo.
	Escala de Inteligencia para Adultos de Wechsler	Aplicada en adultos de entre 16 y 74 años y consta de seis subpruebas verbales (V): información, vocabulario, aritmética, comprensión, semejanza y cinco subpruebas de ejecución (E): diseño de cubos, símbolo en dígitos, ensamble de objetos, completamiento y ordenamiento de dibujos.
	Escala de Inteligencia para niños de Wechsler (WISC-III)	Diseñada para niños de entre 6 y 16 años consta de 6 subpruebas verbales: Información Semejanzas Aritmética Vocabulario Comprensión intervalo de dígitos, y siete de ejecución: completamiento de dibujos e imágenes Codificación Acomodamiento de dibujos Diseño de cubos Ensamble de objetos Búsqueda de símbolos, Laberintos.



Construtto que evalúa	Test	Característica
Personalidad	Inventario de personalidad 16-PF de Raymony Cattell	Puede ser aplicada individual y colectiva a partir de los 16 años, presenta 6 formas (A, B, C, D, E Y F) según el nivel de enseñanza media o superior. Mide la estructura de la personalidad en 16 factores con un total de 105 ítems y tres opciones de respuesta. El perfil de personalidad se obtiene por el cálculo de los factores QI: Adaptación-Ansiedad, QII: Introversión-extraversión, QIII emotividad – dinamismo, QIV: Sumisión-Interdependencia, Neuroticismo.
	Inventario multifacético de la personalidad (MMPI)	Prueba puede ser aplicada a partir de 16 años, no menos 6to año de escolaridad. Consta de 550 ítems, clasificando la información en ciertas, falsas y no sé. Está constituido por 3 escalas. De validación, escala clínica y suplementaria.
	Test de Personalidad de Eysenck (1964)	El instrumento aplicado a partir de los 16 años posee dos formas A y B, con ambos polos Extraversión vs Introversión y Neuroticismo vs Control consta de 57 ítems
Estados de ánimo (ansiedad y depresión)	Inventario de Ansiedad y Rasgo (IDARE) de Ch, Spielberger.	Evalúa la ansiedad como estado (condición emocional transitoria) y como rasgo (propensión ansiosa relativamente estable). Consta de 10 ítems con respuesta en escala Likert.
	Inventario de Ansiedad de Beck (1988)	Compuesto por 21 ítems que describen síntomas de ansiedad de los criterios diagnósticos del DSM-IV
	Inventario de Depresión de Beck (1961)	Evalúa la intensidad de la depresión a nivel cognitivo, afectivo, somático en adultos. Consta de 21 ítems con 4 o 5 afirmaciones. Además, tiene puntos de corte establecidos en depresión ausente: puntuación media de 10,9; depresión leve: puntuación media de 18,7; depresión moderada: 25,4 y depresión grave puntuación media de 30 puntos.
	Autoescala de Depresión de Zung y Conde (1965)	Escala de 20 ítems que investiga la frecuencia y aparición de tristeza, desesperanza, llantos, autocastigos, rumiación suicida, etc. El test cuenta además con puntos de corte para su interpretación. No depresión de 20 – 33, depresión leve: 34-40, depresión moderada 41-54 y depresión severa: 55-80



Constructo que evalúa	Test	Característica
Estrés y afrontamiento	Escala de Afrontamiento de Lazarus (1984)	Este instrumento consta de 67 ítems, clasificados en 8 subescalas. Se otorga una calificación de 0 a 3, y se determina el tipo de afrontamiento: confrontación, distanciamiento, autocontrol, búsqueda de apoyo social, aceptación de la responsabilidad, huida, planificación, reevaluación positiva
	Inventario para la evaluación del estrés laboral "Burnout" de Maslach y Jackson (1986)	Inventario posee tres escalas: cansancio emocional, despersonalización y realización personal. Este pretende medir la relación entre la persona y su ambiente laboral.
	Lista de indicadores de vulnerabilidad al estrés	Adaptación de Dionisio Zaldívar, es un listado de 20 indicadores de estrés en la que el sujeto evaluado debe contestar en base a una escala Likert de 0 a 4, estos ítems evalúan alteraciones de hábitos, nivel de energía, trastornos psicosomáticos, etc.

Nota. Adaptado de Test psicológicos y evaluación (pp. 152-330), por Aiken L., 2022, Pearson Education

Una vez que ha dado lectura a los diversos instrumentos objetivos, usted ha logrado comprender que, estas técnicas se caracterizan por su estructura y su enfoque en obtener respuestas estandarizadas y comparables. Sin embargo, es importante señalar que el uso de técnicas psicométricas objetivas requiere una administración y una interpretación adecuadas por parte de profesionales capacitados para garantizar que los resultados sean precisos y útiles.

6.3. Técnicas proyectivas

Los test proyectivos son una categoría de pruebas psicológicas utilizadas en el campo de la evaluación y diagnóstico psicológico. Se caracterizan por presentar estímulos ambiguos o poco estructurados a los individuos evaluados, quienes deben interpretarlos o proyectar sus pensamientos, sentimientos y emociones a través de sus respuestas. Estas pruebas se basan en la teoría psicoanalítica y la idea de que los individuos pueden proyectar sus pensamientos inconscientes en las respuestas proporcionadas.



La palabra “proyección” fue formulada por Freud en 1894 entendida como un mecanismo de defensa patológico que permite proyectar el inconsciente, más adelante este mismo autor detalla que dicha proyección también surge cuando no se presenta un conflicto (González, 2017).

Lawrence realizó algunas investigaciones en el año 1939, en donde señaló que el término “técnica proyectiva” se refiere a los procedimientos de evaluación psicológica en los cuales las personas “proyectan” sus necesidades y sentimientos internos en estímulos ambiguos, en los que se pide a la persona describir, contar una historia al respecto. Completar o responder de alguna otra forma (Aiken, 2022, p. 429).

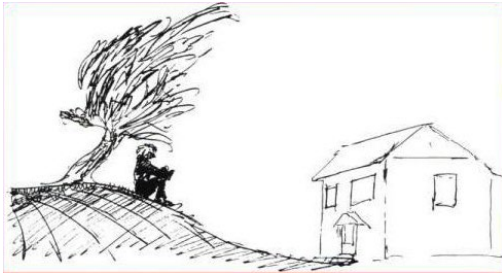
A continuación, de acuerdo con González, F. (2007) se citará algunos **tipos de técnicas** y las características que forman parte de cada una de ellas; estas difieren por las tareas que se ejecutan en cada prueba y en función de la consigna que se brinda al evaluado.



- **Técnicas proyectivas gráficas**

Figura 8.

Técnicas proyectivas gráficas



Nota. Tomado de Psicología Hoy [Fotografía], por Vega M, 2014, (<https://www.psicologiahoy.com/http/>), CC BY 2.0

Este tipo de test gráficos no poseen con un sistema objetivo de puntuación, lo que resulta poco confiables y válidas. Estos servirían para la creación de hipótesis sobre la personalidad y conflictos existentes. Dentro de esta categoría encontramos el dibujo de la persona, que se interpreta en términos de uso de las características como ropa, posición, rasgos faciales, etc. También encontramos el dibujo de la familia, House, tree, person (HTP), dibujo de la persona bajo la lluvia.



■ Técnicas proyectivas de completamiento

Figura 9.

Técnicas proyectivas de completamiento

55. Niño	71. Flor	86. Falso
56. Cuidar	72. Vencer	87. Ansiedad
57. Lápiz de mina	73. Caja	88. Besar
58. Triste	74. Salvaje	89. Novia
59. Ciruela	75. Familia	90. Puro
60. Casarse	76. Lavar	91. Puerta
61. Casa	77. Vaca	92. Elegir
62. Querido	78. Amigo	93. Heno
63. Vidrio	79. Suerte	94. Contento
64. Pelear	80. Mentir	95. Ridiculizar
65. Piel	81. Comportamiento	96. Dormir
66. Grande	82. Estrecho	97. Meses
67. Zanahoria	83. Hermano	98. Agradable
68. Pintar	84. Temer	99. Mujer
69. Parte	85. Cigüeña	100. Abusar
70. Viejo		

Nota. Adaptado de Test de asociación de palabras de Jung, por Solo derecho, 2022, (<https://soloderecho.com.bo/test-de-asociacion-de-palabras-de-jung/>), CC BY 2.0

Son aquellos instrumentos en los que el sujeto debe responder con asociaciones libre a estímulos verbales o escritos entre ellos podemos evidenciar el test de asociación de palabras de Jung, test de completar frase o técnicas de completar historias.



■ Técnicas narrativas

Figura 10.

Técnicas narrativas



Nota. Adaptado de Test de apercepción temática: características y funcionamiento, por Psicología y mente, 2022, (<https://psicologiaymente.com/psicologia/test-de-apercepcion-tematica/>), CC BY 2.0

Estas se caracterizan ya que se pide al evaluado que narre algo acerca de un tema en particular o una imagen que se le da. Estas técnicas ponen en evidencia características de la personalidad. La narración puede abarcar temas como el sentido de su vida, como soy, como quisiera ser, mi futuro debe ser, concepto de sí mismo, yo ideal. Etc. Por ejemplo el Test de apercepción temática, etc..

Es importante detallar que, hasta este punto, usted ha logrado interiorizar algunas técnicas proyectivas, todo ello le permitirá ampliar el bagaje de conocimientos que usted dispone y sobre todo seleccionar el que más se acople a lo que pretende evaluar, recuerde que el resultado obtenido de la aplicación de los mismos debe ser corroborado con información obtenida mediante otras pruebas o entrevistas a familiares y/o personas cercanas.

Es por esa razón que, a continuación, le invitamos a revisar la siguiente tabla que corresponden a los test proyectivos de cada una de las categorías revisadas en la tabla anterior y que son utilizadas dentro de la práctica psicológica.



Tabla 7.
Test proyectivos

Categoría	Test	Característica
Técnicas proyectivas gráficas	Dibujo de la figura humana de Machouver	Autor: Karen Machover Descripción: este instrumento se lo aplica de manera individual o grupal dirigido para niños se le pide al evaluado que dibuje una figura humana completa en niños mayores de 12 años se pide otro dibujo del sexo opuesto. Para una correcta interpretación se debe tomar en cuenta el nivel de madurez mental y características de personalidad.
	Dibujo de la casa, árbol y persona (HTP)	Autor: J.N. Back Descripción: se solicita que primero dibuje una casa, en la siguiente hoja se pide que dibuje un árbol y luego una persona. Luego de ello se realiza un interrogatorio en cada dibujo por ejemplo alguien vive en la casa, de que material está hecho, que tipo de árbol es. Al igual que el anterior instrumento se pide que dibuje otra persona del sexo opuesto. El dibujo el árbol ofrece información sobre el propio individuo, la casa sobre el nivel de relaciones y el dibujo lo que el sujeto quiere mostrar o desear ser. Y el cuarto dibujo sobre las relaciones interpersonales o familiares.
Técnicas proyectivas de completamiento	Asociaciones de palabras	Introducido por Galton (1879) y Jung (1910), para detectar conflictos neuróticos. Consiste en leer una serie de palabras en voz alta y el examinado de responder con la primera palabra que le venga en mente.
	Frases incompletas	La persona debe completar enunciados inconclusos. Por ejemplo: Mi mayor preocupación es _____ La cosa que más me molesta _____ Dentro de esta técnica se encuentra varios test, como Formulario Rotter de Frases incompletas, segunda edición (por J. B. Rotter, Psychological Corporation). Test de Frases incompletas de Sacks.
Técnicas narrativas	Pruebas de manchas de tinta	Técnica de Psicodiagnóstico de Rorschach (de Hogrefe y Huber), publicados por primera vez en 1921, son diez tarjetas que contiene una mancha de tinta simétrica de manera bilateral, en blanco y negro, rojo y gris, o de muchos colores. Se pide a los examinados que informen lo que ven en la mancha o lo que puede representar.

Nota. Adaptado de Instrumentos de evaluación psicológica (pp. 268-275), por González F., 2007, Ciencias Médicas



La tabla anterior le permitió a usted identificar los diferentes tipos de test proyectivos más utilizados, sin embargo, se ha creído conveniente enfatizar dos de ellos para la práctica en su centro y la labor del docente, en el cual se profundizará en el test de la persona bajo la lluvia y test de frases incompletas de Sacks, siendo estos dos unos de los más utilizados en la labor profesional. Le invitamos a dar lectura a continuación.

6.3.1. Test de la persona bajo la lluvia

Adaptación: Querol y Chávez (2004).

Descripción: el instrumento puede ser administrado individual o grupal, para toda población etaria. Produce un mínimo de ansiedad en el sujeto de la prueba; para ello se necesita una hoja de papel y un lápiz. Es una prueba proyectiva, ya que el sujeto impregna el dibujo con su propio estilo.

Consigna y administración: se aconseja el uso de papel liso, tamaño A4 (21 x 27.9 cm), es conveniente administrarlo luego de haber entablado una cierta relación con el sujeto. Se entrega el papel a lo largo. Si el sujeto modifica la posición del papel, debe respetársele esta elección. La consigna consiste, simplemente, en solicitarle que *“dibuje una persona bajo la lluvia”*. En la medida en que lo necesite, se tranquiliza al sujeto comentándole que no se busca. Se registra la actitud.

Interpretación: se busca obtener la imagen corporal del individuo bajo condiciones ambientales desagradables, tensas, en los que la lluvia representa el elemento perturbador. En cuanto al uso del papel, si el individuo modifica la posición del mismo, podrá interpretarse como oposición, rechazo de órdenes, sugerencias, etc. Se debe tomar en cuenta todas estas características: dimensiones (dibujo grande, pequeño, etc.), emplazamiento (margen superior, inferior, centro de la hoja, etc.), trazos (línea entrecortada, línea esbozada, curva, etc.), presión (normal, débil, pesada, etc.), tiempo (velocidad normal, precipitada, etc.), secuencia, movimiento, sombreados. Luego se realiza un análisis minucioso del dibujo, considerando orientación de la persona, posturas, tachaduras, detalles de accesorios y su ubicación, vestimenta, paraguas como defensa, partes del cuerpo, identidad sexual y finalmente detallar el conflicto o mecanismo de defensa utilizado (Querol y Chávez, 2004).

A continuación, se invita a revisar el siguiente documento en el cual consta el manual de calificación del [Test de la persona bajo la lluvia adaptado](#)



(Querol y Chávez, 2004). Dicho documento cuenta con ejemplos de dibujos y lo que usted debe utilizar para la interpretación de cada trazo realizado. A partir de las páginas 8 - 18 usted podrá encontrar el análisis de recursos expresivos tales como dimensiones, emplazamiento, trazos, presión, etc. Acompañado de varios ejemplos de dibujos para que se guíe en la interpretación de los mismos. A partir de las páginas 19 – 42 usted evidenciará el análisis en cuanto al contenido del dibujo. Y finalmente, en las páginas 44 - 53 se describen los mecanismos de defensa o conflictos como neurosis fóbica, histérica, obsesiva, depresión, melancolía, psicótico, paranoia, entre otros.

6.3.2. Test de frases incompletas de Sacks

Autor: Joseph M. Sacks (FIS).

Descripción: aparece en 1948 y fue elaborado en colaboración con otros psicólogos de Nueva York. Este instrumento evalúa cuatro áreas de la adaptación del sujeto que facilitarían deducir cuáles son las tendencias dominantes de su personalidad, dichas áreas son:

- **Familia:** contiene preguntas referentes a madre, padre, unión familiar, revelará sus actitudes frente a sus padres, de manera individual y como un todo.
- **Sexo:** contiene 8 ítems, incluye actitudes hacia las mujeres y hacia las relaciones heterosexuales, a las mujeres en lo social, hacia el matrimonio y a las relaciones sexuales.
- **Relaciones interpersonales:** se compone de 16 ítems, se revela la actitud y sentimiento del sujeto hacia las personas fuera de casa, tales como amigos, compañeros, jefes y personas bajo su mando.
- **Autoconcepto:** se compone de ítems con relación a temores, culpa, metas y actitudes, hacia sus habilidades, pasado y futuro.

Consta de una hoja de aplicación con 60 frases incompletas, distribuidos en 15 grupos y 4 áreas, que el sujeto tiene que completar contestando lo primero que le viene en mente. El test original cuenta con 60 preguntas.

Interpretación: para poder realizar la calificación del instrumento se deben emitir dos resultados que se explican a continuación:



Análisis cuantitativo: Sacks recomienda manejar las respuestas en forma psicométrica, reuniendo las respuestas acordes a las actitudes y áreas de exploración y puntuando de 0: no hay conflicto, 1: conflicto moderado y 2: conflicto severo.

Análisis cualitativo: es importante que se logre un diagnóstico psicodinámico del entrevistado a través de la exploración de los aspectos intrapsíquicos que se proyectan en las respuestas (Fatalevich y Tonin, 2021).

Una vez realizada la lectura del test, le invitamos a revisar [anexo 14. Test de frases incompletas de Sacks adultos](#). Dicho instrumento contiene 60 interrogantes en las cuales, la persona evaluada debe completar, seguidamente se encuentra la hoja de corrección que deberá usted como evaluador completar con base en las respuestas, colocando puntuaciones que van de 0 a 2. Para ello, usted puede revisar el siguiente manual [Test de frases incompletas de Sacks \(Sacks, 1948\)](#). En el que se explica también la forma de calificación del mismo.

6.4. Evaluación psicológica en entornos simulados

El uso de la Realidad Virtual (RV) ha demostrado ser una herramienta versátil y prometedora en diversos campos, incluida la evaluación psicológica y la intervención psicoterapéutica. Por ejemplo, para la evaluación de fobias y trastornos de ansiedad, trastorno de pánico estrés postraumático de manera gradual y controlada Botella et al. (2007), lo que facilita también la evaluación de las respuestas emocionales y cognitivas de las personas. Por otro lado, también los entornos simulados permiten la evaluación cognitiva mediante tareas cognitivas y ejercicios diseñados en entornos virtuales, y además se puede rehabilitar funciones cognitivas como la memoria, la atención y el procesamiento de información, y estudiar principalmente las funciones atencionales, mnésicas, ejecutivas y/o visoespaciales de dichos individuos (Rizzo, 1994). Otros estudios como el desarrollado por Gutiérrez et al. (2010) en el cual han destacado su uso para la evaluación de trastornos alimentarios y su relación con la percepción de distorsión de la imagen corporal.

Es por ello que, resulta importante definir qué es la realidad virtual para de esta manera comprender el uso en el campo de la psicología.



Heim, (1993), detalla que la realidad virtual es una experiencia tecnológica que envuelve al usuario en un entorno inmersivo y digital que simula la presencia física en lugares reales o imaginarios. A través de la interacción con este entorno, se crea una sensación de presencia y participación. Por otro lado, Bederson y Shneiderman (2003) señala que la realidad virtual es una tecnología que utiliza gráficos computarizados en 3D para crear entornos interactivos y sumergir a los usuarios en experiencias multisensoriales, permitiéndoles explorar y manipular objetos virtuales como si fueran reales. La RV se define como un conjunto de tecnologías utilizadas para generar imágenes realistas en 3D, sonidos y otras sensaciones que posibilitan la presencia del usuario dentro de un escenario ficticio (Cabero y Fernández, 2018).

Les invitamos a revisar la siguiente tabla, el mismo que consta de enlaces de páginas web en los cuales se evidencia el uso de la realidad virtual aplicado a diversos problemas de salud mental o psicosociales en la psicología, la realidad virtual ofrece un enfoque innovador y efectivo para abordar una amplia gama de desafíos psicológicos y emocionales los cuales conocerá a continuación.

Tabla 8.
Programas de realidad virtual en psicología

Programas	Descripción
PsicoVR	Plataforma que maneja diferentes proyectos con el uso de la realidad virtual. Por ejemplo, APACE, es un escenario virtual para personas con discapacidad, KOKO bullying previene situaciones de bullying a través de experimentar situaciones de víctimas de acoso escolar.
VirtualRet	A través del diseño de escenarios permite realizar intervención para todo tipo de fobias.
Amelia virtual care	Mediante entornos inmersivos permite brindar terapia de exposición para tratamiento de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), permite además evaluar e intervenir en trastornos como la bulimia nerviosa, la anorexia nerviosa o el trastorno por atracón

Nota. Faggioni, P., Pineda, V., 2023

Con la lectura y revisión de cada programa usted ha logrado descubrir el uso de la realidad virtual en la psicología y sus potenciales beneficios y aplicaciones en una variedad de contextos clínicos, terapéuticos y de investigación. Su capacidad para crear entornos inmersivos y controlados, permite la práctica de habilidades en contextos seguros y personalizar



el tratamiento la convierte en una herramienta valiosa para terapeutas, investigadores y personas que buscan mejorar su bienestar psicológico.



Felicitaciones, usted ha logrado terminar la revisión de todos los contenidos propuestos en esta semana. A continuación, se detallan algunas actividades para reforzar lo aprendido.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Para mayor comprensión de estos temas, desarrolle las siguientes actividades, que le ayudarán a profundizar sus conocimientos y a adquirir las competencias requeridas en esta asignatura:

1. Elabore un organizador gráfico sobre los tipos de test objetivos y proyectivos

Lea con detenimiento la unidad 6 relacionadas con las técnicas objetivas y proyectivas.

- Identifique las características esenciales de cada una de estas técnicas.
 - Amplíe información sobre cada uno de los test mencionados en la unidad 6 y otros instrumentos proyectivos que existen.
 - Elabore un organizador gráfico detallando una breve descripción y ficha técnica de los instrumentos investigados.
2. Para profundizar el conocimiento sobre el uso de la realidad virtual en psicología, le invitamos a revisar el siguiente video denominado [Realidades virtuales en la psicología](#) de TEDx Talks, en el mismo usted podrá aprender conceptos y aplicaciones, brindadas por un estudiante de psicología de la Universidad de Belgrano.

A continuación, desarrolle un resumen sobre lo observado, contestando las siguientes preguntas:

- ¿Qué procesos se utilizan al momento de interpretar la realidad y la realidad virtual, para diferenciar lo uno de lo otro?



- ¿Cuáles son los usos de la realidad virtual en psicología?

Nota: por favor complete las actividades en un cuaderno o documento Word.

3. Les invitamos a resolver las siguientes preguntas, las cuales corresponden a la autoevaluación 5, que le servirán de refuerzo y, sobre todo, le permitirán determinar el nivel de conocimiento sobre la presente unidad 6.





Autoevaluación 5



En las siguientes preguntas seleccione la respuesta correcta:

1. Seleccione uno de los objetivos de la aplicación de pruebas.
 - a. Evaluar cambios cognoscitivos o de comportamiento.
 - b. Clasificar y etiquetar a las personas.
 - c. Recabar hipótesis.
2. Complete: hace referencia a la capacidad de un instrumento para medir lo que realmente pretende medir: _____.
 - a. Objetivas.
 - b. Fiabilidad.
 - c. Validez.
3. () Seleccione verdadero o falso. El evaluador debe desarrollar habilidades de observación de conducta durante la aplicación de los instrumentos psicológicos, la interpretación del test es una característica puede tomar en cuenta en el evaluado.
4. Complete el enunciado:
El test psicométrico que evalúa la inteligencia es _____, el mismo que consta de 60 matrices agrupadas en cinco series A, B, C, D, E. Por otro lado, el instrumento que permite evaluar la personalidad y consta de 550 ítems se denomina _____.
 - a. Matrices progresivas de Raven.
 - b. Inventario MMPI.
 - c. Inventario de ansiedad y rasgo IDARE.



5. Seleccione: un test psicométrico que evalúa personalidad: _____.

- a. Inventario de Ansiedad de Beck.
- b. Inventario 16-PF.
- c. Escala de Stanford Binet.

6. Seleccione: un test proyectivo: _____.

- a. Autoescala de Depresión de Zung y Conde.
- b. Lista de indicadores de vulnerabilidad al estrés.
- c. Test de Apercepción temática TAT.

7. () Seleccione verdadero o falso. Las técnicas proyectivas se caracterizan por presentar estímulos ambiguos en las cuales el individuo proyecta pensamientos, sentimientos y emociones.

8. Complete el enunciado:

La _____ en psicología hace referencia a los principios éticos y de _____ al administrar las pruebas y manejar la información del evaluado. La privacidad y la protección de los datos son fundamentales para establecer una relación terapéutica de confianza. Es por ello que para todo proceso de evaluación se necesita _____.

- a. Ética / validez / documento informado.
- b. Ética/ confidencialidad / consentimiento informado.
- c. Ética / privacidad / oficio firmado.



9. Una con líneas según corresponda el nombre del test con la característica que corresponde:

Instrumento	Característica
a. Psicodiagnóstico de Rorschach.	1. Dibujo de la persona, el árbol y la casa. Se realiza después un interrogatorio de cada dibujo.
b. HTP.	2. Consiste en completar el enunciado con frases que se vengan a la mente del evaluado.
c. Test de frases incompletas de Sacks.	3. Son diez tarjetas que contiene una mancha de tinta simétrica de manera bilateral, en blanco y negro, rojo y gris, o de muchos colores.

10. Complete: inventario que mide el síndrome de burnout, posee tres escalas: cansancio emocional, despersonalización y realización personal: _____.
- a. Escala de Afrontamiento de Lazarus.
 - b. Inventario para la evaluación del estrés laboral de Maslach y Jackson.
 - c. Listado de síntomas breves LSB 50.

[Ir al solucionario](#)

¡Felicitaciones! Ha concluido con la evaluación

Retroalimentación:

Con el repaso de los contenidos, usted ha logrado adquirir conocimientos importantes para la evaluación psicológica, asimismo ha conseguido identificar una serie de instrumentos objetivos y proyectivos para la práctica psicológica.



La interpretación de los test proyectivos no debe basarse únicamente en ellos, es necesario comparar las respuestas con otras fuentes de información, como entrevistas y evaluaciones clínicas; dicha interpretación puede ser subjetiva. Si es posible, busque la colaboración y las opiniones de otros profesionales para obtener una comprensión más completa.





Unidad 7. Diseño de propuestas y programas de intervención psicológica

¡Bienvenidos a la unidad 7!

Bienvenidos a la unidad 7 en la cual usted conocerá sobre las propuestas y programas de intervención psicológica. Dentro del campo de la psicología, la intervención psicológica se enfoca en ofrecer apoyo y soluciones a las personas que atraviesan diversas situaciones, como el estrés, la ansiedad, la depresión, conflictos interpersonales o situaciones traumáticas. A través de diferentes enfoques y técnicas, los profesionales de la psicología buscan mejorar la calidad de vida de las personas, potenciar sus recursos internos y promover un bienestar integral.

Es por ello que a continuación se abordará de manera amplia los pasos que se deben seguir para desarrollar programas o proyectos de intervención primaria.

7.1. Propuestas de intervención psicológica

La intervención psicológica se enfoca en ofrecer apoyo y soluciones a las personas que atraviesan diversas situaciones, como el estrés, la ansiedad, la depresión, conflictos interpersonales o situaciones traumáticas, estas intervenciones no solo benefician a los individuos, sino también a grupos y comunidades, fortaleciendo los lazos sociales y mejorando la convivencia en entornos diversos. En ese sentido, es importante detallar lo que menciona Olivares (2021):

La intervención psicológica puede entenderse como un conjunto de estrategias de solución de problemas en las que se resuelven interrogantes como:

- ¿Qué respuesta(s) vamos a evaluar?
- ¿Qué métodos, estrategias e instrumentos de evaluación utilizaremos?
- ¿Qué personas deben intervenir?



- ¿Dónde y cuándo y qué entrenamiento requerirán?
- ¿Qué tratamientos se aplicará?
- ¿Quiénes y dónde lo aplicarán?, etc. (p. 51).

Es importante reconocer que existe diferentes niveles de intervención psicológica y que cada uno pretende diferentes objetivos, los cuales detallaremos a continuación.

7.1.1. Promoción de salud

En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud [WHO], (1986) detalla que la promoción de salud incluye acciones que pretenden potenciar las habilidades interpersonales, cognitivos, emocionales y capacidades de los seres humanos para lograr estilos de vida saludables. Por lo tanto, las intervenciones de promoción de la salud persiguen el cambio de la conducta y modificación del ambiente social y físico. En el campo de la psicología, el rol principal es encargarse de la salud mental, el mismo que contribuiría en el bienestar y sus determinantes (Sanjuán y Rueda, 2014, pp.11-13).

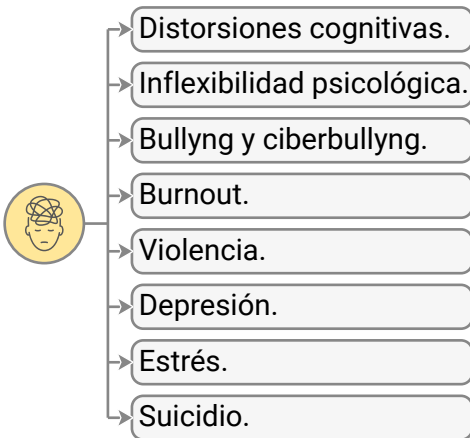
Por otro lado, Fernández-Ballesteros (2013) menciona que los programas de promoción de la salud son un conjunto de acciones, recursos diseñados y aplicados en un entorno específico bajo una planificación previa y sistemática. Así mismo, Glanz et al., (2008) mencionan que la promoción de la salud está dirigida tanto a nivel individual como colectivo y comunitario.

En la siguiente figura, se detallan diferentes temáticas que se pudiesen abarcar dentro del campo de la promoción, estos buscan mejorar el bienestar psicológico y emocional de las personas, prevenir trastornos mentales y fomentar estilos de vida saludables, por lo tanto, son relevantes en una variedad de contextos, como escuelas, lugares de trabajo, comunidades y entornos clínicos.



Figura 11.

Temáticas de promoción de salud mental



Nota. (Faggioni, P., 2023)

Los temas detallados en la figura anterior abarcan una amplia gama de aspectos relacionados con la salud mental y pueden adaptarse a diferentes grupos de edad, culturas y contextos. La promoción de la salud mental es un esfuerzo integral que busca fortalecer las habilidades y los recursos necesarios para llevar una vida emocionalmente saludable y satisfactoria.

7.1.2. Prevención de la enfermedad

Hablar de prevención es identificar que existen niveles de intervención tales como prevención primaria, secundaria y terciaria, estos niveles se refieren a diferentes etapas o niveles de atención que pueden ser implementados en diversos contextos, como la salud, la educación, la psicología y más. Estos niveles de prevención suelen estar diseñados para abordar problemas o necesidades en diferentes etapas de gravedad o complejidad.

A continuación, de acuerdo con Vignolo, et al. (2011) se presenta la siguiente información sobre los niveles de prevención en salud y que comprende cada una de ellas, y se basan en la idea de que prevenir es más efectivo y económicamente viable que tratar una enfermedad una vez que ha ocurrido.

La prevención se entiende como aquellas medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias (OMS, 1998).



Prevención primaria

Se interviene antes de que se genere el problema o enfermedad, permitiendo impedir o retrasar su aparición. Por ejemplo, prevención primaria de la depresión cuyo objetivo sería evitar que las personas desarrollen síntomas de depresión.

Prevención secundaria

Su objetivo es detectar y tratar los problemas o enfermedades en su inicio y retrasar su desarrollo. En el área de salud mental pudiese ser una detección temprana de problemas subclínicos de la ansiedad, cuyo objetivo iría encaminado a implementar intervención para disminuir o eliminar sintomatología.

Prevención terciaria

Son acciones de recuperación. Se lo utiliza cuando la enfermedad o problema está instaurado, por lo que este tipo de intervención pretende eliminar o reducir las consecuencias de su desarrollo. Por ejemplo, aplicación de tratamientos psicológicos a personas diagnosticadas con trastorno.

Una vez revisado la información anterior, usted ha logrado reconocer la importancia de los niveles de prevención en salud, los mismos que contribuyen a reducir la carga de enfermedades y mejorar la calidad de vida de las personas.

De todo lo expuesto anteriormente y comprendiendo los distintos niveles de prevención en las cuales un profesional de la salud mental puede intervenir; a continuación, se explica algunas temáticas importantes que se puede implementar a nivel primario.



Figura 12.

Temáticas de prevención psicológica primaria

55. Niño	71. Flor	86. Falso
56. Cuidar	72. Vencer	87. Ansiedad
57. Lápiz de mina	73. Caja	88. Besar
58. Triste	74. Salvaje	89. Novia
59. Ciruela	75. Familia	90. Puro
60. Casarse	76. Lavar	91. Puerta
61. Casa	77. Vaca	92. Elegir
62. Querido	78. Amigo	93. Heno
63. Vidrio	79. Suerte	94. Contento
64. Pelear	80. Mentir	95. Ridiculizar
65. Piel	81. Comportamiento	96. Dormir
66. Grande	82. Estrecho	97. Meses
67. Zanahoria	83. Hermano	98. Agradable
68. Pintar	84. Temer	99. Mujer
69. Parte	85. Cigüeña	100. Abusar
70. Viejo		

Nota. (Faggioni, P., 2023)

Trabajar en prevención psicológica a nivel primario, implica promover la salud mental y prevenir problemas de salud mental antes de que ocurran; estos temas pueden ser abordados a través de talleres, charlas, recursos educativos y programas comunitarios. Hay que reconocer que este tipo de estrategias tienen un impacto en la sostenibilidad de los sistemas de salud al reducir la demanda de tratamientos costosos y hospitalizaciones.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Una vez que ha realizado un breve recorrido por las diversas intervenciones y temáticas que el profesional de la psicología puede ejercer; es importante que en su centro de práctica indague junto a su tutor/a externa la problemática a abordar en su plan de intervención primaria o de promoción primaria. A continuación, lo invito a desarrollar las siguientes actividades recomendadas para afianzar los conocimientos.

1. Para el desarrollo de la actividad, considere las siguientes estrategias. La promoción de la salud mental es fundamental para el bienestar individual y social. Sin embargo, enfrenta varios desafíos que pueden dificultar su implementación efectiva, que incluyen, estigma y discriminación, Acceso limitado a servicios de salud mental, Falta de conciencia, entre otros. Es por eso que a continuación se invita a realizar la siguiente actividad.



- Escuche el siguiente pódcast denominado [Salud mental y sus desafíos](#) (Sánchez, 1 de agosto, 19m15s) el mismo que contiene entrevista con profesionales en el sector salud y educación.
- Conteste las siguientes interrogantes.
 - a. ¿Cuáles son las estrategias que sugieren los panelistas para aportar a la salud mental?
 - b. ¿Qué herramientas se pueden utilizar en el área educativa para promoción de salud mental?
 - c. ¿Cómo la tecnología puede facilitar para el acceso a servicios psicológicos?

2. Una vez que ha realizado la lectura del artículo sugerido, es momento que extraiga las ideas principales y desarrolle las siguientes actividades:

- Conteste la siguiente interrogante: ¿cuál es la diferencia entre promoción de la salud y prevención?
- Elabore un cuadro que permita diferenciar entre prevención e intervención en los tres niveles primario, secundario y terciario.
- Realice un listado de las actividades que se pueden utilizar en los tres niveles de intervención primaria, secundaria y terciaria.

Nota: por favor complete las actividades en un cuaderno o documento Word.

3. Presente el informe de resultados de los test proyectivos aplicados en el caso 2, para brindar una información precisa y útil de la persona evaluada. Para ello, descargue el [anexo 11. Formato del informe de resultados de test proyectivos](#). Recuerde que dicho documento permite comunicar a la persona evaluada las conclusiones y recomendaciones de lo observado durante el proceso de evaluación psicológica.





7.2. Diseño de una propuesta de intervención psicológica

Estimado estudiante, como ha revisado en semanas anteriores, la promoción de la salud y la prevención psicológica son dos enfoques fundamentales en el ámbito de la salud mental que comparten un objetivo común que es mejorar el bienestar emocional y psicológico de las personas. Aunque ambos conceptos pueden parecer similares, cada uno de ellos se diferencian en su enfoque y alcance. Es por ello que esta semana exploraremos las características distintivas de cada uno y cómo se complementan para abordar de manera integral los desafíos relacionados con la salud mental.

¡Iniciemos!

7.2.1. Desarrollo de programas de promoción de la salud mental

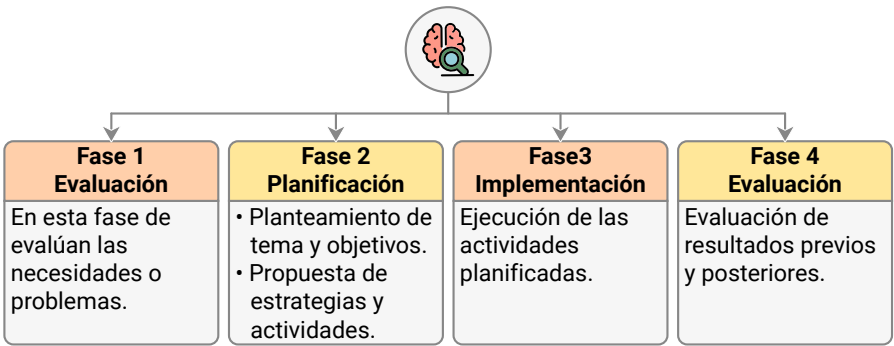
La promoción de la salud mental se enfoca en fomentar el bienestar general y la resiliencia emocional en individuos y comunidades. Busca fortalecer los factores protectores, como las habilidades de afrontamiento, el apoyo social y la autoestima, con el objetivo de prevenir la aparición de problemas de salud mental. La promoción de la salud mental promueve un enfoque proactivo, alienta prácticas saludables y destaca la importancia de un entorno positivo para el desarrollo y el crecimiento personal. Es por ello que a continuación describiremos las cuatro fases que lo conforman (Glasgow y Linnan, 2008, recuperado de Sanjuan y Rueda, 2014).

En la siguiente figura usted podrá identificarlas para el diseño de un programa de promoción de salud mental, estas son un factor clave que ayudan a planificar, desarrollar y ejecutar estrategias efectivas para mejorar el bienestar psicológico de las personas. Estas fases se entrelazan para asegurarse de que el programa sea sólido, basado en evidencia y adecuado a las necesidades de la población objetivo.



Figura 13.

Fases del programa de promoción de salud



Nota. Tomado de Promoción y prevención de la psicología desde la salud, (pp. 22-29), San Juan y Rueda, 2014), Síntesis

Como usted pudo reconocer, cada fase es esencial para el éxito del programa de promoción de salud mental, ya que contribuye a la planificación cuidadosa, la ejecución efectiva y la mejora constante de las intervenciones. Se debe tomar en cuenta que este tipo de programas pueden tener distintos niveles de actuación y estrategias, las cuales pueden estar dirigidos a intervenciones individuales (educación uno a uno, uso de material impreso o audiovisual), grupales (grupos de educación, de apoyo o autoayuda, uso de material impreso o digital) o comunitarias (campañas).

7.2.2. Desarrollo de programas de prevención de la salud mental

Por otro lado, la prevención psicológica se centra en identificar y abordar específicamente factores de riesgo y problemas emocionales y psicológicos en sus etapas tempranas. Su objetivo es prevenir la progresión de trastornos mentales o disfunciones a través de intervenciones oportunas y eficaces. La prevención psicológica se basa en la detección temprana, la evaluación cuidadosa y la implementación de estrategias de intervención adaptadas a las necesidades individuales.

En ese sentido, a continuación de acuerdo con Sanjuán, P. y Rueda, B., (2014) nos presentan un modelo de prevención en salud mental desarrollado por Mrazek y Haggerty (1994) en el cual propusieron que se enfoca en tres niveles distintos de intervención preventiva. Estos niveles están diseñados para abordar problemas de salud mental en diferentes etapas y con distintos enfoques.

Universal: cuando esta es dirigida a toda una población sin importar si los individuos están en riesgo de desarrollar problemas de salud mental. El objetivo principal es promover la salud mental y prevenir la aparición de problemas antes de que se presenten. Las estrategias de prevención universal suelen ser educativas y dirigidas a toda la comunidad., por ejemplo: un programa para prevenir acoso escolar, campañas de concientización, etc.

Selectiva: cuando esta se orienta a grupos con riesgo moderado de desarrollar problemas de salud mental. Estos subgrupos pueden ser definidos por factores como la edad, género, ubicación geográfica, historial familiar, entre otros, por ejemplo: un programa de apoyo a niños con padres que padecen un trastorno mental, programas de apoyo a padres en comunidades de bajos recursos para prevenir problemas de conducta en niños.

Indicada: cuando se dirige a personas con alto riesgo de tener algún problema de salud mental ya sea por presentar síntomas mínimos, o poseen indicadores biológicos, pero aún no poseen un diagnóstico. El objetivo es intervenir tempranamente para evitar la progresión de los problemas y prevenir trastornos más graves. Las estrategias de prevención indicada pueden incluir evaluaciones clínicas, intervenciones terapéuticas breves.

Como usted pudo reconocer, estos tres niveles de prevención en salud mental se basan en la idea de que la intervención temprana y la promoción de la salud pueden tener un impacto significativo en la reducción de la incidencia y la gravedad de los problemas de salud mental. Cada nivel aborda diferentes poblaciones y objetivos, y juntos contribuyen a un enfoque integral de la prevención en salud mental.

Es por ello que en la prevención de los problemas o trastornos mentales se deben tomar en cuenta los factores de riesgo entendidos como variables que aumentan la probabilidad de desarrollar un problema, pueden ser individuales, familiares, comunitarios o estructurales) y los factores de protección que estos permiten aumentar y proteger la salud mental, y a la vez disminuir la probabilidad de que aparezcan, al igual que los factores de riesgos, estos no actúan de manera aislada y pueden ser individuales, familiares, comunitarios o estructurales (Sanjuán y Rueda, 2014, pp.11-13).



En esta distinción entre promoción de la salud y prevención psicológica radica su complementariedad. Mientras la promoción de la salud mental busca fortalecer los recursos y capacidades, la prevención psicológica se enfoca en la identificación y mitigación temprana de problemas específicos. Ambos enfoques trabajan en sinergia para garantizar un enfoque integral en la protección y mejora de la salud mental de las personas.

Como ha podido analizar, los programas de promoción o intervención primaria están compuestos por fases, sin embargo, es indispensable partir por la identificación del problema a intervenir. Al encontrarse desarrollando sus actividades prácticas en una institución, resulta imprescindible que se indague la información y se determine la problemática en coordinación con el psicólogo o directivo responsable del centro, para ello se pueden ejecutar entrevistas para recabar la información. Una vez que cuenta con la información necesaria, usted debe elaborar el informe de resultados de la misma, para ello se invita a revisar el [anexo 15. Formato de informe de entrevista semiestructurada](#), el mismo que está compuesto por datos de la institución beneficiaria, resultados de la entrevista semiestructurada, conclusiones, recomendaciones y anexos.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo las siguientes actividades:

1. Felicitaciones por llegar a este punto. Tras el análisis e identificación de los programas o proyectos de intervención. Usted puede identificar que, pueden existir múltiples problemáticas en las cuales podemos intervenir, es por ello que a continuación le invitamos a leer el siguiente artículo titulado [Propuesta de intervención educativa para la prevención de la conducta suicida en adolescentes en la ciudad de Manizales](#) de Cañón et al. (2018) en el cual usted podrá observar cómo se realiza una intervención educativa para la prevención de la conducta suicida en adolescentes, se detallan los instrumentos de evaluación utilizados para la detección del problema, así como las actividades de intervención utilizadas para mitigar el problema.

Para el desarrollo de la actividad, considere las siguientes estrategias.



- Ingrese al REA y haga una lectura comprensiva.
 - Extraiga las ideas principales y elabore un organizador gráfico tomando en cuenta las siguientes ideas.
- a. Qué instrumentos de evaluación los autores del artículo utilizaron en la propuesta de intervención para la prevención de la conducta suicida.
 - b. Qué estrategias y técnicas se utilizaron para el desarrollo de la propuesta de intervención.

Nota: por favor complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

2. Ahora que usted conoce diversas temáticas que pudiera implementar en su programa de intervención y ha logrado identificar un problema para prevenir o promocionar. Le invitamos a desarrollar las siguientes actividades.
 - Piense en una temática y elabore un “*elevator pitch*” el mismo que consiste en realizar una breve presentación verbal que resume de manera concisa y persuasiva el proyecto.
 - Elabore el guion de su “*elevator pitch*”, el mismo que debe durar entre 30 segundos y 2 minutos, recuerde que el objetivo es captar rápidamente la atención de la persona a la que se le presenta, dejándole una impresión positiva y una comprensión clara de la propuesta.
 - Ensaye varias veces la presentación verbal, cuidado de tu imagen, así como también de la pronunciación de la misma. Puede ser de gran ayuda, practicar con un familiar o amigo.
 - Grábese en video para que puedas observar en qué puedes mejorar.
3. Para realizar un correcto planteamiento de una propuesta de intervención primaria, es importante partir por la identificación de las necesidades en función de las problemáticas psicosociales existentes en su centro de práctica, es por ello que usted realizó una entrevista semiestructurada al tutor externo. Para lo cual usted debe preparar el [informe de resultados de la entrevista \(anexo 15\)](#) el cual será de utilidad para su futura planificación.





7.3. Fases para la elaboración de programas o proyectos de intervención psicológica

Para realizar una correcta planificación de proyectos o programas, es importante considerar las siguientes preguntas ¿qué se quiere hacer?, ¿por qué se quiere hacer?, ¿para qué se quiere hacer?, ¿cuánto se quiere hacer?, ¿dónde se quiere hacer?, ¿cómo se quiere hacer?, ¿quiénes lo van a hacer?, y ¿con qué se va a hacer?

Para desarrollar una correcta planificación de su programa de intervención, se invita a revisar el [anexo 16. Formato plan de intervención primaria](#), este documento consta de título, primera fase, que es la detección de necesidades, introducción, justificación, marco teórico; en la segunda fase se coloca el planteamiento de objetivos, metodología a desarrollar, los beneficiarios, micro localización, y las actividades a ejecutar las cuales van acompañadas de objetivos, técnicas y estrategias, cronograma y recursos; finalmente en la tercera y última fase se detallará la evaluación del programa de intervención, referencias bibliográficas y anexos.

Una vez resueltas dichas interrogantes es importante seguir los pasos para su elaboración según Pérez (2021), quien toma en cuenta las fases que se detallan en el siguiente módulo didáctico, estas fases se entrelazan para asegurarse de que el programa sea sólido, basado en evidencia y adecuado a las necesidades de la población objetivo.

Fases para el diseño de propuestas de intervención.

Una vez revisado el módulo didáctico, usted podrá notar que, seguir los pasos para el diseño y la implementación de un programa de promoción de salud es fundamental por varias razones, ya que garantizan la efectividad, la relevancia y el impacto positivo del programa en la población objetivo, además, ayuda a evitar problemas y desafíos comunes que podrían surgir en la ausencia de un enfoque estructurado.



A continuación, le invitamos a revisar la siguiente tabla, la misma que contiene información sobre algunos modelos de programas de prevención e intervención psicológica, cada uno de ellos utiliza una estructura, instrumentos de evaluación y estrategias diferentes con el fin de abordar la problemática que pretenden mitigar.

Tabla 9.
Modelos de programas de prevención e intervención psicológica

Nombre	Autor	Características
Guía metodológica Prevención del embarazo en niñas y adolescentes	Ministerio de Educación del Ecuador (2019)	Se sugiere la lectura de la parte 2 y 3, el mismo que contiene actividades psicoeducativas relacionadas a la educación sexual, derechos sexuales, afectividad. Cada uno de ellos se encuentran distribuidos por niveles de educación (básica y bachillerato)
Modelo psicoeducativo para la prevención del suicidio en jóvenes	Chávez et al., (2008)	En este documento usted encontrará un estudio realizado a un grupo de jóvenes, en el cual se brindó un taller fue basado en el enfoque de factores de riesgo y de protección identificados en la localidad, se expusieron diferentes informaciones mediante distintas técnicas grupales. Se aplicaron cuestionarios iniciales y finales de evaluación de conocimientos relativos al suicidio con la finalidad de comprobar si los participantes retuvieron los conceptos expuestos.
Evaluación de un programa psicoeducativo para el consumo de sustancias psicoactivas para la infancia.	Hernández (2015)	El presente artículo detalla el estudio realizado para la prevención de consumo, en la fase de evaluación se aplicó instrumento estructurado para indagar Autoesquemas, Hábitos de vida y Habilidades para la vida como factores mediadores en el consumo de sustancias psicoactivas a niños, niñas, padres, madres y profesorado. Posteriormente se creó el programa YOMI VIDA dirigido a la formación a mediadores sociales (profesores), para ser replicado a estudiantes, el programa está compuesto por tres módulos: Autoesquemas, Habilidades para la Vida y Hábitos de Vida, considerados factores mediadores en el consumo de sustancias psicoactivas.

Nota. Faggioni, P., Pineda, V., 2023





Actividades de aprendizaje recomendadas

Las actividades sugeridas a continuación le permitirán reconocer e interiorizar, pero más importante aplicar desde su realidad las diferentes estrategias de intervención para estas problemáticas.

1. Estimado estudiante, le animamos a realizar las siguientes actividades siguiendo estos pasos:
 - Ingrese a los documentos presentados para las intervenciones de suicidio, consumo de sustancias y embarazo adolescente de la tabla modelos de programas de prevención e intervención psicológica.
 - Realice una lectura comprensiva de los documentos.
 - Subraye y extraiga las ideas principales.
 - Elabore un resumen con las ideas principales, y desarrolle las siguientes preguntas:
 - ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación utilizados por los autores para el desarrollo de programas de prevención del suicidio, consumo de sustancias y embarazo adolescente?
 - ¿Qué estrategias y técnicas de intervención utilizaron para psicoeducar a la población beneficiaria?

Nota: por favor complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

2. Estimado estudiante, una vez que conoce las fases a desarrollar dentro del plan de intervención, es momento de elegir el tipo de intervención a ejecutar en su centro de práctica. En esta actividad usted podrá dar inicio a la planificación correspondiente al diseño de su propuesta, la misma que debe incluir:

Fase 1

- Título.
- Introducción.
- Justificación.
- Marco teórico.



Fase 2

- Objetivos: general y específicos.
- Metodología: beneficiarios, micro localización, operacionalización.
- Cronograma, recursos.

Para el desarrollo de la actividad es importante que revise el [anexo 16](#).
[Formato plan de intervención primaria.](#)



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 264 millones de personas en todo el mundo sufren de depresión. A nivel global, cerca de 800,000 personas mueren por suicidio cada año, lo que equivale a una muerte cada 40 segundos. El suicidio es la segunda causa principal de muerte entre personas de 15 a 29 años. Considerar dichas temáticas puede ser de gran relevancia, ya que reduciría el estigma asociado y facilitaría el acceso a servicios de apoyo psicológico.



Semana 14

Fase 2

7.4. Recursos y técnicas de intervención primaria

Apreciado estudiante, en la semana anterior usted ha revisado diversos modelos de programas de promoción e intervención utilizados en diferentes contextos y poblaciones, y además usted ha aprendido que la intervención psicológica primaria se refiere a aquellas estrategias y técnicas aplicadas de manera temprana y generalizada para promover el bienestar emocional y prevenir problemas de salud mental antes de que se desarrollen. Ante ello, en la presente semana se abordarán los recursos y técnicas que permiten cumplir con los objetivos de una intervención.

En ese sentido, es importante distinguir entre “terapia” y “técnica” en el contexto de la intervención psicológica. Ya que la terapia se refiere a un proceso más amplio y completo de tratamiento que tiene como objetivo abordar problemas emocionales, psicológicos o de comportamiento en una persona, es una forma de intervención más profunda y personalizada



que implica una relación terapéutica entre el terapeuta o profesional de la salud mental y el individuo o grupo que busca ayuda. La terapia implica una evaluación y diagnóstico cuidadoso del problema, seguido de una planificación y aplicación de estrategias terapéuticas específicas. Por otro lado, una técnica se refiere a una herramienta, estrategia o método específico que se utiliza dentro de un enfoque terapéutico o en otras intervenciones psicológicas. Las técnicas son componentes más específicos y concretos que se aplican dentro del contexto de una terapia o intervención para alcanzar objetivos más particulares.

Sin embargo, es importante diferenciar que en cada tipo de intervención existen diversas técnicas, es por ello que le invitamos a revisar el siguiente contenido que se expone a continuación.

7.4.1. Técnicas basadas en la información desde el modelo cognitivo conductual

- **Psicoeducación:** estas se encuentran dirigidas a aumentar el conocimiento sobre un tema determinado, situación o conducta. Esto se lo puede ejecutar en tres niveles: individual, familiar o grupal. El objetivo principal es el de informar sobre lo que vive el sujeto o lo que ocurre cuando se trata de un diagnóstico, reducir las recaídas, aliviar sobrecarga emocional, eliminar tabúes y prejuicios y mejorar una adherencia al tratamiento (Tena-Hernández, 2020).
- **Biblioterapia:** consiste en brindar apoyo emocional y pretende a su vez mejorar la calidad de vida de un individuo por medio de los libros y la lectura, este requiere de todo un método de aplicación por seguir para que produzca un efecto visible (Naranjo, et al. 2017).

7.4.2. Técnicas dirigidas a la reducción de ansiedad

- **Entrenamiento en respiración:** este es uno de los procedimientos más sencillos, y útiles para el control de la activación, lo constituyen las técnicas de control de la respiración. Para llevar a cabo este proceso se lo realiza en varias fases. Existen algunas variaciones y una de ellas es la respiración profunda, la cual consiste en realizar una inspiración profunda, seguida de un período de retención (entre cinco y diez segundos) y una lenta exhalación del aire.



- **Entrenamiento en relajación:** tienen por objetivo reducir aspectos fisiológicos o cognitivos propios de la ansiedad. Dentro de este grupo se puede identificar la relajación diferencial Jacobson en 1929, cuyo objetivo es conseguir que la persona identifique las señales de sus músculos cuando están en tensión muscular y conseguir la relajación de los músculos (Labrador, 2008).

7.4.3. Técnicas grupales

Dentro de la intervención a nivel social, se puede identificar dos de ellas, según Pérez, (2021).

- **Brainstorming:** consiste en que todos los miembros del grupo expresan, durante un periodo de tiempo, las ideas que les sugiere un tema concreto, sin establecer condiciones previas, un moderador recoge todas las aportaciones, para ello el participante dispone de 2 minutos para aportar, luego de ello se escribe en el papelógrafo o pizarra el tema sobre el que se tiene que centrar el grupo. Posteriormente, se hace un análisis de todo lo aportado. Finalmente, se elabora una lista definitiva de ideas, para seleccionar las que parecen más interesantes.
- **Técnica de parejas rotativas:** este permite fomentar un clima de comunicación e integración grupal, además facilita el intercambio de ideas. Para el desarrollo de la actividad se divide al grupo en parejas y se entrega una hoja y bolígrafo para identificar el nombre del grupo. En el ángulo superior derecho deben escribir dos adjetivos que les describan. En el ángulo superior izquierdo deben escribir palabras que expresen lo que les gusta hacer. En la parte inferior deben escribir un proyecto de futuro.

Posteriormente, se les invita a colocarse en círculo y deben numerarse. Los números impares forman un círculo concéntrico, formando pareja cada uno de ellos con el número par siguiente que están en el exterior, cada pareja dialoga y comparte información. Cada dos minutos, a una señal establecida, los miembros del círculo exterior corren un puesto hacia la derecha. Y así sucesivamente hasta completar una vuelta. Al finalizar se puede realizar una retroalimentación de los aportes dados.





Existen muchas más técnicas que se pueden trabajar de manera grupal, es por esto que ahora le proponemos revisar el siguiente video [Juegos entretenidos para adultos mayores](#) de González (2021), en el cual usted conocerá algunas estrategias lúdicas a ejecutar con personas adultas mayores y que potencien los lazos entre sus pares.



A continuación, de acuerdo con el Proyecto Jalda (s.f.) podrá encontrar también otros tipos de técnicas participativas y dinámicas, para la facilitación de grupos, siendo una estrategia efectiva para fomentar la participación activa, el aprendizaje interactivo y la construcción de conocimiento. Estas técnicas involucran a los participantes de manera activa y práctica, lo que puede aumentar la retención de información, mejorar la comprensión de conceptos y fortalecer las habilidades de resolución de problemas y pensamiento crítico.

Las técnicas participativas involucran a los participantes en la actividad, lo que mantiene su atención y aumenta su compromiso con el contenido. Es por ello que a continuación se clasificará en tres grupos de técnicas con base en lo que se pretende conseguir.

■ **Técnicas y dinámicas de presentación**

Estas permiten que los participantes se presenten y se conozcan mutuamente para fortalecer y lograr un ambiente ameno. Entre ellos podemos encontrar: presentación por parejas, la telaraña, el ovillo, el barco se hunde, la moneda, etc.

Es momento de revisar el siguiente video en el que se estructura la explicación de la [Técnica del ovillo](#).

■ **Técnicas y dinámicas de análisis y profundización**

Comprende técnicas visuales, audiovisuales las mismas que permiten analizar y reflexionar sobre los conocimientos de un tema impartido. Aquí podemos destacar el juego de la memoria, mapas parlantes, proyección de diapositivas y videos, maquetas, radiodrama, sociodrama, lluvia de ideas, etc.

Es momento de revisar el siguiente video en el que se detalla el uso de la [Técnica de dibujos generadores de reflexión](#).



■ Técnicas de evaluación

Estas permiten identificar los conocimientos adquiridos o evaluar indicadores de un evento desarrollado con miras a mejorar, se recaban opiniones de los participantes, comprensión sobre los temas. Por ejemplo, se puede utilizar la técnica de los rostros, pelota preguntona, el correo, el relato, etc.

A continuación, le invitamos a revisar el siguiente video, la técnica de [Folio giratorio](#).

Usted ha logrado interiorizar algunas técnicas participativas y dinámicas, la elección de la técnica dependerá de los objetivos, el contexto y la población con la que se trabaja, entre ellos se pudo identificar debates, juegos de roles, simulaciones, discusiones en grupos pequeños, lluvias de ideas, resolución de problemas, mapas conceptuales y más. En general, estas técnicas pueden transformar la experiencia de aprendizaje y hacer que sea más interactiva, enriquecedora y significativa para los participantes.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Una vez que ha interiorizado las diferentes técnicas de intervención, mismas que serán de gran utilidad para el uso en su centro de prácticas, se sugiere que pueda desarrollar las siguientes actividades.

1. Realice una lectura comprensiva del siguiente REA sobre [Técnicas de cierre y evaluación](#) en el cual consta algunas técnicas grupales dados por la Organización Panamericana de Salud, entre los objetivos que pretenden dichas actividades se encuentran la expresión de sentimientos; fortalecer los sentimientos del grupo, etc. Organización Panamericana de Salud.
 - a. Realice una lectura comprensiva del REA.
 - b. Extraiga las ideas principales del instrumento.
 - c. Elabore una infografía sobre 4 técnicas grupales que usted utilizaría en su programa de intervención.

Nota: por favor complete las actividades en un cuaderno o documento Word.



2. Continúe con la ejecución de su propuesta de intervención psicológica en el centro de prácticas. Recuerde que usted debe plantear un objetivo específico y desarrollar dos actividades (talleres, charlas, campañas, etc.), que permitan cumplir con lo planificado.

Le invitamos a revisar el [anexo 17. Formato de talleres](#), que describe la estructura y el contenido de los talleres que se llevarán a cabo.



Semana 15

Para dar continuidad y finalizar el estudio de la unidad, en esta presente semana usted podrá ampliar sus conocimientos sobre estrategias de evaluación para los planes de intervención en salud mental, la evaluación le facilitará garantizar que los esfuerzos sean efectivos, eficientes y capaces de adaptarse a las necesidades cambiantes de las personas y las comunidades.

¡Iniciemos!

7.5. Evaluación de programas de promoción y prevención de la salud

Definir los indicadores para evaluar el progreso y la efectividad de la intervención, permite realizar ajustes según sea necesario y garantizar que la intervención esté siendo exitosa. Por lo tanto, esta fase permite identificar los objetivos alcanzados, así mismo comprobar si las actividades y estrategias planteadas fueron las más acordes. Es por ello que a continuación analizaremos tres tipos de evaluación o resultados:

- **Evaluación formativa:** se la ejecuta antes de desarrollar el proyecto dirigido a la población de beneficiarios que van a participar del mismo.
- **Evaluación del proceso:** se lo desarrolla en el transcurso para identificar si las actividades y metodología utilizada se están ejecutando de forma correcta.
- **Evaluación sumativa:** llamada de resultados y se la utiliza para identificar el logro de resultados (Sanjuán y Rueda, 2014).



Asimismo, la OCDE en el año de 1995 hace mención sobre algunos criterios principales a considerar. De entre ellos se detallan a continuación:

- **Pertinencia:** se entiende al análisis de los resultados, objetivos de la intervención y su relación en resolución de problemas identificados.
- **Eficiencia:** en este sentido, la eficiencia es la relación entre los recursos del proyecto y los logros conseguidos, mide la capacidad de utilizar menos recursos para lograr un mismo objetivo. Por ende, mide el proceso de aplicación y ejecución del proyecto.
- **Eficacia:** es el nivel de consecución de metas y objetivos, hace referencia a la capacidad de lograr las metas propuestas.
- **Impacto:** son aquellos efectos a mediano y largo plazo que tiene en los participantes del proyecto, sean estos efectos deseados o no deseados. Es decir, que evaluar el impacto determina si el proyecto produjo los resultados deseados y estos son atribuibles a dicha intervención. Podemos identificar diversos tipos de intervención tales como sociales, ambientales, económicos, etc.
- **Viabilidad:** es aquella cualidad debe estar presente en todas las fases del desarrollo, ya que este permite ver qué probabilidades se tiene para llevar a cabo, es decir, ver si el camino a seguir y las condiciones son las correctas, y analizar si se cuenta con los recursos necesarios (Pérez, 2021).

Por otro lado, es necesario además hacer una revisión de los tipos de evaluación según los instrumentos a utilizar, en ese sentido uno no es mejor que otro, sin embargo, el interventor tendrá que analizar cuál de estos le permitirá alcanzar el propósito que persigue. En este sentido, se puede identificar dos:

- **Instrumentos cuantitativos:** los que producen datos numéricos, por ende datos objetivos. Para ello se utilizan preguntas cerradas con opciones para su elección.
- **Instrumentos cualitativos:** proporcionan información verbal, siendo esta más flexible y explicativa, aportando una mayor



comprensión en los datos, ya que las preguntas en este caso son preguntas abiertas (Pérez, 2021).

A continuación, Sanjuán, P. y Rueda, B., (2014), nos describen los modelos de evaluación de la promoción de la salud mental con base en resultados se enfocan en medir los efectos y el impacto de las intervenciones y programas de promoción de la salud mental. Estos modelos buscan determinar si las estrategias implementadas están logrando los resultados deseados y cómo están contribuyendo al bienestar psicológico y emocional de los individuos y comunidades.

Los modelos de evaluación son esenciales para medir y demostrar la efectividad de las intervenciones con base en los resultados inmediatos hasta los más lejanos. Lógicamente, los resultados a evaluar dependerán del alcance de los programas. A continuación, se detallan los siguientes:

- **Resultados de promoción de la salud:** son los más inmediatos y recogen factores de carácter personal, social y estructural. Por ejemplo, la alfabetización, implementación de políticas públicas y saludables.
- **Resultados intermedios de salud:** son los siguientes en la jerarquía y son aquellos determinantes de la salud y la modificación de los mismos, entre ellos están la modificación de hábitos, eliminar el consumo de tabaco, incrementar la actividad física.
- **Resultados sociales y de salud:** son los más altos en la jerarquía porque es el fin último a lo que se pretende, por ejemplo: la reducción de la mortalidad, la discapacidad.

Estos modelos de evaluación son esenciales para medir y demostrar la efectividad de las intervenciones. Al utilizar estos enfoques, las organizaciones pueden tomar decisiones informadas sobre cómo mejorar sus programas y maximizar los beneficios para la salud mental de las personas.





Al estar finalizando su programa de intervención, es importante resaltar la importancia de desarrollar la evaluación final. Para lo cual le invitamos a revisar el [anexo 18. Formato de encuesta de satisfacción](#), la misma que deberá ser aplicada al tutor del centro de práctica, este instrumento cumple con el objetivo de recopilar información sobre la satisfacción de los participantes, con respecto al plan de intervención.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Nos encontramos cerca de la recta final de sus actividades prácticas. Y con la revisión de la presente unidad a lo largo de semanas, usted tiene claro cuáles son los pasos a seguir para la ejecución de programas de prevención primaria y promoción de salud. En este sentido, es importante no dejar de lado la última fase que consiste en la evaluación final, para lo cual le invitamos a desarrollar las siguientes actividades:

1. Revise detenidamente la información desarrollada en la unidad, sobre todo lo relacionado con el apartado sobre lo que son los programas de intervención.
 - Identifique las principales características y tipos de evaluación de los programas o proyectos de intervención.
 - Elabore el ensayo de las características principales de esta fase.

Nota. Utilice un cuaderno de borrador o un documento en Word para desarrollar las actividades recomendadas.

2. Estimado estudiante, para evaluar los aprendizajes adquiridos sobre esta temática, le invito a desarrollar la autoevaluación que a continuación se presenta.





Autoevaluación 6



Lea atentamente cada interrogante y seleccione la respuesta correcta:

1. Complete: entre los diversos tipos de prevención. La _____ se la utiliza antes de que se genere un problema.
 - a. Prevención primaria.
 - b. Prevención secundaria.
 - c. Prevención terciaria.
2. Complete: dentro de los diversos tipos de intervención, la _____ pretende eliminar o reducir las consecuencias del desarrollo. Seleccione el que corresponde.
 - a. Intervención primaria.
 - b. Intervención secundaria
 - c. Intervención terciaria.
3. Seleccione: existen 3 tipos de prevención de la salud mental según Mrazek y Haggerty (1994): _____.
 - a. Intervención primaria, secundaria y terciaria.
 - b. Universal, selectivo, indicado.
 - c. Comunitario, universal, individual.
4. () Seleccione verdadero o falso. El duelo es una de las temáticas o problemáticas que usted utilizaría para promoción de salud mental.
5. Complete: para la planificación del diseño de un plan de intervención, se debe realizar varias fases. Seleccione la que corresponde a la fase uno: _____.
 - a. Plantear objetivos.
 - b. Diseñar metodología.
 - c. Detección de necesidades.



6. Seleccione: en la fase de la planificación del plan de intervención se debe organizar la metodología, en la cual contiene:
_____.
- a. Revisión bibliográfica, evaluación inicial y planteamiento de objetivos.
 - b. Delimitar el problema, planteamiento de objetivos y definir los beneficiarios.
 - c. Contiene las actividades, técnicas e instrumentos para el desarrollo de la propuesta.
7. () Seleccione verdadero o falso. La psicoeducación es una técnica de intervención primaria.
8. Seleccione: dentro de las técnicas para reducción de la ansiedad se encuentra: _____.
- a. Entrenamiento en habilidades sociales.
 - b. Biblioterapia.
 - c. Entrenamiento en respiración.
9. La fase de evaluación en un programa de intervención permite evaluar el progreso y efectividad del mismo. Seleccione aquella evaluación que se ejecuta antes de desarrollar el proyecto.
- a. Evaluación del proceso.
 - b. Evaluación formativa.
 - c. Evaluación sumativa.
10. Complete: la _____ es aquella cualidad que permite ver qué probabilidades se tiene para llevar a cabo, es decir, ver si el camino a seguir es correcto.
- a. Viabilidad.
 - b. Confiabilidad.
 - c. Pertinencia.

[Ir al solucionario](#)

¡Felicitaciones! Ha concluido con la evaluación



Durante el transcurso de las semanas sobre el estudio de la unidad 7, usted ha conseguido competencias sobre el desarrollo de planes de intervención primaria; recuerde que dicho conocimiento es indispensable para el ejercicio profesional, así como también en fomentar comunidades con un enfoque en la salud mental. Al educar a la población sobre la detección temprana de problemas de salud mental, la gestión del estrés y la importancia del autocuidado, contribuye a crear sociedades más saludables y resilientes.



Finalice la ejecución de su propuesta de intervención psicológica aplicada en el centro de prácticas. Para lo cual usted debe organizar el informe de la propuesta de intervención (anexo 16) el cual será de utilidad para comunicar los resultados, medir el impacto y asegurar que las acciones implementadas fueron coherentes con los objetivos planteados.



Semana 16

Estimado estudiante, en esta última semana del periodo académico, usted debe culminar con la revisión de estas dos unidades enfocadas en las técnicas psicométricas tanto objetivas y proyectivas, así como el análisis exhaustivo del contenido explicado en el diseño de las propuestas y programas. Por tal motivo, le sugiero volver a revisar el contenido desarrollado de cada una de ellas y prestar atención en las actividades de aprendizaje recomendadas.

Al encontrarse hasta este punto, y haber culminado sus horas prácticas. Es importante que vaya preparando el entregable final de prácticas pre profesionales ([anexo 19. Formato del entregable final de prácticas](#)). En el cual se puede evidenciar todas las actividades desarrolladas durante el presente periodo académico, para ellos usted debe consolidar la información, anexando las actividades desarrolladas en el plan docente y otros documentos administrativos.

Para poder evidenciar todas las actividades desarrolladas durante el presente periodo académico, usted debe consolidar la información de las actividades desarrolladas en el plan docente. A continuación, usted podrá visualizar los documentos que su informe debe contener.



- **Oficio de asignación de prácticas:** documento que lo descarga del portal de prácticas.
- **Documento de aceptación de plaza:** documento lo genera en el portal de prácticas, y este indica que acepta la plaza asignada en un inicio del periodo académico.
- **Registro de asistencia:** este documento debe contener sellos y firma de la autoridad, además los días y hora en que usted desarrolló todas sus prácticas.
- **Certificación de prácticas pre profesionales:** documento que debe contener 144 horas cumplidas con sellos y firma de la autoridad.
- **Rúbrica de evaluación del tutor externo:** dicho instrumento lo debe llenar el tutor externo (psicólogo de la institución).
- **Informe de prácticas preprofesionales que incluya todas las actividades y prácticas del plan docente:** en este documento usted debe detallar todas las actividades desarrolladas durante las 16 semanas.
- **Anexos:** agregar fotografías, test aplicados, diapositivas de talleres u otro documento que usted considere que respalde a las actividades desarrolladas en su centro de práctica.

No olvide que cada uno de los documentos antes detallados, los puede encontrar al final de la guía; sin embargo, es importante resaltar la importancia de los siguientes documentos administrativos, los cuales deberán ser emitidos por la institución en la que realizó sus prácticas [anexo 20. Registro y control de asistencia](#), este anexo incluye un registro detallado de la asistencia, de los días, horas y actividades en las que el estudiante acudió a su centro de prácticas. Otro de los documentos es el [anexo 21: certificación de la organización receptora](#), dicho instrumento certifica la finalización exitosa de sus prácticas, este debe contener el número de horas estipulado (144 horas), y estar firmado por el psicólogo o el director del centro con el respectivo sello de la institución. Finalmente, el tutor de prácticas (psicólogo) evaluará su desempeño a través del [anexo 22: rúbrica de evaluación del tutor externo](#) en donde el profesional deberá escoger las competencias genéricas, profesionales, sociales y actitudinales del



estudiante, marcando las opciones a = sobresaliente, B = bien, C = suficiente y D = deficiente.

Recuerde que todos los anexos mencionados en esta semana son de gran importancia, ya que legalizan sus prácticas, es por ello que su presentación es obligatoria.



¡Felicitaciones, terminó las unidades de esta asignatura!

Les motivamos a continuar con el mismo entusiasmo en su formación académica.





4. Solucionario

Autoevaluación 1		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	a	Correcto. La evaluación psicológica es un proceso de recopilación de datos sobre el comportamiento humano y otros aspectos relevantes para obtener información y realizar un diagnóstico.
2	b	Correcto. Uno de los objetivos de la evaluación psicológica es predecir el futuro comportamiento de un individuo a partir de la información recopilada.
3	a	La fiabilidad en la evaluación psicológica se refiere a la consistencia y estabilidad de una prueba para medir lo que se supone que debe medir.
4	b	Correcto. La entrevista clínica es una herramienta de recogida de información ampliamente utilizada en la evaluación psicológica.
5	c	Correcto. El objetivo de controlar en la evaluación psicológica implica examinar características actuales para comparar cambios posteriores y evaluar la eficacia de una intervención.
6	a	La validez en la evaluación psicológica se refiere a la capacidad de una prueba para medir lo que se supone que debe medir.
7	c	Correcto. Los criterios económicos se refieren a mantener un equilibrio entre los costos y beneficios de las pruebas psicológicas.
8	c	Correcto. Uno de los criterios de utilidad al seleccionar una técnica de evaluación psicológica es asegurarse de que se utilice adecuadamente según el caso en particular.
9	b	Correcto. Uno de los objetivos de la evaluación psicológica es predecir el futuro comportamiento de un individuo a partir de la información recopilada.
10	b	Correcto. Los criterios de calidad se refieren a asegurarse de la calidad de cada técnica utilizada en la evaluación psicológica.

Ir a la
autoevaluación



Autoevaluación 2		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	a	Correcto. El diagnóstico es el proceso por el cual se determina si los problemas que afectan a la persona cumplen todos los criterios de un trastorno psicológico.
2	c	Correcto. Los sistemas utilizados a nivel mundial para la clasificación y diagnóstico de psicopatologías son el DSM-V y CIE-11.
3	a	El diagnóstico específico es aquel que facilita determinar, precisar problemas y sus causas.
4	c	Correcto. Posterior a la recopilación de la información sobre la sintomatología reportada y observada del paciente, es necesario obtener una comprensión clara de los síntomas e identificar en qué medida se ajustan a los criterios de diagnóstico de un trastorno específico.
5	b	Correcto. La última edición del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales es del DSM-V.
6	c	Correcto. El uso de la observación implica el sujeto que observa (observador externo o autoobservación), el lugar de observación (natural o artificial) y el tiempo en que se realiza la observación (actual o pasado).
7	b	Correcto. Las técnicas objetivas permiten la recogida de información de eventos psicológicos observables que en gran parte de los casos no son controlables por el sujeto evaluado.
8	a	Correcto. El lugar de observación puede realizarse tanto en un ambiente natural o artificial.
9	a	Correcto. Los elementos para llegar a un diagnóstico incluyen: listado de comportamiento, material de entrevistas, historial personal, familiar, laboral, resultados de pruebas, criterios diagnósticos.
10	b	Los tres niveles de diagnóstico son: diagnóstico general, específico y diagnóstico en el proceso de tratamiento.

Ir a la
autoevaluación



Solucionario



Autoevaluación 3		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	c	La autobiografía se considera un tipo de autoinforme, que consiste en una expresión narrativa de la vida de un individuo, de una persona, en donde expresa, describe, explica e interpreta su experiencia subjetiva.
2	a	Las entrevistas estructuradas poseen un formato predeterminado, en donde las preguntas se definen previamente y las opciones de respuesta del entrevistado son limitadas, siguiendo una dirección específica.
3	c	La fase II del procedimiento de evaluación psicológica corresponde a la formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables.
4	a	Los supuestos de asociación funcional se establecen considerando relaciones explicativas o causales de un evento o variables.
5	b	La lista de cotejo es un instrumento estructurado que coadyuva a recolectar información sobre la presencia o ausencia de un comportamiento, acción o una característica en particular.
6	c	La escala numérica es expresada en números, para ello el observador asigna una escala numérica con una clave descriptiva que señalan los niveles de frecuencia de característica u otro aspecto observable.
7	b	La deducción de enunciados verificables facilita establecer conclusiones contrastables, para lo cual se requiere que las variables que constan en las hipótesis se encuentren debidamente operacionalizadas mediante la aplicación de diversos instrumentos.
8	c	Los autoinformes recopilan contenidos evaluables de manifestaciones motoras, cognitivas, fisiológicas, experiencia subjetiva y emociones.
9	b	Los cuestionarios se caracterizan por contener un formulario de preguntas o afirmaciones a las cuales el sujeto debe responder mediante una alternativa dicotómica o una escala ordinal.
10	b	La rúbrica permite determinar el nivel y la calidad de una tarea mediante una escala cuantitativa y/o cualitativa.

Ir a la
autoevaluación



Solucionario



Autoevaluación 4		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	c	La autobiografía se considera un tipo de autoinforme, que consiste en una expresión narrativa de la vida de un individuo, de una persona, en donde expresa, describe, explica e interpreta su experiencia subjetiva.
2	a	Las entrevistas estructuradas poseen un formato predeterminado, en donde las preguntas se definen previamente y las opciones de respuesta del entrevistado son limitadas, siguiendo una dirección específica.
3	b	La fase II del procedimiento de evaluación psicológica corresponde a la formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables.
4	a	Los supuestos de asociación funcional se establecen considerando relaciones explicativas o causales de un evento o variables.
5	b	La lista de cotejo es un instrumento estructurado que coadyuva a recolectar información sobre la presencia o ausencia de un comportamiento, acción o una característica en particular.
6	c	La escala numérica es expresada en números, para ello el observador asigna una escala numérica con una clave descriptiva que señalan los niveles de frecuencia de característica u otro aspecto observable.
7	a	La deducción de enunciados verificables facilita establecer conclusiones contrastables, para lo cual se requiere que las variables que constan en las hipótesis se encuentren debidamente operacionalizadas mediante la aplicación de diversos instrumentos.
8	c	Los autoinformes recopilan contenidos evaluables de manifestaciones motoras, cognitivas, fisiológicas, experiencia subjetiva y emociones.
9	a	Los cuestionarios se caracterizan por contener un formulario de preguntas o afirmaciones a las cuales el sujeto debe responder mediante una alternativa dicotómica o una escala ordinal.
10	b	La rúbrica permite determinar el nivel y la calidad de una tarea mediante una escala cuantitativa y/o cualitativa.

Ir a la
autoevaluación



Solucionario



Autoevaluación 5

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	a	El objetivo principal de las pruebas psicológicas es evaluar el comportamiento, las aptitudes cognoscitivas, rasgos de personalidad y otras características individuales y de grupo, con el fin de ayudar a la toma de decisiones, formar juicio.
2	c	Hace referencia a la probabilidad del buen funcionamiento de una cosa. Se refiere a la capacidad de un instrumento para medir realmente lo que pretende medir. Es decir, un instrumento es válido si mide de manera precisa y exacta el constructo o característica que se busca evaluar.
3	b	El evaluador debe considerar muchos aspectos tales como conducta, postura, apariencia física, en la cual se debe observar su higiene personal, está arreglado, limpio, desaliñado, vestimenta acorde a la temporada, cicatrices, etc.
4	a	El test de matrices progresivas de Raven es un instrumento que evalúa inteligencia en la cual consiste en completar la serie faltante.
5	b	El inventario de personalidad 16-PF mide la estructura de la personalidad en 16 factores. El perfil de personalidad se obtiene por el cálculo de los factores QI: adaptación-ansiedad, QII: introversión-extraversión, QIII: emotividad – dinamismo, QIV: sumisión- interdependencia, Neuroticismo.
6	c	El TAT Test de Apercepción Temática es un instrumento proyectivo cuya administración comienza pidiendo al examinado que cuente una historia completa sobre que está sucediendo, que piensan y sienten los personajes. Al interpretan y se asume que las personas proyectan sus deseos y conflictos.
7	b	Los test proyectivos son una categoría de pruebas psicológicas utilizadas en el campo de la evaluación diagnóstico psicológico. Se caracterizan por presentar estímulos ambiguos o poco estructurados a los individuos evaluados, quienes deben interpretarlos o proyectar sus pensamientos, sentimientos y emociones a través de sus respuestas.
8	b	El profesional de psicología debe adherirse a los principios éticos y de confidencialidad al administrar las pruebas y manejar la información del evaluado. La privacidad y la protección de los datos son fundamentales para establecer una relación terapéutica de confianza. Para todo proceso de evaluación se necesita el consentimiento informado de quienes se someten a una prueba o de sus representantes legales.



Solucionario



Autoevaluación 5

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
9	a-3 b-1 c-2	Técnica de Psicodiagnóstico de Rorschach (de Hogrefe y Huber), publicados por primera vez en 1921, son diez tarjetas que contiene una mancha de tinta simétrica de manera bilateral, en blanco y negro, rojo y gris, o de muchos colores. Se pide a los examinados que informen lo que ven en la mancha o lo que puede representar.

10	b	El MBI es un Inventario, posee tres escalas: cansancio emocional, despersonalización y realización personal. Este pretende medir la relación entre la persona y su ambiente laboral.
----	---	--

[Ir a la autoevaluación](#)



Solucionario



Autoevaluación 6

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	a	La intervención primaria se interviene antes de que se genere el problema o enfermedad, permitiendo impedir o retrasar su aparición. Por ejemplo, prevención primaria de la depresión cuyo objetivo sería evitar que las personas desarrollen síntomas de depresión.
2	c	Se lo utiliza cuando la enfermedad o problema está instaurado, por lo que este tipo de intervención pretende eliminar o reducir las consecuencias de su desarrollo. Por ejemplo: aplicación de tratamientos psicológicos a personas diagnosticadas con trastorno.
3	b	Mrazek y Haggerty (1994) establecen 3 tipos de prevención en la salud mental, la universal, misma que esta es dirigida a toda una población, selectiva: cuando esta se orienta a grupos con riesgo moderado y la indicada cuando se dirige a personas con alto riesgo de tener algún problema de salud mental.
4	b	La promoción de la salud mental se enfoca en fomentar el bienestar general y la resiliencia emocional en individuos y comunidades. Busca fortalecer los factores protectores, como las habilidades de afrontamiento. Por esa razón la inteligencia emocional sería un buen tema para la promoción.
5	c	En la fase 1 denominada diagnóstico y análisis, la detección de necesidades permite identificar los problemas, respondiendo estas preguntas, ¿existe un problema, cuál es, se cuenta con información, etc.?
6	a	Metodología: responde al cómo lo vamos a hacer, este apartado contiene actividades, técnicas e instrumentos, definir la población, identificar la muestra, recoger datos, analizar datos, temporalización, recursos humanos, materiales, financieros.
7	a	Psicoeducación permite aumentar el conocimiento sobre un tema determinado, situación o conducta. Por ejemplo, se puede utilizar dicha técnica para brindar información acerca de qué es la depresión, cuáles son los síntomas, factores que lo desencadenan, etc.
8	a	El entrenamiento en respiración procedimiento que utiliza la respiración diafragmática para reducir la ansiedad.



Solucionario



Autoevaluación 6

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
----------	-----------	-------------------

9	b	La evaluación formativa se la ejecuta antes de desarrollar el proyecto dirigido a la población de beneficiarios que van a participar del mismo.
---	---	---

10	c	La eficacia: es el nivel de consecución de metas y objetivos, hace referencia a la capacidad de lograr las metas propuestas.
----	---	--

[Ir a la autoevaluación](#)



Solucionario





Referencias



5. Referencias bibliográficas

- Aiken Lewis, R. (2022). Test psicológicos y evaluación. (Undécima Edición). Pearson Education. <https://visorweb.utpl.edu.ec/reader/tests-psicologicos-y-evaluacion>
- Beatón, G. A. (1999). El diagnóstico en la psicología. Revista cubana de Psicología, 2. <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rcp/v16n3/05.pdf>, 2.
- Buela, G., y Sierra, J. (1997) *Manual de evaluación psicológica, Fundamentos, técnicas y aplicaciones*. (1.ª Ed.). Editorial Tirant
- Carrasco, M., y Rubio, F. (2020). *Psicología jurídica y forense*. (1.ª Ed.). Editorial Sanz y Torres, S.L
- Cañón, S., Castaño-Castrillón, J., Mosquera-Lozano, A., Nieto-Angarita, L., Orozco-Daza, M., & Giraldo-Londoño, W. (2018). Propuesta de intervención educativa para la prevención de la conducta suicida en adolescentes en la ciudad de Manizales (Colombia). *Diversitas: Perspectivas en Psicología*, 14(1), 27-40. <https://doi.org/10.15332/s1794-9998.2018.0001.02>
- Casullo, M. M. (2009). *La evaluación psicológica: modelos, técnicas y contextos*. Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación-e Avaliação Psicológica, 1(27), 9-28.
- Cronbach, L. (1990). *Essentials of psychological testing*, Nueva York: Harper & Row.
- Cronbach, L. (1968). *Fundamentos de la exploración psicológica*. Edición Revolucionaria, La Habana.
- Delgado, E. (2007). *Planteamiento didáctico en la educación preescolar*. (1.ª Ed.) Editorial UENED
- Fatelevich, M. y Tonin, S. (2021). Test de Frases Incompletas: origen, desarrollo y adaptaciones en diferentes ámbitos de evaluación psicológica. XIII Congreso Internacional de Investigación y

Práctica Profesional en Psicología. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ <https://www.aacademica.org/000-012/122.pdf>

Fernández-Ballesteros, R. (2013) (2.ª. Ed.). Evaluación psicológica. Madrid: Ediciones Pirámide.

Gil, J. (2016). *Técnicas e instrumentos para la recogida de información*. Universidad Nacional de Educación a Distancia. González, F. (2007). *Instrumentos de evaluación psicológica*. Editorial Ciencias Médicas

Glanz, K et al. (2008). Health Behaviour and Health Education. Chapter 9: Social Networks and Social Support. Pags. 189-210. Jossey-Bass.

González, F. (2007). *Instrumentos de evaluación psicológica*. Editorial Ciencias Médicas

Gutiérrez, J (2002) Aplicaciones de la Realidad Virtual en psicología Clínica. Aula Médica Psiquiátrica, 4(2), 92-126

Labrador, F (2008) Técnicas de modificación de conducta. Edición pirámide

Mrazek P.J., Hall M., (1994). A policy perspective on prevention, American journal of community psychology, 1997, Vol. 25: 221-226.

Medina, M., y Verdejo, A. (2001). *Evaluación del aprendizaje estudiantil*. (3.ª Ed.). Isla negra.

Morrison, J. (2014). *La entrevista psicológica*. Editorial Manual Moderno. Morrison, J. (2015). *DSM-5. Guía para el diagnóstico clínico*. Editorial Manual Moderno.

Morrison, J. (2015). *DSM-5. Guía para el diagnóstico clínico*. Editorial Manual Moderno.

Muñoz, M. (2010). *Manual práctico de evaluación psicológica clínica*. Editorial Síntesis S. A.

Naranjo et al. (2017). La biblioterapia como herramienta de ayuda aplicada en la biblioteca escolar: estudios de caso. Volumen 7, número 2, Artículo científico 2. DOI: <https://dspace.ups.edu.ec/>



Referencias



bitstream/123456789/20863/5/Fundamentos%20de%20%20
evaluacio%cc%81n%20psicolo%cc%81gica.pdf

Olivares, J. (2021). Intervención psicológica: estrategias, técnicas y tratamientos. (ND). Ediciones Pirámide. <https://visorweb.utpl.edu.ec/reader/intervencion-psicologica-estrategias-tecnicas-y-tratamientos>

Paz Guerra, S., & Peña Herrera, B. (2021). Fundamentos de la evaluación psicológica. ABYA-YALA. <https://doi.org/http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/20863>

Pérez Serrano, Gloria. (2021). Diseño de proyectos sociales. Narcea, S.A. Ediciones. <https://visorweb.utpl.edu.ec/reader/disenio-de-proyectos-sociales-aplicaciones-practicas-para-su-planificacion-gestion-y-evaluacion-1617722661>

Perpiñá, C. (2012). Manual de la entrevista psicológica. Madrid: Ediciones Pirámide.

Querol y Chávez (2004). Persona bajo la lluvia. Lugar Editorial psicológica. Conceptos, métodos y estudio de casos. Ediciones Pirámide.

Rivera, J. A., & Álvarez-Alatorre, Y. (2022). DSM-5-TR: Antecedentes históricos, descripción general de los principales cambios. *Revista Puertorriqueña de Psicología*, 33(2), 302-317. <https://doi.org/https://doi.org/10.55611/rebs.3302.08>

Sanjuán, P. y Rueda, B., (2014). Promoción y prevención de la salud desde la psicología. Editorial Síntesis, S. A.



Referencias





6. Anexos

Actividades potenciales dentro del centro de prácticas

Estimado estudiante, a continuación, se presenta las actividades que se pueden realizar en el centro de prácticas.

Actividades a desarrollarse en el centro de práctica

Este nivel de Prácticum es fundamental para la formación profesional, ya que esta asignatura pretende fortalecer el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias propias del campo de aplicación de la psicología, sin dejar de lado la parte teórica, fundamental para lograr el acercamiento e inserción en sus posibles escenarios laborables, donde se presentan diferentes casuísticas del quehacer psicológico. Por tal razón, el estudiante aportará desde su formación a la prevención de problemáticas psicosociales de mayor prevalencia tales como: *violencia, consumo de sustancias, depresión, ansiedad y suicidio*, temas de suma importancia en nuestra sociedad y comunidad.

Es por ello que, a continuación, se adjuntan las siguientes actividades a ejecutar por los estudiantes:

- Actividades de ayudantía que la entidad requiera relacionadas con la carrera de Psicología, considerando las competencias que poseen los estudiantes (promoción, prevención e intervención primaria) en coordinación con el psicólogo de la institución.
- Detección de necesidades a través de una entrevista semiestructurada dirigida a tutor externo (psicólogo), autoridades o beneficiarios.



- Ejecutar el programa de intervención primaria, el mismo que consiste en el desarrollo de talleres relacionados con la problemática detectada, el mismo que podrá ser grabado con previa autorización, cuidando la integridad e identidad de los usuarios.
- Aplicación de instrumentos para evaluar los talleres ejecutados, y de esta manera medir el impacto de los programas diseñados.

Atentamente,



Anexos



Ficha de observación

Ficha de observación Nro.:

Constructo: irritabilidad

Datos informativos:

Nombre:	Edad:	
Escolaridad:	Grado:	
Institución educativa:	Lugar de observación:	
Observador:	Duración:	
Fecha:	Hora de inicio:	Hora de finalización:

Conducta a Observar	Frecuencia			
	Siempre	Frecuentemente	A veces	Nunca

Se aísla

Baja tolerancia a la frustración.

Acusa constantemente a sus
compañeros

Permanece fijo en la conducta
reactiva (reacciona de manera
exagerada)

Se maneja con descargas
impulsivas, resulta difícil
establecer el equilibrio

Se muestra amenazante ante
cualquier orden

Se muestra amenazante cuando
se le llama la atención.

Observaciones:

Firma del observador:

Nombres y Apellidos:



Anexos



Entrevista estructurada y semiestructurada

A. Ejemplo de entrevista estructurada

Entrevista clínica (Preevaluación)

I. Datos generales:	
Forma de aplicación	Individual
Objetivo	
Dirigido a	
Edad	
Nombre del entrevistador	
Fecha de aplicación	

I. Preguntas:

- ¿Puede decirme su nombre?
- ¿Qué edad tiene?
- ¿Cuál es la fecha de su nacimiento?
- ¿Cuál es su profesión?
- ¿Sabe qué día es hoy?
- ¿Cómo ha llegado hasta aquí?
- ¿Le ha traído alguien?
- ¿Sabe la dirección de este sitio?
- ¿Dónde estaba antes de venir aquí?
- ¿Cuál es la razón de que esté aquí?

B. Ejemplo de entrevista semiestructurada

Recolección de información inicial (Ámbito clínico)

I. Datos generales:	
Objetivo	Conocer aspectos de la vida del evaluado que faciliten la determinación de daños psicológicos producto de la exposición a un hecho violento.
Dirigido a	
Edad	
Nombre del entrevistador	
Fecha de aplicación	



Anexos



II. Ambientación y encuadre:

- ¿Cuál es su nombre completo?
- ¿Cuál es su fecha y lugar de nacimiento?
- ¿Qué edad tiene?
- ¿En la actualidad a qué se dedica?
- ¿Cuál es su grado de escolaridad?
- ¿Cuál es su estado civil?
- ¿En qué ciudad vive? ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en esta ciudad?

III. Resumen de los hechos:

- Por favor, coménteme ¿Cuáles fueron los sucesos por los cuales usted se encuentra aquí, el día de hoy?
- Puede indicarme ¿Cómo sucedió?
- Cuénteme por favor ¿Cómo se sintió en ese momento?
- ¿Qué emociones experimentó?
- ¿Qué cambios identifica en su vida antes y después del suceso?

IV. Problemas o dificultades

- ¿Qué problemas o dificultades ha presentado a lo largo de su vida?
- ¿Cómo ha superado esas dificultades?
- Me podría indicar ¿Qué estrategias o medios emplea utiliza superar los problemas, las dificultades que se le presentan?



Anexos



Historia clínica

I. Datos de identificación:

Apellidos y nombres
Lugar y fecha de nacimiento
Edad
Estado civil
Número de hijos
Instrucción
Ocupación
Domicilio

II. **Motivo de consulta** (indique la razón por la que el paciente solicita asistencia psicológica).

III. **Sintomatología** (enumerar los principales síntomas actuales y la forma de evolución, así como la frecuencia, intensidad, factores desencadenantes).

IV. **Genograma** (representación gráfica de la estructura o composición familiar).

V. Psicoanamnesis personal

- Prenatal y parto: (condiciones biológicas y psicológicas de los padres durante la concepción-embarazo).
- Pubertad, adolescencia y juventud (características de la crisis de la adolescencia, proyecciones futuras, anhelos y aspiraciones, éxitos-fracasos, intereses vocacionales, estudios realizados, conflictos sexuales).
- Madurez (Relaciones con hijos, cónyuge, padres, amigos, éxitos-fracasos, enfermedades padecidas, tratamientos recibidos).

VI. **Enfermedades diagnosticadas.**

VII. **Historia social** (desarrollo en el medio familiar, escolar, laboral, entre otros).



Anexos



VIII. Ocio y tiempo libre.

IX. Estado actual físico y de salud

X. Observación de la conducta (durante la consulta, mencionar aspecto psíquico y físico en general: exilado, deprimido, ansioso, arreglo personal, limpieza, arreglo de ropa, uñas, barba, expresión verbal, conciencia, orientación, atención).

XI. Diagnóstico presuntivo.

XII. Instrumentos psicológicos aplicados.

XIII. Diagnóstico definitivo.

XIV. Pronóstico (posibilidades de superación del problema).

XV. Recomendaciones (evitar el uso de aconsejar, debería).



Anexos





Modalidad de estudios: distancia

Área académica: ciencias sociales, educación y humanidades

Titulación/carrera: psicología

Prácticas preprofesionales de la correspondiente a la

Prácticum 2: prácticas preprofesionales

Nombre del estudiante: apellidos y nombres completos.

Fecha:

Tutor académico: apellidos y nombres del tutor académico.

PERIODO ACADÉMICO:

CONTEXTUALIZACIÓN CENTRO DE PRÁCTICA



Anexos



1. Características del centro de prácticas

- **Nombre de la institución:**
- **Misión de la institución:**
- **Visión de la institución:**
- **Localización:**

1.1. Descripción del centro

- **Tipo de entidad:**
- **Objetivos:**
- **Prestaciones y servicios:**
- **Hora de atención de la entidad:**
- **Organigrama:**

1.2. Perfil de los usuarios

- **Tipo de problemáticas que atiende la entidad:**
- **Rango de edad de los usuarios:**
- **Perfil socioeconómico-cultural de los usuarios:**

1.3. Equipo de centro

- **Rol del profesional en psicología que trabaja en la entidad:**



Anexos



Informe de formulación y deducción de hipótesis

I. Datos informativos:

Nombres y apellidos del evaluado

Ocupación

Fecha de aplicación

Fecha de nacimiento

Edad

Evaluador

II. Motivo de evaluación

III. Formulación de hipótesis

Hipótesis 1:

Sintomatología asociada según el
DSM-V

Criterio diagnóstico

Hipótesis 2:

Sintomatología asociada según el
DSM-V

Criterio diagnóstico

Hipótesis 3:

Sintomatología asociada según el
DSM-V

Criterio diagnóstico

IV. Hipótesis definitiva



Anexos



V. Instrumentos o técnicas de evaluación para hipótesis definitiva

VI. Conclusiones

VII. Recomendaciones



Lista de cotejo

Nombre:

Fecha:

Observador:

Lugar:

Tiempo de inicio:

Tiempo de finalización:

Instrucciones: a continuación, se presenta una lista de conductas observables, para que usted valore el desarrollo (área personal) del preescolar. Analice con atención cada aspecto y sea objetivo con sus decisiones. Marque con una (X) la presencia o ausencia del comportamiento. Cada sí equivale a (10) puntos, al finalizar sume los puntos parciales y establezca los criterios de valoración que aparecen al final de la lista.

Indicadores- área personal	Criterios	
	Sí	No
1 Diferencia niño de niña.		
2 Señala las partes del cuerpo.		
3 Indica el nombre de papá y mamá.		
4 Se lava las manos y cara por sí mismo.		
5 Se viste y desviste por sí mismo.		
6 Comparte el juego con otros niños.		
7 Tiene mejor amigo.		
8 Conoce su edad.		
9 Organiza juegos.		
10 Acata órdenes.		
Total de puntos obtenidos		

Criterios de valoración:

Excelente (100-80 puntos). Muy bueno (79- 60 puntos). Bueno (59-40 puntos).
 Regular (39-20 puntos). Deficiente (19-10 puntos).

Observaciones:



Anexos



Formato de informe para lista de cotejo y escalas de apreciación

Estimado estudiante, a continuación, se presenta el formato de informe para lista de cotejo y escalas de apreciación.

I. Datos informativos:

Nombres y apellidos del evaluado

Edad

Fecha de elaboración

Evaluador

II. Valoración realizada (Incluya las áreas o aspectos explorados con sus respectivos resultados)

Área personal

III. Conclusiones: (Se realizan en función de los resultados obtenidos, en este apartado debe citar a un autor que refiera el desarrollo del menor en determinada etapa de desarrollo; de tal manera, que le permita comparar con los resultados obtenidos)

IV. Recomendaciones: (se establecen con relación a las conclusiones y pueden estar dirigidas a los padres de familia, docente, escuela, entre otros).



Anexos



Cuestionario PHQ-9

Cuestionario sobre la salud del paciente (PHQ-9)

Durante las últimas 2 semanas, ¿qué tan seguido ha tenido molestias debido a los siguientes problemas?

(Marque con un "X" para indicar su respuesta).

	Ninguno Día	Varios días	Más de la mitad de los días	Casi todos los días
1 Poco interés o placer en hacer cosas.	0	1	2	3
2 Se ha sentido decaído, deprimido o sin esperanzas.	0	1	2	3
3 Ha tenido dificultad para quedarse o permanecer dormido, o ha dormido demasiado.	0	1	2	3
4 Se ha sentido cansado(a) o con poca energía.	0	1	2	3
5 Sin apetito o ha comido en exceso.	0	1	2	3
6 Se ha sentido mal con usted mismo o que es un fracaso o que ha quedado mal con usted mismo o con su familia.	0	1	2	3
7 Ha tenido dificultad para concentrarse en ciertas actividades, tales como leer el periódico o ver la televisión.	0	1	2	3
8 ¿Se ha movido o hablado tan lento que otras personas podrían haberlo notado?, o lo contrario, muy inquieto o agitado, que ha estado moviéndose mucho más de lo normal.	0	1	2	3
9 Pensamientos de que estaría mejor muerto o de lastimarse de alguna manera.	0	1	2	3

Puntaje total:

Si marcó cualquiera de los problemas, ¿qué tanta dificultad le han dado estos problemas para hacer su trabajo, encargarse de las tareas del hogar, o llevarse bien con otras personas?

No ha sido difícil Un poco difícil Muy difícil Extremadamente difícil

☐
☐
☐
☐


Anexos



16PF-5

Nombres y apellidos	
Edad	
Fecha	
Evaluador	

Instrucciones:

A continuación, encontrará unas frases que permitirán conocer sus actitudes e intereses. En general, no existen respuestas “buenas” ni “malas”. Conteste con sinceridad; de esta forma se podrá conocer mejor su forma de ser.

Cada frase contiene tres posibles respuestas (a, b, c); normalmente la alternativa (b) viene con una interrogante (dudo, me da igual o no puedo decidir), para ser señalada cuando no es posible decidirse entre la a y la c.

1. En un negocio sería más interesante encargarse de:

- A. Las máquinas o llevar registros.
- B. ?
- C. Entrevistar y hablar con personas.

2. Normalmente me voy a dormir sintiéndome satisfecho de cómo ha ido el día.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

3. Si observo que la línea de razonamiento de otra persona es incorrecta, normalmente:

- A. Se lo señalo.
- B. ?
- C. Lo paso por alto.



Anexos



4. Me gusta muchísimo tener invitados y hacer que se lo pasen bien.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

5. Cuando tomo una decisión, siempre pienso cuidadosamente en lo que es correcto y justo.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

6. Me atrae más pasar una tarde ocupado en una tarea tranquila a la que tenga afición que estar en una reunión animada.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

7. Admiro más:

- A. A una persona con capacidad de tipo medio, pero con una moral estricta.
- B. ?
- C. Una persona con talento, aunque a veces no sea responsable.

8. Sería más interesante ser:

- A. Ingeniero de la construcción.
- B. ?
- C. Escritor de teatro.

9. Normalmente soy el que da el primer paso al hacer amigos.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.



Anexos



10. Me encantan las buenas novelas u obras de teatro/cine.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

11. Cuando la gente autoritaria trata de dominarme, hago justamente lo contrario de lo que quiere.

- A. Si
- B. ?
- C. Falso.

12. Algunas veces no congenio muy bien con los demás porque mis ideas no son convencionales y corrientes.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. No

13. Muchas personas te “apuñalarían por la espalda” para salir ellas adelante.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

14. Me meto en problemas porque a veces sigo adelante con mis ideas sin comentarlas con las personas que puedan estar implicadas.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

15. Hablo de mis sentimientos:

- A. Con facilidad cuando las personas parecen estar interesadas.
- B. ?
- C. Solo si no tengo más remedio.



Anexos



16. Me aprovecho de la gente.

- A. Algunas veces.
- B. ?
- C. Nunca.

17. Mis pensamientos son demasiado complicados y profundos como para ser comprendidos por muchas personas.

- A. Casi nunca.
- B. ?
- C. A menudo.

18. Prefiero:

- A. Comentar mis problemas con los amigos.
- B. ?
- C. Guardarlos para mis adentros.

19. Pienso acerca de las cosas que debería haber dicho, pero no las dije.

- A. Casi nunca.
- B. ?
- C. A menudo.

20. Siempre estoy alerta ante los intentos de propagandas en las cosas que leo.

- A. Si.
- B. ?
- C. No.

21. Si las personas actúan como si yo no les gustara:

- A. No me perturba.
- B. ?
- C. Normalmente me hace daño.



Anexos



22. Cuando observo que difiero de alguien en puntos de vista sociales, prefiero:

- A. Discutir el significado de nuestras diferencias básicas.
- B. ?
- C. Cambiar de tema.

23. He dicho cosas que hirieron los sentimientos de otros.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

24. Si tuviera que cocinar o construir algo, seguiría las instrucciones exactamente.

- A. Verdadero, para evitar sorpresas.
- B. ?
- C. Falso, porque podría hacer algo más interesante.

25. A la hora de construir o hacer algo preferiría trabajar:

- A. Con otros.
- B. ?
- C. Yo solo.

26. Me gusta hacer planes con antelación para no perder tiempo entre las tareas.

- A. Raras veces.
- B. ?
- C. A menudo.

27. Normalmente me gusta hacer mis planes yo solo, sin interrupciones y sugerencias de otros.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.



Anexos



- 28. Cuando me siento tenso, incluso pequeñas cosas me sacan de quicio.**
- A. Verdadero.
 - B. ?
 - C. Falso.
- 29. Puedo encontrarme bastante a gusto en un ambiente desorganizado.**
- A. Verdadero.
 - B. ?
 - C. Falso.
- 30. Si mis planes, cuidadosamente elaborados, tuvieran que ser cambiados a causa de otras personas:**
- A. Eso me molestaría e irritaría.
 - B. ?
 - C. Me parecería bien y estaría contento de cambiarlos.
- 31. Preferiría:**
- A. Estar en una oficina, organizando y atendiendo a personas.
 - B. ?
 - C. Ser arquitecto y dibujar planos en un despacho tranquilo.
- 32. Cuando las pequeñas cosas comienzan a marchar mal unas detrás de otras.**
- A. Me siento como si no pudiera dominarlas.
 - B. ?
 - C. Continúo de un modo normal.
- 33. Me satisface y entretiene cuidarme de las necesidades de los demás.**
- A. Verdadero.
 - B. ?
 - C. Falso.



Anexos



- 34. A veces hago observaciones tontas, a modo de broma, para sorprender a los demás.**
- A. Verdadero.
 - B. ?
 - C. Falso.
- 35. Cuando llega el momento de hacer algo que he planeado y esperado, a veces no me apetece ya continuarlo.**
- A. Verdadero.
 - B. ?
 - C. Falso.
- 36. En las situaciones que dependen de mí me siento bien dando instrucciones a los demás.**
- A. Verdadero.
 - B. ?
 - C. Falso.
- 37. Preferiría emplear una tarde:**
- A. Haciendo con tranquilidad y sosiego algo por lo que tenga afición.
 - B. ?
 - C. En una fiesta animada.
- 38. Cuando yo sé muy bien lo que el grupo tiene que hacer, me gusta ser el único en dar las órdenes.**
- A. Si.
 - B. ?
 - C. No.
- 39. Me divierte mucho el rápido y vivaz humor de algunas series de televisión.**
- A. Verdadero.
 - B. ?
 - C. Falso.



Anexos



- 40. Le doy más valor y respeto a las normas y buenas maneras que a una vida fácil.**
- A. Verdadero.
 - B. ?
 - C. Falso.
- 41. Me encuentro tímido y retraído a la hora de hacer amigos entre personas desconocidas.**
- A. Verdadero.
 - B. ?
 - C. Falso.
- 42. Si pudiera, preferiría hacer ejercicio con:**
- A. La esgrima o la danza.
 - B. ?
 - C. El tenis o la lucha libre.
- 43. Normalmente hay una gran diferencia entre lo que la gente dice y lo que hace.**
- A. Verdadero.
 - B. ?
 - C. Falso.
- 44. Resultaría más interesante ser músico que mecánico.**
- A. Verdadero.
 - B. ?
 - C. Falso.
- 45. Las personas forman su opinión acerca de mí demasiado rápidamente.**
- A. Casi nunca.
 - B. ?
 - C. A menudo.



Anexos



46. Soy de esas personas que:

- A. Siempre están haciendo cosas prácticas que necesitan ser hechas.
- B. ?
- C. Imaginan o piensan acerca de cosas sobre sí mismas.

47. Algunas personas creen que es difícil intimar conmigo.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

48. Puedo engañar a las personas siendo amigable cuando en realidad me desagradan.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

49. Mis pensamientos tienden más a girar sobre cosas realistas y prácticas.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

50. Suelo ser reservado y guardar mis problemas para mis adentros.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

51. Después de tomar una decisión sobre algo, sigo pensando si será acertada o errónea.

- A. Normalmente verdadero.
- B. ?
- C. Normalmente falso.



Anexos



52. En el fondo no me gustan las personas que son “diferentes” u originales.

- A. Verdadero, normalmente no me gustan.
- B. ?
- C. Falso, normalmente los encuentro interesantes.

53. Estoy más interesado en:

- A. Buscar un significado personal a la vida.
- B. ?
- C. Asegurarme un trabajo con un buen sueldo.

54. Me perturbo más que otros cuando las personas se enfadan entre ellas.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

55. Lo que este mundo necesita es:

- A. Más ciudadanos íntegros y constantes.
- B. ?
- C. Más reformadores con opiniones sobre cómo mejorar el mundo.

56. Prefiero los juegos en los que:

- A. Se forman equipos o se tiene un compañero.
- B. ?
- C. Cada uno hace su partida.

57. Normalmente dejo algunas cosas a la buena suerte en vez de hacer planes complejos y con todo detalle.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.



Anexos



- 58. Frecuentemente tengo periodos de tiempo en que me es difícil abandonar el sentimiento de compadecerme a mí mismo.**
- A. Verdadero.
 - B. ?
 - C. Falso.
- 59. Mis mejores horas del día son aquellas en que estoy solo con mis pensamientos y proyectos.**
- A. Verdadero.
 - B. ?
 - C. Falso.
- 60. Si la gente me interrumpe cuando estoy intentando hacer algo, eso no me perturba.**
- A. Verdadero, no me siento mal.
 - B. ?
 - C. Falso, me molesta.
- 61. Siempre conservo mis pertenencias en perfectas condiciones.**
- A. Verdadero.
 - B. ?
 - C. Falso.
- 62. A veces me siento frustrado por las personas demasiado rápidamente.**
- A. Verdadero.
 - B. ?
 - C. Falso.
- 63. No me siento a gusto cuando hablo o muestro mis sentimientos de afecto o cariño.**
- A. Verdadero.
 - B. ?
 - C. Falso.



Anexos



64. En mi vida personal, casi siempre alcanzo las metas que me pongo.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

65. Si el sueldo fuera el mismo, preferiría ser un científico más que un directivo de ventas.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

66. Si la gente hace algo incorrecto, normalmente le digo lo que pienso.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

67. Pienso que mis necesidades emocionales:

- A. No están demasiado satisfechas.
- B. ?
- C. Están bien satisfechas.

68. Normalmente me gusta estar en medio de mucha actividad y excitación.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

69. La gente debería insistir, más de lo que lo hace ahora, en que las normas morales sean seguidas estrictamente.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.



Anexos



70. Preferiría vestir:

- A. De modo aseado y sencillo.
- B. ?
- C. A la moda y original.

71. Me suelo sentir desconcertado si de pronto paso a ser el centro de la atención en un grupo social.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

72. Me pone irritado que la gente insista en que yo siga las mínimas reglas de seguridad.

- A. Verdadero, porque no siempre son necesarias.
- B. ?
- C. Falso, porque es importante hacer las cosas correctamente.

73. Comenzar a conversar con extraños:

- A. Nunca me ha dado problemas.
- B. ?
- C. Me cuesta bastante.

74. Si trabajara en un periódico, preferiría los temas de:

- A. Literatura o cine.
- B. ?
- C. Deportes o política.

75. Dejo que pequeñas cosas me perturben más de lo que debieran.

- A. A veces.
- B. ?
- C. Raras veces.



Anexos



76. **Es acertado estar en guardia con los que hablan de modo amable, porque se pueden aprovechar de uno.**
- A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.
77. **En la calle me detendría más a contemplar a un artista pintando que a ver la construcción de un edificio.**
- A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.
78. **Las personas se hacen perezosas en su trabajo cuando consiguen hacerlo con facilidad.**
- A. Casi nunca.
B. ?
C. A menudo.
79. **Se me ocurren ideas nuevas sobre todo tipo de cosas, demasiadas para ponerlas en práctica.**
- A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.
80. **Cuando hablo con alguien que no conozco todavía, no doy más información que la necesaria.**
- A. Normalmente verdadero.
B. ?
C. Normalmente falso.
81. **Pongo más atención en:**
- A. Las cosas prácticas que me rodean.
B. ?
C. Los pensamientos y la imaginación.



Anexos



82. Cuando la gente me critica delante de otros, me siento muy descorazonado y herido.

- A. Casi nunca.
- B. ?
- C. A menudo.

83. Encuentro más interesante a la gente si sus puntos de vista son diferentes de los de la mayoría.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

84. Al tratar con la gente es mejor:

- A. "Poner todas las cartas sobre la mesa".
- B. ?.
- C. "No descubrir tu propio juego".

85. A veces me gustaría más ponerme en mi sitio que perdonar y olvidar.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

86. Me gusta la gente que:

- A. Es estable y tradicional en sus intereses.
- B. ?.
- C. Reconsidera seriamente sus puntos de vista sobre la vida.

87. A veces me siento demasiado responsable sobre cosas que suceden a mi alrededor.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.



Anexos



88. El trabajo que me es familiar y habitual:

- A. Me aburre y me da sueño.
- B. ?
- C. Me da seguridad y confianza.

89. Logro terminar las cosas mejor cuando trabajo solo que cuando lo hago en equipo.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

90. Normalmente no me importa si mi habitación está desordenada.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

91. Me resulta fácil ser paciente, aun cuando alguien es lento para comprender lo que estoy explicándole.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso, me cuesta ser paciente

92. Me gusta unirme a otros que van a hacer algo juntos, como ir a un museo o de excursión.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

93. Soy algo perfeccionista y me gusta que las cosas se hagan bien.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.



Anexos



- 94. Cuando tengo que hacer una larga cola por algún motivo, no me pongo tan intranquilo y nervioso como la mayoría.**
- A. Verdadero, no me pongo.
 - B. ?
 - C. Falso, me pongo intranquilo.
- 95. La gente me trata menos razonablemente de lo que merecen mis buenas intenciones.**
- A. A veces.
 - B. ?
 - C. Nunca.
- 96. Me lo paso bien con gente que muestra abiertamente sus emociones.**
- A. Verdadero.
 - B. ?
 - C. Falso.
- 97. No dejo que me depriman pequeñas cosas.**
- A. Verdadero.
 - B. ?
 - C. Falso.
- 98. Si pudiera ayudar en el desarrollo de un invento útil, preferiría encargarme de:**
- A. Investigarlo en el laboratorio.
 - B. ?
 - C. Mostrar a las personas su utilización.
- 99. Si ser cortés y amable no da resultado, puedo ser rudo y astuto cuando sea necesario.**
- A. Verdadero.
 - B. ?
 - C. Falso.



Anexos



100. Me gusta ir a menudo a espectáculos y diversiones.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

101. Me siento insatisfecho conmigo mismo.

- A. A veces.
- B. ?
- C. Raras veces.

102. Si nos perdiéramos en una ciudad y los amigos no estuvieran de acuerdo conmigo en el camino a seguir:

- A. No protestaría y les seguiría.
- B. ?
- C. Les haría saber que yo creía que mi camino era mejor.

103. La gente me considera una persona animada y sin preocupaciones.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

104. Si el banco se descuidara y no me cobrara algo que debiera, creo que:

- A. Lo indicaría y lo pagaría.
- B. ?
- C. Yo no tengo por qué decírselo.

105. Siempre tengo que estar luchando contra mi timidez.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

106. Los profesores, sacerdotes y otras personas emplean mucho tiempo intentando impedirnos hacer lo que deseamos.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.



Anexos



107. Cuando estoy con un grupo, normalmente me siento, escucho y dejo que los demás lleven el peso de la conversación.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

108. Normalmente aprecio más la belleza de un poema que una excelente estrategia en un deporte.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

109. Si uno es franco y abierto, los demás intentan aprovecharse de él.

- A. Casi nunca.
- B. ?
- C. A menudo.

110. Siempre me interesan las cosas mecánicas y soy bastante bueno para arreglarlas.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

111. A veces estoy tan enfrascado en mis pensamientos que, a no ser que salga de ellos, pierdo toda la noción del tiempo y desorden o no encuentro mis cosas.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

112. Parece como si no pudiera confiar en más de la mitad de la gente que voy conociendo.

- A. Verdadero, no se puede confiar en ella.
- B. ?
- C. Falso, se puede confiar en ella.



Anexos



113. Normalmente descubro que conozco a los demás mejor que ellos me conocen a mí.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

114. A menudo los demás dicen que mis ideas son realistas y prácticas.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

115. Si creo que lo merecen, hago agudas y sarcásticas observaciones a los demás.

- A. A veces.
- B. ?
- C. Nunca.

116. A veces me siento como si hubiera hecho algo malo, aunque realmente no lo haya hecho.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

117. Me resulta fácil hablar sobre mi vida, incluso sobre aspectos que otros considerarían muy personales.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

118. Me gusta diseñar modos por los que el mundo pudiera cambiar y mejorar.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.



Anexos



119. Tiendo a ser muy sensible y preocuparme mucho acerca de algo que he hecho.

- A. Casi nunca.
- B. ?
- C. A menudo.

120. En el periódico que acostumbro a hojear me intereso más por:

- A. Los artículos sobre los problemas sociales.
- B. ?
- C. Todas las noticias locales.

121. Preferiría emplear una tarde libre en:

- A. Leer o trabajar en solitario en un proyecto.
- B. ?
- C. Hacer alguna tarea con los amigos.

122. Cuando hay algo molesto que hacer, prefiero:

- A. Dejarlo a un lado hasta que no haya más remedio que hacerlo.
- B. ?
- C. Comenzar a hacerlo de inmediato.

123. Prefiero tomar la comida de mediodía:

- A. Con un grupo de gente.
- B. ?
- C. En solitario.

124. Soy paciente con las personas, incluso cuando no son corteses y consideradas con mis sentimientos.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.



Anexos



125. Cuando hago algo, normalmente me tomo tiempo para pensar antes en todo lo que necesito para la tarea.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

126. Me siento molesto cuando la gente emplea mucho tiempo para explicar algo.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

127. Mis amigos probablemente me describen como una persona:

- A. Cálida y amigable.
- B. ?
- C. Formal y objetiva.

128. Cuando algo me perturba, normalmente me olvido pronto de ella.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

129. Como afición agradable prefiero:

- A. Hacer o reparar algo.
- B. ?
- C. Trabajar en grupo en una tarea comunitaria.

130. Creo que debo reclamar si en el restaurante recibo mal servicio o alimentos deficientes.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.



Anexos



131. Tengo más cambios de humor que la mayoría de las personas que conozco.

- A. Normalmente verdadero.
- B. ?
- C. Normalmente falso.

132. Cuando los demás no ven las cosas como las veo yo, normalmente logro convencerlos.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

133. Creo que ser libre para hacer lo que desee es más importante que tener buenos modales y respetar las normas.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

134. Me encanta hacer reír a la gente con historias ingeniosas.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

135. Me considero una persona socialmente muy atrevida y comunicativa.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

136. Si una persona es lo suficientemente lista para eludir las normas sin que parezca.

- A. Podría incumplirlas si tiene razones especiales para ello.
- B. ?
- C. Debería seguirlas a pesar de todo.



137. Cuando me uno a un nuevo grupo, normalmente encajo pronto.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

138. Prefiero leer historias rudas o de acción realista más que novelas sentimentales e imaginativas.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

139. Sospecho que la persona que se muestra abiertamente amigable conmigo pueda ser desleal cuando yo no esté delante.

- A. Casi nunca.
- B. ?
- C. A menudo.

140. Cuando era niño empleaba la mayor parte de mi tiempo en:

- A. Hacer o construir algo.
- B. ?
- C. Leer o imaginar cosas ideales.

141. Muchas personas son demasiado quisquillosas y sensibles, y por su propio bien deberían “endurecerse”.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

142. Me muestro tan interesado en pensar en las ideas que a veces paso por alto los detalles prácticos.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.



Anexos



143. Si alguien me hace una pregunta demasiado personal intento cuidadosamente evitar contestarla.

- A. Normalmente verdadero.
- B. ?
- C. Normalmente falso.

144. Cuando me piden hacer una tarea voluntaria digo que estoy demasiado ocupado:

- A. A veces.
- B. ?
- C. Raras veces.

145. Mis amigos me consideran una persona algo abstraída y no siempre práctica.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

146. Me siento muy abatido cuando la gente me critica en un grupo.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

147. Les surgen más problemas a quienes:

- A. Se cuestionan o cambian métodos que ya no son satisfactorios.
- B. ?
- C. Descartan enfoques nuevos o prometedores.

148. Soy muy cuidadoso cuando se trata de elegir a alguien con quien "abrirme" francamente.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.



Anexos



149. Me gusta más intentar nuevos modos de hacer las cosas que seguir caminos ya conocidos.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

150. Los demás dicen que suelo ser demasiado crítico conmigo mismo.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

151. Generalmente me gusta más una comida si contiene alimentos familiares y cotidianos que si contiene alimentos poco corrientes.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

152. Puede pasar fácilmente una mañana entera sin tener necesidad de hablar con alguien.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

153. Deseo ayudar a las personas.

- A. Siempre.
- B. ?
- C. A veces.

154. Yo creo que:

- A. Algunos trabajos no deberían ser hechos tan cuidadosamente como otros.
- B. ?
- C. Cualquier trabajo habría que hacerlo bien si es que se va a hacer.



Anexos



155. Me resulta difícil ser paciente cuando la gente me critica.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

156. Prefiero los momentos en que hay gente a mi alrededor.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

157. Cuando realizo una tarea no me encuentro satisfecho a no ser que ponga especial atención incluso a los pequeños detalles.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

158. Algunas veces me “sacan de quicio” de un modo insoportable pequeñas cosas, aunque reconozca que son triviales.

- A. Si.
- B. ?
- C. No.

159. Me gusta escuchar a la gente hablar de sus sentimientos personales que de otros temas.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

160. Hay ocasiones en que no me siento de humor para ver a nadie.

- A. Muy raras veces.
- B. ?
- C. Bastante a menudo.



Anexos



161. Me gustaría más ser consejero orientador que arquitecto.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

162. En mi vida cotidiana casi nunca me encuentro con problemas que no puedo afrontar.

- A. Verdadero, puedo afrontarlos fácilmente.
- B. ?
- C. Falso.

163. Cuando las personas hacen algo que me molesta, normalmente:

- A. No le doy importancia.
- B. ?
- C. Se lo digo.

164. Yo creo más en:

- A. Ser claramente serio en la vida cotidiana.
- B. ?
- C. Seguir siempre el dicho “diviértete y sé feliz”.

165. Me gusta que haya alguna competitividad en las cosas que hago.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

166. La mayoría de las normas se han hecho para no cumplirlas cuando haya buenas razones para ello.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.



Anexos



167. Me cuesta bastante hablar delante de un grupo numeroso de personas.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

168. Preferiría un hogar en el que:

- A. Se sigan normas estrictas de conducta.
- B. ?
- C. No haya muchas normas.

169. En las reuniones sociales suelo sentirme tímido e inseguro de mí mismo.

- A. Verdadero.
- B. ?
- C. Falso.

170. En la televisión prefiero:

- A. Un programa sobre nuevos inventos prácticos.
- B. ?
- C. Un concierto de un artista famoso.

Las cuestiones que vienen a continuación se diseñaron como ejercicios de resolución de problemas. En ellas hay una y solo una respuesta correcta. Si no está seguro de cuál es la correcta, elija la que crea mejor. Vea un ejemplo aquí debajo:

Ejemplo:

Toro es a “ternero” como caballo” es a:

Potro

Ternero

La contestación correcta es “potro”; es la cría del caballo como ternero, es la cría del toro.



Anexos



171. "Minuto" es a "hora" como "segundo" es a:

- A. Minuto.
- B. Milisegundo.
- C. Hora.

172. "Renacuajo" es a "rana" como "larva" es a:

- A. Araña.
- B. Gusano.
- C. Insecto.

173. "Jamón" es a "cerdo" como "chuleta" es a:

- A. Cordero.
- B. Pollo.
- C. Merluza.

174. "Hielo" es a "agua" como "roca" es a:

- A. Lava.
- B. Arena.
- C. Petróleo.

175. "Mejor" es a "pésimo" como "peor" es a:

- A. Malo.
- B. Santo.
- C. Óptimo.

176. ¿Cuál de las tres palabras indica algo diferente de las otras dos?

- A. Terminal.
- B. Estacional.
- C. Cíclico.

177. ¿Cuál de las tres palabras indica algo diferente de las otras dos?

- A. Gato.
- B. Cerca.
- C. Planeta.



Anexos



178. Lo opuesto de “correcto” es lo opuesto de:

- A. Bueno.
- B. Erróneo.
- C. Adecuado.

179. ¿Cuál de las tres palabras indica algo diferente de las otras dos?

- A. Probable.
- B. Eventual.
- C. Inseguro.

180. Lo opuesto de lo opuesto de “inexacto” es:

- A. Casual.
- B. Puntual.
- C. Incorrecto.

181. ¿Qué número debe seguir al final de estos? 1 – 4 – 9 – 16

- A. 20.
- B. 25.
- C. 32.

182. ¿Qué letra debe seguir al final de estas? A – B – D – G

- A. H.
- B. K.
- C. J.

183. ¿Qué letra debe seguir al final de estas? E – I – L ...

- A. M.
- B. N.
- C. O.

184. ¿Qué número debe seguir al final de estos? $1/12$ – $1/6$ – $1/3$ – $2/3$...

- A. $3/4$
- B. $4/3$.
- C. $3/2$.



Anexos



185. ¿Qué número debe seguir al final de estos? 1 2 0 3 -1.....

- A. 5.
- B. 4.
- C. 3.



Anexos



Formato del informe de resultados de test proyectivos

Informe de resultados de test proyectivos

I. Datos informativos:

Nombre completo:		
Lugar/fecha de nacimiento:		
Lugar/fecha de aplicación:		
Dirección:		
Correo electrónico:		
Edad:	Estado civil:	Nº. hijos:
Residencia:	Instrucción:	Ocupación:
Religión:	Nº. Teléfono:	Nº. Celular:

II. Ficha técnica de instrumentos aplicados

Test de frases incompletas de Sacks

Nombre
Autor y año
Constructo que evalúa
Tiempo de aplicación
Edades de aplicación
Forma de aplicación
Lugar de baremación y estandarización
Variables en las que subdividen los baremos
Tipo de uso

Test de la persona bajo la lluvia

Ficha técnica

Nombre
Autor y año
Constructo que evalúa
Tiempo de aplicación
Edades de aplicación
Forma de aplicación
Lugar de baremación y estandarización
Variables en las que subdividen los baremos
Tipo de uso



Anexos



Consentimiento informado

Consentimiento informado

Lugar y fecha: _____.

Yo _____ en calidad de persona evaluada autorizo al o la estudiante _____ para que realice la evaluación psicológica, con la finalidad de que realice sus prácticas en la asignatura Prácticum 2 de la carrera de Psicología de la Universidad Técnica Particular de Loja. Además, informo que no poseo ningún grado de consanguinidad con el evaluador.

Y autorizo, para que esta información sea utilizada para los fines educativos que me fueron informados. Así mismo, autorizo pueda realizar una memoria fotográfica sobre la mencionada actividad.

Firma del evaluado: _____.

CI: _____.



Anexos



Informe psicológico

I. Datos informativos:

Nombre completo:		
Lugar/fecha de nacimiento:		
Lugar/fecha de aplicación:		
Dirección:		
Correo electrónico:		
Edad:	Estado civil:	No. hijos:
Residencia:	Instrucción:	Ocupación:
Religión:	Nro. Teléfono:	Nro. Celular:

II. Motivo de consulta y descripción del problema (inicio, curso del problema y estado actual)

III. Breve historia biográfica

- Área Familiar
- Área Social (funcionamiento social actual)
- Área Académica /Laboral

IV. Historia Clínica (síntomatología clínica asociada a las circunstancias actuales y anteriores según paciente e historia de los tratamientos recibidos).

V. Resultados de evaluación psicológica:

- Información relevante obtenida mediante entrevista (información que no puede ser ingresada en los apartados anteriores será incluida en este bloque)
- Información obtenida con cuestionarios (resultados cuantitativos)



Anexos



Instrumentos	Resultados	Interpretación

- VI. Integración de resultados
- VII. Conclusiones diagnósticas y pronósticas (inferencia diagnóstica)
- VIII. Recomendaciones

Firma Estudiante UTPL

Nombres y Apellidos:

Nº Cédula:

Anexos



Test de frases incompletas de Sacks adultos

Test de frases incompletas de SACKS (adultos)

Nombre: _____ Fecha: _____

Edad: _____ Tiempo de inicio: _____ Tiempo de finalización: _____

Instrucciones: a continuación, hay 60 frases incompletas. Lea cada una y complétela con lo primero que venga a su mente. Trabaje tan a prisa como sea posible. En caso de que no pueda completar una, encierre el número correspondiente en un círculo y termine después.

- 1 Siento que mi padre raras veces me
- 2 Cuando tengo mala suerte
- 3 Siempre anhelé
- 4 Si yo estuviera a cargo
- 5 El futuro me parece
- 6 Las personas que están sobre mí
- 7 Sé que es tonto, pero tengo miedo de
- 8 Creo que un verdadero amigo
- 9 Cuando era niño (a)
- 10 Mi idea de mujer (hombre) perfecta (o)
- 11 Cuando veo a un hombre y a una mujer juntos
- 12 Comparando las demás familias, la mía
- 13 En las labores me llevo mejor con
- 14 Mi madre
- 15 Haría cualquier cosa por olvidar la vez que
- 16 Si mi padre tan solo
- 17 Siento que tengo habilidades para
- 18 Sería perfectamente feliz si
- 19 Si la gente trabajara para mí
- 20 Yo espero
- 21 En la escuela, mis maestros
- 22 La mayoría de mis amistades no saben que tengo miedo de
- 23 No me gusta
- 24 Antes
- 25 Pienso que la mayoría de los muchachos (a)
- 26 Yo creo que la vida matrimonial
- 27 Mi familia me trata como
- 28 Aquellos con los que trabajo



Anexos



29	Mi madre y yo
30	Mi más grande error fue
31	Desearía que mi padre
32	Mi mayor debilidad
33	Mi ambición secreta en la vida
34	La gente que trabaja para mí
35	Algún día yo
36	Cuando veo al jefe venir
37	Quisiera perder el miedo de
38	La gente que más me agrada
39	Si fuera joven otra vez
40	Creo que la mayoría de las mujeres (hombres)
41	Si tuviera relaciones sexuales
42	La mayoría de las familias que conozco
43	Me gusta trabajar con la gente que
44	Creo que la mayoría de las madres
45	Cuando era más joven me sentía culpable de
46	Siento que mi padre es
47	Cuando la suerte se vuelve en contra mía
48	Cuando doy órdenes, yo
49	Lo que más deseo en la vida es
50	Dentro de algún tiempo
51	La gente a quien yo considero mis superiores
52	Mis temores en ocasiones me obligan a
53	Cuando no estoy, mis amigos
54	Mi más vívido recuerdo de la infancia
55	Lo que menos me gusta de las mujeres (hombres)
56	Mi vida sexual
57	Cuando era niño (a)
58	La gente que trabaja conmigo, generalmente
59	Me agrada mi madre, pero
60	La peor cosa que he hecho



Anexos



Hoja de corrección SACKS

Instrucciones. Sobre la base de su juicio clínico, tomando en cuenta como factores respuestas inapropiadas, referencias, estereotipos y manifestaciones de conflicto, evalúa las respuestas al SSCT del sujeto en las 15 categorías listadas abajo, con base en la siguiente escala. 3 2. – Severamente alterado, aparenta requerir ayuda terapéutica en el manejo de los conflictos emocionales en esta área.

2. – Disturbio severo, tiene conflictos emocionales en esta área.

1. – Disturbio moderado.

0. – No hay alteración significativa en esta área.

X. – Incierto, no hay suficiente evidencia.

Área de adaptación familiar

Actitud hacia el padre (frases 1, 16, 31 y 46).	Puntaje:
Actitud hacia la madre (frases 14, 29, 44 y 59).	Puntaje:
Actitud hacia la unidad familiar (frases 12, 27, 42 y 57).	Puntaje:

Área sexual

Actitud hacia los hombres/las mujeres (frases 10, 25, 40 y 55).	Puntaje:
Actitud hacia las relaciones heterosexuales (frases 11, 26, 41 y 56).	Puntaje:

Área de relaciones interpersonales

Actitud hacia amigos y conocidos (frases 8, 23, 38 y 53).	Puntaje:
Actitud hacia colegas en el trabajo o escuela (frases 13, 28, 43 y 58).	Puntaje:
Actitud hacia superiores en el trabajo o escuela (frases 6, 21, 36 y 51).	Puntaje:
Actitud hacia los subordinados (frases 4, 19, 34 y 49).	Puntaje:



Anexos



Área de autoconcepto

Actitud hacia los temores (frases 7, 22, 37 y 52).	Puntaje:
Actitud hacia los sentimientos de culpa (frases 15, 30, 45 y 60).	Puntaje:
Actitud hacia las metas (frases 3, 18, 33 y 48).	Puntaje:
Actitud hacia las propias capacidades (frases 2, 17, 32 y 47).	Puntaje:
Actitud hacia el pasado (frases 9, 24, 39 y 54).	Puntaje:
Actitud hacia el futuro (frases 5, 20, 35 y 50).	Puntaje:

Interpretación: _____







Anexos



Formato de informe de entrevista semiestructurada

Informe de entrevista al tutor externo

I. Datos informativos de la Institución:

Nombre de institución: _____

Provincia: _____

Cantón: _____

Dirección: _____

Teléfono institucional _____

Correo electrónico: _____

Nombre del directivo: _____

II. Resultados de la entrevista semiestructurada

Nombre de la persona entrevistada: _____

Cargo: _____

III. Conclusiones

IV. Recomendaciones

V. Anexos

- Formato de entrevista semiestructurada aplicada
- 1 fotografía de la práctica.



Anexos



Formato plan de intervención primaria

Plan de intervención primaria

1. Título

Plan de intervención primaria para la prevención de (coloca la problemática) dirigido a ___ de ___ en la ciudad de.

Por ejemplo:

Plan de intervención primaria para la prevención de la depresión dirigido a personas adultas mayores que asisten a una Casa de Acogida Mis días Felices en la ciudad de Quito.

2. Primera fase:detección de necesidades

(Indicar las necesidades del centro o lugar donde será aplicado el plan).

2.1. Introducción

Elabore 1 página de introducción, en la que mencione las prevalencias, estadísticas y actualmente como se encuentra la problemática (puede escoger un solo tema de la siguiente lista: depresión, ansiedad, violencia, consumo de sustancias, estrés).

2.2. Justificación

En función a los estudios, debe justificar por qué es necesario implementar un programa de intervención. Argumentar por qué es importante diseñar el programa de intervención primaria. La finalidad de un proyecto es más bien una aspiración a solucionar un problema bastante general. Elabore una página.

Marco teórico

(Mínimo 4 páginas, máximo 6 páginas, evite emplear viñetas.

2.2.1. Definición de la problemática.

2.2.2. Definición de factores de riesgo en general.

2.2.3. Factores de riesgo de la problemática.

2.2.4. Definición de factores de protección en general.



Anexos



2.2.5. Factores de protección de la problemática.

2.2.6. Estrategias de afrontamiento sobre la problemática.

3. Segunda fase: proceso del programa de intervención primaria

3.1 Objetivos

3.0.7. Objetivo general

Redactar un objetivo general, mismo que debe iniciar con un verbo en infinitivo, redactarse de forma clara y responde a las siguientes preguntas: ¿qué se realiza?, ¿cómo?, ¿para qué? Ejemplo:

- Ejecutar el plan de intervención primaria sobre estrés laboral mediante actividades lúdicas.

3.0.8. Objetivos específicos

Redactar tres objetivos, específicos. Ejemplo:

- Psicoeducar sobre los factores de riesgo y protección para la prevención de la depresión en adolescentes.

3.2 Metodología

3.2.1 Beneficiarios

(Describir los beneficiarios directos e indirectos).

3.2.2 Microlocalización

El programa de intervención se llevará a cabo en _____ (**Nombre de institución donde usted realiza las prácticas, o nombre de la familia o del barrio, si es que usted está en tarea adaptada**), con la finalidad de lograr _____ (**objetivo de intervención**).

3.2.3. Operacionalización

Por cada objetivo específico usted debe proponer una actividad, es decir, en total son 4 actividades que va a desarrollar, por ejemplo un taller, charla, reunión, paseo, encuentro, etc.

Objetivo 1: _____



Anexos



Actividad	Objetivo de la actividad	N.º Participantes	Tiempo de aplicación	Recursos materiales	Lugar	Insumo para evaluar la actividad
-----------	--------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------	----------------------------------

Procedimiento de la actividad

Por ejemplo:

1. Saludo.
2. Dinámica la pelota juguetona.
3. Psicoeducación de los factores de riesgo utilizando la técnica lluvia de ideas.
4. Retroalimentación de los contenidos.
5. Dinámica de despedida.

3.2.4 Cronograma

Actividades	Abril	Mayo	Junio	Julio

3.2.5 Recursos

- Humanos.
- Técnicos.
- Materiales.
- Financiamiento (máximo 30 dólares).

3.3. Tercera fase: evaluación del programa de intervención primaria

3.1. Evaluación inicial

- Antes de aplicar el plan de intervención usted debe evaluar los conocimientos que poseen los usuarios acerca de la problemática.



Anexos



- Puede realizar una entrevista semiestructurada, una lista de cotejo, una ficha de observación o una encuesta máximo con 5 preguntas, de verdadero y falso, utilizando un lenguaje apropiado para los usuarios, de preferencia no utilizar términos técnicos.

Deben crear cuadros estadísticos o gráficos estadísticos, realizar una discusión y análisis de los resultados encontrados, utilizando las normas Apa 7.^a Edición. De esta manera en las tres evaluaciones.

Pueden presentar 1 solo gráfico estadístico, y debajo la descripción.

Ejemplo: encuesta inicial sobre consumo de sustancias

En la evaluación inicial, se formuló una encuesta pretalleres, elaborada con la herramienta del formulario en <https://docs.google.com/forms/u/1/> (el enlace de la encuesta es <https://forms.gle/PGSVGBx7BiwhbciQ8>) y se consideraron algunos aspectos, como el grado de conocimiento del tema, conciencia de la problemática y sus consecuencias a nivel de salud y qué tan importante es el tema propuesto a partir de la necesidad planteada. También se consideró en la encuesta si los sujetos desean ser parte de la solución o desean conocer cómo prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, ya sea para sí mismos o para la sociedad y grupo al que pertenecen.

Para la construcción del instrumento, se establecieron algunas variables sociodemográficas como la edad, estado civil, instrucción, etc. Todo esto relacionado con el tema a evaluar, ya que por ejemplo es importante verificar que los adultos de diferentes edades según investigaciones tienen mayor conciencia de los daños en la salud a mediano y a largo plazo (Oblitas Guadalupe, 2017). Por otro lado, me propuse evaluar la percepción de los participantes sobre algunos puntos básicos de la adicción, como por ejemplo las sustancias que consumen, ya sean legales o ilegales, si lo consideran un problema, ya sea social o personal. Asimismo, si han recibido capacitación y, por tanto, si están conscientes de las consecuencias, factores de riesgo, de protección y estrategias de afrontamiento. Además, cómo se enfrentarían a dicha problemática del consumo si un conocido lo hace, es decir, cómo actuarían en tales caos.

En definitiva, valoramos el conocimiento del tema, es decir, de las sustancias que consumen y conocen, de la problemática y sus consecuencias o factores relacionados como problemas de salud a partir de enfermedades



Anexos



no transmisibles, o de conducta sexual y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), siendo de vital importancia prevenir para evitar problemáticas mayores. Por último, es importante destacar la valoración del conocimiento de los sujetos, de la existencia de programas de prevención primaria.

Tabulación de las encuestas

A continuación, presento las tablas donde resumo los resultados del instrumento aplicado y el análisis de resultados.

Tabla 1

Variables Sociodemográficas: Encuesta Inicial aplicada a usuarios del Plan de Intervención Primaria sobre consumo de sustancias.

Edad	No.	Estado	No.	%	Nivel-	No.	%	Género	No.	%
		Civil			Instrucción					
27	1	Soltero	2	12,5	Bachiller	2	12,5	Masculino	6	37,7
29	1	Casado	8	50	Técnico	1	6,3	Femenino	9	56,3
35	1	Divorciado	2	12,5	Tercer Nivel	9	56,3	Prefiero no decirlo	0	0
39	1	Unión de Hecho	3	18,8	Cuarto Nivel	4	25	Ninguno	1	6,3
40	2	Viudo	1	6,3						
41	1									
42	1									
43	2									
45	2									
48	1									
56	1									
58	1									
64	1									
Total	16		16			16				

Nota. Se observan los datos sociodemográficos del grupo evaluado. Destacan las edades de 40, 43 y 45 años que son las que tienen más participantes.



Anexos



Las edades de la muestra seleccionada están entre 27 años y 64 años (el número de participantes son 16), por lo que creo que es un rango amplio, es así que observamos en las respuestas que son de carácter homogéneo en cuanto a algunas preocupaciones como los daños en la salud. El 43,8 % piensa que los daños de salud pueden darse a mediano plazo y el 37,5 % a corto plazo. Lo cual confirma que en las edades adultas la preocupación no incide tanto a corto plazo como se ha informado en la bibliografía especializada. Son los adolescentes, son los que piensan más a corto plazo según las fuentes consultadas. (Oblitas Guadalupe, 2017).

3.2 Evaluación intermedia

Es decir, debe seguir el mismo procedimiento que en la evaluación inicial, coloca una breve descripción, seguidamente coloca la tabulación de los resultados, o gráfico estadístico con normas Apa 7.^a Edición, debajo la descripción. Pero en esta fase, debe colocar 4 gráficos o tablas, de los resultados que obtuvieron después de ejecutar cada taller del plan de intervención. Al finalizar cada taller usted debe evaluar si los participantes aprendieron algo, si les gustó el taller, de lo aprendido que pueden implementar en su vida, etc. En total, 5 preguntas.

3.3 Evaluación final

Elabora una entrevista semiestructurada máximo con 5 preguntas que le debe aplicar al tutor externo, en la cual usted le pregunta sobre lo que opinaron los participantes, el impacto del plan de intervención, y lo que le pareció al tutor respecto a esta práctica. En este apartado usted coloca una descripción sobre las respuestas del tutor o tutora externa, al final en anexos debe colocar la fotografía de la entrevista, la cual debe ser firmada por el estudiante y el tutor externo. Si la entrevista es de manera virtual, usted coloca el enlace de la grabación en YouTube, puede colocar en modo privado, pero que el enlace tenga acceso mucho tiempo.

4. Conclusiones

Redacte tres conclusiones, las cuales van acorde a los objetivos del plan.

5. Recomendaciones

Redacte tres recomendaciones en función de las conclusiones.



Anexos



6. Bibliografía

En este apartado coloca la bibliografía de todo el plan de intervención, ya no por partes de acuerdo a las tareas, sino que las une a todas y crea una sola.

7. Anexos

1. Metodología para la ejecución de talleres: debe colocar el material que usted utilizó en el desarrollo de los talleres. Por ejemplo, las diapositivas, no colocar vínculos; fotografías de imágenes, infografías, etc.
2. Memoria fotográfica de la ejecución del plan de intervención: colocar 12 fotografías de la ejecución de cada taller del plan de intervención, es decir, 3 fotografías de cada taller, con normas Apa 7.ª Edición.
3. Memoria fotográfica de las encuestas aplicadas, evaluación inicial, recuerde colocar todas las encuestas.
4. Memoria fotográfica de las encuestas aplicadas, evaluación intermedia.
5. Memoria fotográfica de las encuestas aplicadas, evaluación final: coloca la fotografía de la entrevista semiestructurada de la evaluación final.

Ejemplo: colocar fotografía según APA 7.ª. Ed.

Fotografía 1



Nota. Realización de taller psicoeducativo dirigido a docentes.



Anexos



Planificación de talleres

I. Tema:

II. Objetivo general:

III. Objetivos específicos:

IV. Actividades:

(Estimado estudiante, por cada actividad que se pretenda realizar debe detallar los aspectos de la siguiente tabla)

Nombre de la actividad
Objetivo de la actividad
Tiempo de aplicación
Recursos humanos
Recursos materiales
Nro. de capacitadores
Desarrollo



Anexos



Formato de encuesta de satisfacción

Encuesta de satisfacción

Nombre de tutor externo: _____

Edad: _____ Nivel de Instrucción: _____

Ocupación: _____

La siguiente encuesta tiene por objetivo conocer su opinión acerca del programa de intervención denominado: _____
_____ (**Redactar el nombre del programa de intervención primaria**).

Por favor, conteste sinceramente y tenga en cuenta que esta información se utilizará únicamente para fines académicos. Considere que no existen respuestas buenas ni malas. **Marque con una (X) la respuesta que usted considera la más adecuada.**

Pregunta	Muy Malo	Malo	Bueno	Muy Bueno	Excelente
----------	-------------	------	-------	--------------	-----------

¿El tema de la propuesta del plan de promoción de salud mental Ud. considera que fue:

Usted considera que el tiempo y espacio físico (aulas, salón, auditorios, etc.); donde se desarrolló el plan de promoción han sido:

El desarrollo de las actividades y metodología, por parte del instructor/s fueron:

Pregunta	Muy Malo	Malo	Bueno	Muy Bueno	Excelente
----------	-------------	------	-------	--------------	-----------

Las actividades realizadas han ayudado a la problemática abordada:

Los recursos utilizados (trípticos, vídeos, etc.), por las personas, a cargo, le parecen adecuados.

Pregunta	Muy Malo	Malo	Bueno	Muy Bueno	Excelente
----------	-------------	------	-------	--------------	-----------

Califique su satisfacción general con el programa.

Califique el desempeño de la persona a cargo de la ejecución del programa.



Anexos



Sugerencia u observación: _____

Firma de tutor externo

Gracias por su colaboración.



Informe final de prácticas preprofesionales entorno laboral

Modalidad de estudios: _____

Facultad de ciencias sociales, educación y humanidades

Nombre de la carrera: psicología

Nombres completos del estudiante: _____

Fecha: _____ Nombre del tutor académico: _____

Nombre de la organización receptora : _____

Periodo académico: _____



Anexos



Índice

Detallar los apartados que incluye en informe.

1. Introducción

Incluir una breve descripción de lo que trata el informe. (Breve justificación de por qué realizaron las prácticas preprofesionales, metodología, resultados, al menos 700 palabras).

2. Desarrollo

Señalar las principales actividades que se realizaron, los resultados obtenidos y la importancia que estas actividades tienen para el desarrollo de las competencias establecidas para el nivel de las prácticas preprofesionales, y de qué manera esas competencias aportan al perfil de egreso de carrera.

Las actividades que se detallan en el presente informe deben guardar concordancia con la planificación presentada en el plan docente de la asignatura, mismas que responden a los resultados de aprendizaje declarados y al desarrollo de competencias que aportan al perfil de egreso del estudiante. Estas actividades deberán detallarse a través de la siguiente tabla:

Actividad	Fecha de inicio	Fecha fin
Semana 1		
Semana 2		
Semana 3		
Semana 4		
Semana 5		
Semana 6		
Semana 7		
Semana 8		
Semana 9		
Semana 10		
Semana 11		
Semana 12		
Semana 13		
Semana 14		
Semana 15		
Semana 16		



Anexos



3. Bibliografía

Solo si es necesaria para la elaboración del informe.

4. Apéndices

- Colocar los anexos utilizados en todo el plan docente.
- Historias clínicas.
- Informes de entrevistas psicológicas.
- Informes de entrevista al tutor externo.
- Informe de contextualización del centro de práctica.
- Test aplicados.
- Informe de plan de promoción de salud mental.
- Encuesta de satisfacción.
- Recursos digitales utilizados para los talleres (infografías, papelógrafos, PowerPoint, etc.).
- Anexos fotográficos, etc.

Firma:

(Nombres completos del estudiante).

Oficio de asignación.



Anexos



Documento de asignación al estudiante

Loja, (Fecha)

Sr./Sra./Srta.

(Nombres completos del estudiante)

Estudiante de (nombre de la carrera)

De mi consideración:

Por medio del presente me permito comunicar a usted que para el período académico (____), ha sido asignado(a) a (nombre organización receptora), bajo el convenio de Prácticas Pre-Profesionales, para que realice (número de horas) horas de práctica preprofesional.

Estas actividades se realizarán en coordinación con (nombre de tutor externo asignado por la organización receptora), tutor externo de la práctica preprofesional, y, (nombre del docente) tutor académico.

El tutor académico es el docente asignado a la asignatura y quien está a cargo de la planificación, seguimiento y evaluación de la práctica.

Particular que informo a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

(Nombre del director (a) de carrera)

Director de (nombre de la carrera)

Documento de aceptación de plaza.



Anexos



Documento de aceptación del estudiante

Loja, de junio del 2023

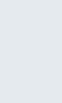
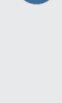
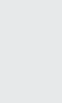
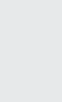
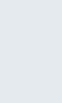
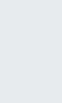
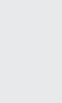
Director de la carrera de psicología

(Nombres completos del estudiante) portador de la cédula de identidad (**Número**), estudiante de (Nombre de la carrera)) de la Universidad Técnica Particular de Loja, acepto, realizar mis horas de prácticas preprofesionales en (nombre de la organización receptora) durante el periodo académico (...), y cumplir las siguientes responsabilidades:

- a. Realizar las actividades académicas y formativas en la organización receptora.
- b. Cumplir con los horarios establecidos y el número de horas para las prácticas preprofesionales, así como con las actividades asignadas.
- c. Mantener reserva y confidencialidad de la información que reciba, conozca o maneje dentro de la institución/empresa/dependencia a la que ha sido asignado.
- d. Cuidar los equipos e instrumentos que le sean entregados en los tiempos y plazos que permanezcan bajo su responsabilidad.
- e. Actuar respetando las disposiciones del Reglamento de Ética y Régimen Disciplinario y demás normativa de la UTPL, así como las normativas y disposiciones de la organización receptora durante el periodo de las prácticas preprofesionales.
- f. Presentar a la universidad el “informe final de prácticas preprofesionales” sobre las actividades realizadas, dentro de los plazos establecidos por la UTPL.
- g. Presentar documentos que respalden el cumplimiento de la práctica.
- h. Dar a conocer al tutor académico las incidencias que puedan afectar al normal desarrollo de las prácticas.

Firma del estudiante

(Nombres completos del estudiante)



Registro y control de asistencia

(Debe ser llenado por el estudiante y legalizado con la firma del tutor externo y con sello de la institución al lado de la firma).

Registro y control de asistencia

Director de carrera de: _____

Registro y control de asistencia del estudiante: _____

Gestión productiva/prácticum: _____

Periodo académico ordinario:

Institución:	Escribir el nombre completo.
Dependencia:	Escribir el nombre del departamento, laboratorio o dependencia en la que realiza las actividades.
Tutor externo del lugar de práctica:	Escribir los nombres y apellidos completos y el cargo.
Estudiante:	Escribir los nombres y apellidos completos.



Anexos



	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Fecha						

Hora de entrada

Hora de salida

Firma del estudiante

Actividades

realizadas:

Observaciones:

Fecha

Hora de entrada

Hora de salida

Firma del estudiante

Actividades

realizadas:

Observaciones:

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Fecha						

Hora de entrada

Hora de salida

Firma del estudiante

Actividades

realizadas:

Observaciones

Fecha

Hora de entrada

Hora de salida

Firma del estudiante

Actividades

realizadas:

Observaciones

f) _____

Nombre completo del tutor externo

(Incluir el sello de la institución/dependencia).



Anexos



Certificación de la organización receptora

Incluir logo de la empresa

Ciudad, fecha

(nombres completos de quien suscribe el documento)

(cargo de quien suscribe el documento)

(nombre de organización receptora/empresa).

Certifico

Que el/la Sr./Sra./Srta. (nombres completos del estudiante), portador de la cédula de identidad (**Número**), estudiante (nombre de carrera) de la Universidad Técnica Particular de Loja, realizó sus prácticas preprofesionales en (nombre de la organización receptora) en el Departamento de (nombre de dependencia/área), desde el (**día**) de (**mes**) **del (año)** hasta el (**día**) de (**mes**) **del (año)**, cumpliendo **96 horas** de prácticas preprofesionales.

Que El/la Sr./Srta. estudiante en mención ha demostrado ser responsable en el cumplimiento de las tareas encomendadas para su práctica preprofesional.

Esto es todo cuanto puedo manifestar en honor a la verdad, pudiendo el suscrito hacer uso de este documento como estime conveniente.

Atentamente,

Nombres completos

Cargo

Correo electrónico

Teléfono de contacto

Sello de la organización receptora

***Nota:** este documento puede ser firmado por el representante legal o jefe de recursos humanos de la organización receptora.



Anexos



Rúbrica de evaluación del tutor externo

Rúbrica de evaluación de desempeño

Datos del estudiante:			
Apellidos y nombres			
Periodo académico			
Fecha de inicio de la práctica	dd/mm/aaaa	Fecha de fin de la práctica	dd/mm/aaaa
Datos de la empresa/institución:			
Nombre de la empresa/institución			
Dependencia donde se realizó la práctica			
Nombre del tutor externo			

A = Sobresaliente (4 puntos) B = Bien (3 puntos)

C = Suficiente (2 puntos) D = Deficiente (1 punto)

Competencias genéricas	Evaluación				Puntaje
	A	B	C	D	
Expresión oral y escrita.					
Participación y trabajo en equipo.					
Plantea y cumple sus objetivos.					
Total					
Competencias profesionales	Evaluación				Puntaje
	A	B	C	D	
Aplica teorías y conceptos en la empresa en donde desarrolla sus prácticas o pasantías.					
Aporta criterios técnicos en los procedimientos que desarrolla.					
Demuestra ser organizado.					
Planea las actividades a desarrollar.					
Cumple con la carga de trabajo asignada en el tiempo indicado.					
Ejecuta el trabajo con eficiencia, eficacia, acorde con las necesidades de la empresa o institución.					
Entrega oportunamente informes e información solicitada.					
Total					



Anexos



Competencias sociales					Puntaje
	A	B	C	D	
Tiene facilidad para adaptarse a las políticas de la empresa o institución.					
Socializa con los equipos de trabajo y personal de la empresa o institución.					
Es amable, confiable y tiene sentido de pertenencia.					
Solicita información antes de ejecutar actividades con su superior o compañeros de trabajo.					

					Total
Competencias actitudinales					Puntaje
	A	B	C	D	
Demuestra confianza en sí mismo.					
Admite con profesionalismo los éxitos y fracasos derivados de su labor y decisiones.					
Tiene facilidad para asumir la rotación de cargos según las circunstancias.					
Dedica el esfuerzo necesario en la ejecución de una tarea hasta haberla completado satisfactoriamente.					
Maneja con integridad el cumplimiento del horario de trabajo asignado por la empresa o institución.					
					Total
					Puntaje total
					Calificación

Sugerencias adicionales:

* De forma opcional se puede incluir sugerencias sobre las prácticas, que se consideren como aporte para la mejora de la carrera o la universidad.

Fecha

Firma del estudiante

Firma del tutor académico

Nombre del estudiante

Nombre de tutor académico



Anexos



Rúbrica y tabla de calificación, aplica para todas las carreras de UTPL

Puntaje	Calificación	Puntaje	Calificación	Puntaje	Calificación	Puntaje	Calificación
76	6	56	4,42	36	2,84	16	1,26
75	5,92	55	4,34	35	2,76	15	1,18
74	5,84	54	4,26	34	2,68	14	1,10
73	5,76	53	4,18	33	2,60	13	1,03
72	5,68	52	4,10	32	2,53	12	0,95
71	5,60	51	4,03	31	2,45	11	0,87
70	5,53	50	3,95	30	2,37	10	0,83
69	5,45	49	3,87	29	2,29	9	0,71
68	5,37	48	3,79	28	2,21	8	0,63
67	5,29	47	3,71	27	2,13	7	0,58
66	5,21	46	3,63	26	2,05	6	0,47
65	5,13	45	3,55	25	1,97	5	0,39
64	5,05	44	3,47	24	1,89	4	0,33
63	4,97	43	3,39	23	1,81		
62	4,89	42	3,31	22	1,74		
61	4,81	41	3,24	21	1,66		
60	4,74	40	3,16	20	1,58		
59	4,66	39	3,08	19	1,5		
58	4,58	38	3	18	1,42		
57	4,5	37	2,92	17	1,34		



Anexos

